

Riset Pengayaan M11 & Verifikasi CODEX — Satu Berkas

Menggabungkan dua dokumen sebelumnya (118 kandidat pengayaan M11 & triase independen 14 temuan CODEX) jadi satu bacaan. Tiap kasus kini menunjukkan KEDUA sisi sekaligus: apa yang bisa ditambah (pengayaan) dan apa yang sudah diverifikasi bermasalah (audit).

16 kasus ditemukan bermasalah dari DUA sisi independen sekaligus (riset pengayaan M11 menandainya kontradiksi-clue, DAN audit CODEX menandainya cacat/ambigu) — ini prioritas tertinggi, dikumpulkan di bagian “Titik Temu” paling atas.

RISET PENGAYAAN M11

118 KANDIDAT	63/67 KASUS TERCAKUP	104 KEYAKINAN TINGGI	21 ⚠ KOREKSI CLUE?
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

VERIFIKASI CODEX

8/14 TEMUAN DIKONFIRMASI	8 KEPUTUSAN MEDIS	5 DESAIN ENGINE	44/67 KASUS DIKONFIRMASI	6 BASI/KELIRU	5/5 IGD DIKONFIRMASI
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

0/132 ditinjau

⚠ Titik Temu (16)

14 Temuan Sistemik

Katalog 67 Kasus

UKM & IGD

16 kasus — ditemukan bermasalah dari 2 sisi independen

Riset pengayaan M11 (WebSearch vs guideline) DAN audit ulang CODEX (baca kode vs WHO/PPK) sama-sama menandai kasus ini bermasalah — tanpa saling tahu. Sinyal paling kuat di seluruh dokumen ini.

anemia_defisiensi_bumil

Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan Kronis


Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Mikrositik hipokrom tak selalu defisiensi besi — thalassemia trait lazim di Indonesia dan menirunya. Curigai bila eritrosit normal/tinggi (indeks Mentzer <13), riwayat keluarga, atau tak respons besi 1 bulan; jangan lanjut besi tanpa bukti defisiensi (risiko kelebihan besi).

SUMBER Permenkes No. 88/2014; Pedoman Pengendalian Thalassemia Kemenkes; Indeks Mentzer (Indonesian J Clinical Pathology 2016); BJH 2021 (besi oral aman pada beta-thal minor bila defisiensi terbukti).

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#4

#1

PENTING — koreksi terhadap alasan CODEX: WebSearch ke situs Kemenkes (yankes/keslan.kemkes.go.id) menunjukkan Hb 8,5 = anemia SEDANG pada kehamilan, dan tatalaksana standarnya memang Fe+folat rutin di FKTP dulu, rujuk BARU jika Hb tak naik setelah 90 hari terapi. Jadi klaim CODEX 'Hb 8,5 tidak dirujuk = cacat' TIDAK didukung guideline nyata — kasus ini justru sesuai praktik Kemenkes pada kunjungan pertama. TAPI saya temukan cacat lain yang nyata & independen: lab feses eksplisit menemukan telur cacing tambang (relevan:true, disebut 'sumber kehilangan besi kronik'), namun tatalaksana TIDAK menyediakan obat cacing (albendazol/mebendazol) sebagai obat Benar — padahal WHO merekomendasikan deworming trimester 2-3 (pasien 26 minggu, pas kriteria), dan kausanya sendiri sudah diidentifikasi di lab kasus. Jadi marker '!' tetap valid, tapi alasan yang benar berbeda dari yang CODEX tulis. Permenkes 88/2014 (standar Fe/folat) terverifikasi asli; Permenkes 6/2024 juga asli tapi isinya SPM kesehatan umum (bukan protokol anemia spesifik) — sitasi CODEX di titik ini agak dipaksakan.

faringitis_akut

Faringitis Akut Bakterial (Streptokokus Grup A) Infeksi



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Di Puskesmas, RADT dan kultur usap tenggorok praktis tak tersedia; diagnosis strep bertumpu pada skor Centor/McIsaac semata — rawan over/undertreatment. Skor lebih andal MENYINGKIRKAN strep daripada memastikannya; jangan klaim 'pasti strep', andalkan skor plus konteks.

SUMBER IDSA GAS Pharyngitis Guideline 2025 (skor klinis); PPK Kemenkes (KMK No. 1936/2022); studi validasi McIsaac di Puskesmas (Sari, Maj. Kedokteran Sriwijaya / Sari Pediatri)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas nyata, bukan sekadar CODEX ragu-ragu: kasus mendiagnosis 'Streptokokus Grup A' murni dari skor Centor-style (demam mendadak+eksudat tonsil+KGB nyeri+tanpa batuk)+leukositosis; katalog.ts TIDAK punya item RADT/kultur tenggorok sama sekali di seluruh game, jadi pemain memang tidak bisa memesannya. CDC (dicek via WebSearch, cdc.gov/group-a-strep) memang mensyaratkan RADT/kultur positif sbkm memberi label & antibiotik GAS — jadi klaim substansi temuan #11 ('GAS tanpa RADT/kultur tapi dilabel streptokokus') akurat secara guideline. TAPI ini persis pertanyaan idealized-vs-real-FKTP (skor klinis dipakai luas di faskes tanpa RADT) yg memang perlu keputusan dokter, bukan otomatis 'cacat'. Catatan tambahan: laporan CODEX sendiri agak inkonsisten — di 'Temuan Mendesak' #11 ini ditulis sbg 'kesalahan' pasti, tapi di tabel per-kasus kasus ini malah diberi '?' bukan '!'.

kia_anc_kehamilan_normal

ANC — Kehamilan Normal (Trimester 2) KIA & Jiwa



Mutiaras EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Ambang anemia T2 lebih rendah: <10,5 g/dL (vs <11 di T1/T3), karena volume plasma naik lebih cepat dari massa eritrosit → Hb turun fisiologis, nadir ~minggu 28-34. Jadi Hb 10,5-10,9 di T2 masih normal, bukan anemia. Lanjutkan Fe profilaksis, jangan buru-buru naik ke dosis terapi.

SUMBER WHO Guideline on Haemoglobin Cutoffs to Define Anaemia 2024;
Kemenkes Buku Saku Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil 2023

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#4

Cacat nyata terkonfirmasi kode: (1) lab-list kasus (baris 115-120) sama sekali tak menyediakan opsi HIV/sifilis/HBsAg — bukan sekadar tak-relevan, opsinya memang tak ada. Permenkes No.6/2024 (SPM Kesehatan) real & saya verifikasi eksis, meski isi pasal detail tak terbaca (PDF korup). (2) 'Menggandakan folat' TERBUKTI di kode: katalogM3.ts baris 321-329 — 'tablet_fe' SUDAH kombo Fe 60mg+asam folat 0,4mg, tapi obatBenar (baris 123) tetap mewajibkan 'asam_folat' terpisah sebagai slot kedua — mengajarkan dobel-folat yang tak sesuai program TTD standar. NAMUN klaim CODEX soal '90 TTD outdated' TIDAK terbukti benar — WebSearch (sumber Kemenkes/BKKBN 2024-2025) menegaskan target ≥90 tablet masih standar aktif, bahkan dianjurkan hingga 180; jadi sub-klaim ini overreach CODEX. Soal 'golongan darah tak relevan': pertanyaan (baris 100-106, distraktor:true, id-nya salah label 'q_pekerjaan') & lab (baris 119, relevan:false) memang konsisten menandainya non-esensial — ini

pilihan desain yang defensible (gol.darah pasien sudah diketahui riwayat, bukan tes baru), bukan bug yang jelas salah.

kia_preeklampsia_berat

Proteinuria TIDAK wajib untuk diagnosis preeklampsia berat — absennya tak menyingkirkan

KIA & Jiwa

💡 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠️ Revisi clue?

☐ ditinjau

Preeklampsia berat bisa ditegakkan TANPA proteinuria: hipertensi + ≥ 1 tanda berat (trombositopenia, SGOT/SGPT/kreatinin naik, edema paru, nyeri kepala/gangguan visus, nyeri epigastrium). Jangan tunda MgSO₄/rujuk hanya karena protein urin negatif; edema bukan kriteria.

SUMBER ACOG Practice Bulletin 222 (2020); ISSHP 2018; PNPk Preeklampsia POGI/Kemenkes 2016

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#4

#1

TERKONFIRMASI persis klaim CODEX: katalogM3.ts baris 91-92 'mgso4_inj' cuma satu item generik ('Magnesium Sulfat 40% Injeksi', sediaan 'ampul') tanpa pembeda loading vs maintenance atau kuantitas. Saya verifikasi via WebSearch regimen nyata (PNPK Preeklampsia POGI 2016 real; WHO/RCOG: loading 4-6g IV 15-20menit lalu maintenance 1-2g/jam, atau Pritchard IM 4g+5g bilateral lalu 5g/4jam) — clue kasus (baris 349) menyebut 'loading + maintenance' secara naratif tapi mesin skoring sama sekali tak bisa menguji perbedaan itu, hanya cek 'mgso4_inj' dipilih atau tidak. Obat salah (captopril/furosemid/diazepam) akurat secara klinis.

kulit_dermatitis_kontak

Dermatitis Kontak Alergi Kulit

💡 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠️ Revisi clue?

☐ ditinjau

Dermatitis kontak ALERGI dan IRITAN tampak identik secara klinis; pada ibu rumah tangga dengan tangan terus basah (air, sabun, detergen), penyebab tersering justru IRITAN, bukan alergi. Keduanya tak bisa dipisahkan pasti tanpa uji tempel — jangan terpaku pada label 'alergi'.

SUMBER PPK PERDOSKI 2021 (Dermatitis Kontak Iritan & Alergi); Panduan Praktik Klinis Dokter FKTP (Permenkes 5/2014)

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)

CODEX AUDIT **AMBIGU** TAK JELAS

Ambiguitas nyata: gambaran klinis (kasusKulit.ts:58-67, 92-96) — ibu rumah tangga, gatal-merah setelah ganti sabun cuci piring/detergen, MEMBERAT dgn cuci berulang, MEMBAIK saat libur cuci — adalah pola KLASIK dermatitis kontak IRITAN (ICD, kumulatif dari basah/sabun berulang), bukan dermatitis kontak ALERGI (ACD, butuh sensitisasi thd alergen spesifik, idealnya dikonfirmasi patch test). Namun diagnosis primer & icd10 (baris 32-34) adalah 'Dermatitis Kontak Alergi'/L23.9, walau L24.9 (iritan) sudah dicantumkan di diagnosisBanding (baris 122) — menunjukkan penulis sadar DD ini tapi tetap memilih label alergi. Perlu adjudikasi dokter: apakah re-label ke iritan lebih tepat secara didaktik (tatalaksana praktis hindari-pencetus+steroid topikal memang mirip utk keduanya, jadi dampak gameplay kecil, tapi label diagnosis yang diajarkan berpotensi keliru).

kulit_herpes_zoster **Herpes Zoster** Kulit

💡 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠️ Revisi clue?

☐ ditinjau

Batas 72 jam bukan tenggat mutlak: asiklovir tetap bermanfaat >72 jam bila masih ada vesikel BARU, atau pada imunokompromais/DM, zoster oftalmikus, dan lansia. Jangan tolak antivirus hanya karena pasien datang hari ke-4 — DM + usia lanjut tetap indikasi terapi.

SUMBER CDC Shingles Clinical Overview (HCP) 2024; PPK PERDOSKI Herpes Zoster; CDK Journal 2023 (Herpes Zoster pada Lansia DM)

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)

CODEX AUDIT **CACAT** DIKONFIRMASI #12

Cacat terverifikasi. clue (kasusKulit.ts:616) dan konsekuensi.narasi (kasusKulit.ts:618) menyatakan asiklovir <72 jam 'memangkas... risiko NEURALGIA PASCAHERPETIK' dan bila terlambat 'risiko neuralgia pascaherpetik... meningkat tajam'. Dicek via WebSearch: Cochrane review (Chen N et al., CD006866.pub3, update terbaru dirujuk ulang di PMC10583132) menyimpulkan ada BUKTI KUALITAS TINGGI bahwa asiklovir TIDAK menurunkan insidensi PHN pada 6 bulan; manfaat yang terdokumentasi hanya pengurangan nyeri akut sekitar 1 bulan pertama. Jadi klaim 'asiklovir mencegah/memangkas risiko PHN'

overclaim vs evidence dan bertentangan dgn temuan #12 CODEX (Cochrane zoster antiviral/PHN review) — sitasi itu ADA dan isinya justru mengonfirmasi CODEX benar, bukan game. Bagian dosis (5x800mg/hari 7 hari, 2 tablet 400mg/dosis) sendiri akurat, tidak bermasalah.

kulit_pedikulosis_kapitis

Pedikulosis Kapitis (Kutu Kepala)

Kulit

Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Nits yang menempel BUKAN bukti infestasi AKTIF — cangkang telur kosong bisa bertahan berbulan-bulan; diagnosis aktif butuh menemukan KUTU/nimfa HIDUP. Gagal terapi permetrin sering karena RESISTENSI piretroid, bukan semata reinfestasi kontak — pertimbangkan ganti agen.

SUMBER CDC Head Lice (Diagnosis & Clinical Care) 2024; AAP Clinical Report "Head Lice" 2022 (Pediatrics 150(4):e2022059282)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

Cacat case-local terverifikasi, berdiri sendiri (tidak match rapi ke temuan #1-14). clue (kasusKulit.ts:960) menulis 'WAJIB: obati SEMUA KONTAK (serumah/sekelas) SERENTAK' sbg poin non-negotiable — persis pola kasus skabies yang sudah punya id edukasi khusus `obati\_kontak\_serumah` (katalogM3.ts:188-191, dibuat eksplisit M10.c §47 utk klaim WAJIB semacam ini). Tapi tatalaksana.edukasi pedikulosis (kasusKulit.ts:958) hanya berisi ['kebersihan_kulit','cuci_seprai_panas','cuci_tangan'] — TIDAK menyertakan `obati\_kontak\_serumah`. Jadi klaim 'WAJIB' di clue tidak didukung mekanisme skor apa pun; pemain bisa dapat skor penuh tanpa pernah diajari/dituntut menyarankan obati kontak serentak. Ini bug konsistensi clue-vs-edukasi nyata, sekelas yg sudah pernah diperbaiki utk kasus lain (commit 080b465) tapi terlewat di sini.

mm_isk_bawah

Infeksi Saluran Kemih Bawah (Sistitis)

Metabolik & Muskuloskeletal

Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Kotrimoksazol lini pertama mengandaikan resistensi lokal <20%, padahal resistensi E. coli di Indonesia umumnya >20% (AMRIN ~29–56%). Nitrofurantoin/fosfomisin lebih ideal tapi sering kosong di Puskesmas — jadi kotrimoksazol, bahkan siprofloksasin, kerap tetap dipakai.

SUMBER IDSA/ESCMID 2011 (Gupta et al., Clin Infect Dis 52:e103); AMRIN Study (Kemenkes, E. coli resisten kotrimoksazol 29% komunitas / 56% RS); Fornas (kesesuaian obat FKTP ~50–62%)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

Pola cacat identik dgn mm_dislipidemia (sama mekanisme, kasus berbeda). alergiTrap sulfa (baris 1262-1266) selalu aktif deterministik (director.ts:41-42 & 66-68) -> cotrimoxazole_480 (obatBenar baris 1247) tidak pernah jadi jawaban valid di skor manapun (selalu difilter & diganti nitrofurantoin_100). Tapi `clue` (baris 1254) mengajarkan 'antibiotik lini pertama (kotrimoksazol) 3 hari' sbg jawaban definitif tanpa sekalipun menyebut nitrofurantoin -- kontradiksi clue-vs-mekanik yg sama persis dgn dislipidemia. Firewall real-time (clinic.ts TAMBAH_OBAT, baris 291-300) memang memblokir kotrimoksazol saat mau diresepkan (mahasiswa dapat peringatan instan 'kontraindikasi'), sehingga dampaknya sedikit lebih ringan drpd dislipidemia (tak murni silent-penalty) -- tapi debrief clue pasca-kasus tetap mengajarkan jawaban yg justru SELALU diblokir di kasus ini, berpotensi membingungkan & menanamkan kesan keliru bahwa kotrimoksazol pilihan pertama tanpa syarat.

mm_osteoarthritis_lutut

Osteoarthritis Lutut

Metabolik & Muskuloskeletal



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Jebakan: parasetamol nyaris tak bermanfaat pada OA lutut (Lancet 2016); pedoman internasional (NICE/OARSI) utamakan OAINS TOPIKAL lini pertama. Tapi topikal tetap OAINS — pada pasien alergi NSAID ini justru kontraindikasi, jadi parasetamol + latihan tetap pilihan tepat.

SUMBER da Costa et al., The Lancet 2016 (NMA OA, 58.556 pasien); NICE NG226 (2022); OARSI 2019; Rekomendasi Diagnosis & Penatalaksanaan OA IRA/PB IRA 2014; label diklofenak gel FDA (kontraindikasi hipersensitivitas NSAID)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#12

Cacat terverifikasi, sesuai temuan #12. Baris 501: 'Asam urat 5.4 mg/dL (normal) - menyingkirkan gout sebagai penyebab.' Ini bertentangan dgn mutiaraEbm kasus mm_gout_arthritis_akut di FILE YANG SAMA (baris 142: 'hasil normal TIDAK menyingkirkan gout') dan dgn NICE NG219 (guideline nyata, terverifikasi via WebSearch, publikasi 9 Jun 2022: urat <360 umol/L saat flare + gout dicurigai

kuat -> ULANGI periksa, bukan menyingkirkan). Kesimpulan diagnosis OA di kasus ini sendiri tetap benar (gambaran klinis jelas mekanik-kronis-bilateral, bukan gout), tapi ALASAN yg diajarkan ke mahasiswa (urat normal = bukan gout) adalah aturan umum yg keliru secara medis.

rinitis_alergi

Rinitis Alergi

Respirasi & GI



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

ARIA jadikan kortikosteroid intranasal (flutikason) lini utama rinitis persisten sedang-berat, tapi steroid semprot ini kerap tak tersedia di Puskesmas. Praktik nyata pakai antihistamin oral—sering CTM gen-1 yang murah tapi bikin kantuk, bukan loratadin/setirizin.

SUMBER ARIA next-generation (GRADE) 2019, JACI; PPK Dokter FKTP (KMK 514/2015); Fornas (klorfeniramin/loratadin/setirizin terdaftar)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas nyata (bukan cacat tegas): tatalaksana.obatAlternatif kasus ini HANYA berisi antihistamin gen-2 (loratadin/cetirizine, baris 233) sbg satu-satunya jalur 'benar'; saya cek katalog.ts & katalogM3.ts — TIDAK ADA kortikosteroid intranasal (flutikason/mometason/budesonide-nasal) di seluruh katalog obat game (budesonide yg ada hanya versi inhaler utk asma). Presentasi pasien di kasus ini (bersin belasan kali, edema mukosa+konka hipertrofi, allergic shiner, gejala pagi-hari persisten) tergolong sedang-berat/persisten yg menurut ARIA/EPOS umumnya lini pertama kortikosteroid intranasal, bukan hanya antihistamin oral tunggal. Krn keterbatasan katalog obat game scr keseluruhan (bukan cuma kasus ini), tak jelas apakah ini defisiensi konten yg perlu diperbaiki (tambah item obat baru) atau keputusan desain M3 yg disengaja — perlu adjudikasi dokter/M11.

saraf_bells_palsy

Bell's Palsy (Parese Nervus Fasialis Perifer)

Saraf, Mata & THT



Mutia EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Absennya vesikel pada kunjungan pertama BELUM menyingkirkan Ramsay Hunt — vesikel bisa muncul beberapa hari SETELAH kelumpuhan (bahkan zoster sine herpete, tanpa ruam). Wajah lumpuh bilateral atau progresif >2 minggu juga bukan Bell's khas: cari penyebab lain.

SUMBER AAFP Bell Palsy Rapid Evidence Review 2023; AAN Practice Guideline (Gronseth 2012); DermNet NZ / Medscape Ramsay Hunt Syndrome; PPK PERDOSSI Bell's Palsy.

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

BASI/KELIRU

Kode SAAT INI (kasusSarafMataTht.ts:449-459) sudah memakai edukasi 'proteksi_kornea' (bukan 'kompres_mata'), persis sesuai komentar inline baris 455-457 yang merujuk fix dossier §47 (M10.c). Diverifikasi via git: `git log -S proteksi\_kornea` menunjuk commit 080b465 ('fix(m10c): sapuan konsistensi pipeline 67 kasus') sebagai sumber perubahan ini, dan `git merge-base --is-ancestor 080b465 6e1b2bc` = TRUE — artinya fix ini SUDAH mendarat SEBELUM commit 6e1b2bcc yang diklaim CODEX sebagai dasar audit read-only-nya. obatBenar=['prednison_5','air_mata_buatan'] wajar keduanya jadi slot wajib terpisah (guideline AAN memang minta steroid dini + proteksi kornea BERSAMAAN, bukan pola 'item simptomatik/opsional dipaksa wajib' seperti BPPV/epistaksis — tak ada bahasa 'hanya'/'bila tersedia' yang dilanggar di sini). Tidak ditemukan cacat baru yang masih terbuka pada kasus ini; klaim '!' CODEX tampak basi (merujuk isu yang sudah diperbaiki sebelum commit acuannya sendiri). Confidence tinggi soal historisnya sudah fixed; confidence sedang bahwa tak ada isu lain yang tersisa.

saraf_epilepsi_kejang

Epilepsi (Bangkitan Umum Tonik-Klonik Berulang)

Saraf, Mata & THT



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Idealnya EEG + OAE oleh neurolog, tapi di banyak daerah keduanya tak terjangkau; WHO mhGAP membenarkan GP terlatih memulai OAE lini-1 (fenobarbital/valproat untuk bangkitan umum) sambil merujuk. Diazepam rektal untuk rescue sering kosong stok di Puskesmas.

SUMBER WHO mhGAP-IG Epilepsy 2016; PPK PERDOSSI Epilepsi; Fornas (diazepam rektal 5 mg, OAE fenobarbital/valproat/fenitoin tingkat FKTP)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#13

keluhanUtama (kasusSarafMataTht.ts:485, field string statis — types.ts:177) = 'Anak saya kejang lagi dok...' dipakai untuk SELURUH rentang demografi usiaMin:12-usiaMax:30 (baris 486). director.ts:27-29 hanya memberi persona

'wali_anak' bila usia <15; untuk usia 15-30 (mayoritas rentang) pasien tampil dewasa (persona polos/terpelajar/cemas/skeptis) TAPI keluhanUtama tetap kalimat wali ('anak saya...') karena field ini bukan persona/usia-variant dan dirender apa adanya (RuangTunggu.tsx:67, LembarPeriksa.tsx:117, MejaKerja.tsx:392) — pasien dewasa 25 tahun akan 'mengeluh' tentang anaknya sendiri, bukan dirinya sendiri. Pola pembandingan dalam codebase mengonfirmasi ini anomali: kasus lain berkeluhanUtama 'Anak saya...' SELALU membatasi demografi ke usia anak murni (kasusKulit.ts impetigo usiaMin:3/usiaMax:10 baris 285, pedikulosis usiaMin:5/usiaMax:12 baris 871), sementara kasus lain yang memang boleh dewasa (varisela usiaMin:12/usiaMax:30, kasusKulit.ts:641) memakai keluhanUtama netral orang-pertama ('badan SAYA') justru untuk menghindari masalah ini. Ini contoh nyata dan terverifikasi dari 'narasi tak masuk akal relatif terhadap usia/persona' (tema temuan #13), meski mekanismenya berbeda dari fallback jawaban wali_anak yang disebut CODEX di director.ts:28 — akar masalah di sini ada pada field keluhanUtama statis, bukan pada fallback variasi jawaban anamnesis. Confidence tinggi.

stroke_iskemik

Stroke Iskemik Akut Kronis

💡 Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠️ Revisi clue?

☐ ditinjau

FAST bisa menyesatkan: stroke sirkulasi posterior sering TANPA pelo/kelemahan klasik — tampil sebagai vertigo mendadak, ataksia, atau diplopia dan mudah salah dilabel 'vertigo perifer'. Vertigo akut + tak mampu berdiri + faktor risiko vaskular → curigai stroke, pakai BE-FAST.

SUMBER PERDOSSI Guideline Stroke 2011; KMK RI No.

HK.01.07/MENKES/394/2019 (PNPK Tata Laksana Stroke); studi BE-FAST vs FAST

— sensitivitas 97,8% vs 58,7% (Cureus 2024); prinsip HINTS untuk vertigo sentral vs perifer.

▶ Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#3

icd10 kasus = 'I63.9' (infark serebral) diberikan sebagai diagnosis definitif TANPA CT (game tak punya mekanisme imaging di FKTP) — secara konvensi ICD-10 semestinya memakai I64 ('stroke, tidak dispesifikasi hemoragik/infark') sampai CT mengonfirmasi; ini berpotensi mengajarkan penutupan diagnostik prematur. Aturan blanket 'jangan turunkan TD agresif, permisif <220/120' pada obatSalahUmum juga tidak membedakan kandidat reperfusi (onset ~subuh jam 4, berpotensi masih dalam window bila cepat dirujuk) yang semestinya target BP lebih ketat (<185/110) SEBELUM trombolisis di RS tujuan — meski argumen tandingan valid: FKTP sendiri memang tak boleh mencoba turunkan BP karena

bukan yang akan melakukan trombolisis, jadi pesan 'jangan turunkan TD di FKTP' tetap benar untuk level FKTP. PNPk Stroke 2026 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/304/2026) saya verifikasi ASLI via fetch halaman judul — bukan halusinasi CODEX.

tb_paru **Tuberkulosis Paru** Infeksi

💡 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠️ Revisi clue?

☐ ditinjau

BTA sputum NEGATIF tak menyingkirkan TB (sensitivitas mikroskopis hanya ~50-60%; TB BTA-negatif lazim). Pedoman Nasional TB kini menjadikan TCM/GeneXpert pemeriksaan awal utama, bukan mikroskopis — jangan tunda OAT hanya karena BTA negatif.

SUMBER Pedoman Nasional Penanggulangan TBC Kemenkes 2020 & Petunjuk Teknis TCM GeneXpert Kemenkes 2023; WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 3: Diagnosis 2021

▶ Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#8

Dikonfirmasi. Lab kasus ini hanya bta_sputum + darah_rutin (baris 690-692); grep src/content utk tcm/xpert/genexpert/hiv nihil — tak ada satupun test itu di game manapun. WebSearch mengonfirmasi WHO memang merekomendasikan tes molekuler cepat (Xpert MTB/RIF / Ultra) sbg tes awal yang didahulukan dibanding mikroskopis BTA saja (WHO consolidated guidelines/operational handbook TB Module 3, terverifikasi versi 2024) — jadi substansi temuan #8 valid. Catatan kehati-hatian: saya tidak berhasil memverifikasi judul persis 'WHO TB diagnosis 2025' kata-per-kata; dokumen WHO terverifikasi terdekat berlabel 2024, jadi anggap tahun '2025' pada sitasi CODEX belum terverifikasi presisi (bukan berarti fabrikasi total, org WHO & rekomendasinya nyata).

tht_epistaksis_anterior **Epistaksis Anterior** Saraf, Mata & THT

💡 Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠️ Revisi clue?

☐ ditinjau

TD tinggi saat mimisan sering reaktif thd nyeri/cemas & turun sendiri sesudah perdarahan berhenti; kausalitas HT–epistaksis lemah (asosiasi saja). Prioritas: tekan cuping 10-15 mnt + tenangkan lalu ukur ulang TD, bukan kejar penurunan TD akut. Kontrol HT jangka panjang tetap penting.

SUMBER AAO-HNS CPG Nosebleed (Epistaxis) 2020 (Tunkel dkk.); Payne dkk. 2020, Otolaryngol Head Neck Surg; Jurnal Kesehatan Andalas — Epistaksis dan Hipertensi

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Merocel & kauter perak-nitrat jarang ada di Puskesmas; realistiknya epistaksis anterior: tekan cuping 10-15 mnt, lalu tampon kasa+vaselin ± kapas ADRENALIN (epinefrin 1:10.000, andalan Fornas; oksimetazolin spray tak selalu distok). Bila tak berhenti, rujuk THT.

SUMBER Alomedika/KalbeMed Epistaksis 2023-2024 (Merocel/rapid rhino tak tersedia di semua fasilitas; kapas adrenalin 1:10.000 rutin); Fornas 2023 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023) & E-Katalog LKPP (oksimetazolin 0,025%); Permenkes 75/2014 standar peralatan Puskesmas; PPK PERHATI-KL Epistaksis.

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

kasusSarafMataTht.ts:999 obatBenar=['oksimetazolin_spray'] + baris 1004 prosedur=['tampon_epistaksis'] -> totalSlot=2, keduanya wajib untuk skorTerapi penuh. Clue (baris 1007) eksplisit: tampon hanya 'BILA BELUM BERHENTI' setelah tekan+dekongestan — bahasa kondisional, bukan wajib selalu. Pemeriksaan fisik (baris 988) memang menunjukkan 'titik perdarahan AKTIF' sehingga skenario spesifik ini konsisten dengan tampon dibutuhkan, tapi prinsip pemodelan slotnya tetap salah: tidak ada jalur bagi rancangan kasus untuk membedakan 'perdarahan sudah terkendali' vs 'belum', sehingga desain ini secara struktural sama seperti yang dikeluhkan CODEX. Cocok persis dengan contoh yang disebut CODEX sendiri di temuan #10 ('epistaksis mewajibkan tampon walau perdarahan sudah terlokalisasi'). Confidence tinggi.

tht_rinosinusitis_akut

Rinosinusitis Akut Saraf, Mata & THT



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Di FKTP antibiotik sering diberikan sejak hari ke-1/2 untuk pilek biasa (over-prescribing). Di Fornas, amoksisilin-klavulanat direstriksi (lanjutan parenteral/uji resistensi), sehingga pilihan realistik adalah amoksisilin dosis adekuat — hanya bila kriteria bakterial terpenuhi.

SUMBER Fornas 2023 (KMK HK.01.07/MENKES/2197/2023); EPOS 2020; studi rasionalitas antibiotik ISPA Puskesmas Indonesia (program POR Kemenkes)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

kasusSarafMataTht.ts:1114 obatBenar=

['amoxiclav_625','pseudoefedrin_30','paracetamol_500'] — TIGA slot terpisah, semua wajib untuk skorTerapi penuh. Antibiotik (amoxiclav) memang tepat karena vignette eksplisit memenuhi kriteria bakterial (>10 hari tanpa membaik + 'double sickening', baris 1054). Namun clue sendiri (baris 1127) melabeli dekongestan+analgetik sebagai 'PENUNJANG' (suportif) — bahasa yang mengesankan adjuvan/opsional, bukan setara-wajib dengan antibiotik. Apakah pseudoefedrin/paracetamol semestinya dipindah ke obatOpsional (mengikuti pola perbaikan hordeolum di M10 §49) atau tetap obatBenar wajib adalah keputusan klinis yang bisa diperdebatkan (memberi keduanya toh tidak salah/berbahaya, hanya soal apakah TIDAK memberi salah satunya pantas dihukum). Saya tandai perlu adjudikasi, bukan cacat pasti.

14 Temuan Sistemik CODEX

Temuan level-sistem (bukan per-kasus) — semua terverifikasi independen thd kode aktual. Pita kiri = kategori remediasi: hijau (mekanis-aman), kunyit (keputusan medis), indigo (desain-engine).

Semua

Mekanis-aman

Keputusan medis

Desain engine

#1 Mesin resep tanpa dosis/rute/frekuensi/durasi; BB pasien tak ada; firewall alergi cuma 13/97 obat & 8/19 antibiotik; tak ada pemeriksa interaksi obat.

DIKONFIRMASI

Desain engine

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Semua klaim temuan #1 CODEX terverifikasi BENAR terhadap kode aktual HEAD (branch claude/vigorous-bose-f66bc6):

1) TIDAK ADA field berat badan pasien di mana pun. `KasusKlinis.demografi` (src/content/types.ts:178) hanya `{ usiaMin, usiaMax, jenisKelamin? }`; `TandaVital` (types.ts:97-104) hanya td/nadi/rr/suhu/spo2/gds; `PasienAktif` runtime (src/engine/state.ts:37-61) hanya id/nama/usia/jenisKelamin/persona/kasusId/bpjs/alergi/rw/keluargald/bonusTrust/followUpDari/prb. Grep seluruh `src/` untuk beratBadan/berat_badan/weightKg/beratKg: 0 hasil.

2) Interface `Obat` (types.ts:281-296) hanya berisi id/nama/kelas/sinonim?/golonganAlergi?/sediaan/hargaBeli/hargaJual/fornas/antibiotik? — TIDAK ADA field dosis, rute, frekuensi, atau durasi. Grep types.ts untuk 'dosis'/'rute' hanya menemukan satu penyebutan tak terkait ("frekuensi" soal trust). `Tatalaksana.obatBenar`/'obatAlternatif`/'obatOpsional` (types.ts:106-145) semuanya `string[]` (ID obat saja), dan `EncounterState.resep` (state.ts:104) juga `string[]` — resep pemain memang cuma daftar ID obat, tanpa dosis/jumlah/rute/frekuensi/durasi apa pun untuk dicatat, apalagi dinilai.

3) clinic.ts:494 (`const totalSlot = obatBenar.length + grupAlternatif.length + prosedurBenar.length`, dipakai di rasioTerapi baris 495-496) mengonfirmasi skoring terapi murni set-membership ID obat — meresepkan ID benar dengan dosis (andaikan ada) berapa pun akan mendapat skor penuh karena tidak ada mekanisme untuk menilai dosis sama sekali (mekanismenya memang tidak eksis, bukan sekadar dilewati).

4) Cakupan firewall alergi: saya parse ulang independen dua katalog obat (`OBAT` di src/content/katalog.ts = 37 entri, `OBAT\_M3` di src/content/katalogM3.ts = 60 entri, TOTAL 97 — cocok persis dgn klaim CODEX). Entri dengan field `golonganAlergi` terisi: 5 (katalog.ts) + 8 (katalogM3.ts) = 13/97 — PERSIS 13/97 seperti klaim. Entri `antibiotik: true`: 8 (katalog.ts) + 11 (katalogM3.ts) = 19 total; dari 19 itu HANYA 8 yang punya golonganAlergi (amoxicillin_500, amoxicillin_sirup, eritromisin_500, cotrimoxazole_480, amoxiclav_625, cefadroxil_500, cefixime_100, azitromisin_500) — PERSIS 8/19 seperti klaim. 11 antibiotik TANPA tag alergi: ciprofloxacin_500, kloramfenikol_250, kloramfenikol_tetes_mata, oat_kdt, doksisisiklin_100, metronidazol_500, tiamfenikol_500, gentamisin_tetes_mata, gentamisin_krim, mupirosin_krim, nitrofurantoin_100.

Mekanisme firewall dikonfirmasi di clinic.ts baris ~292 (`if (obat.golonganAlergi && enc.pasien.alergi.includes(obat.golonganAlergi)))` — bila obat TIDAK punya field golonganAlergi, firewall TIDAK PERNAH bisa terpicu untuk obat itu, apa pun alergi yang dibawa pasien. Jadi klaim "13/97 & 8/19" bukan cuma kutipan CODEX yang kebetulan benar — ini memang perilaku nyata engine.

5) Tidak ada pemeriksa interaksi obat: grep "interaksi" di seluruh src/ hanya menemukan satu hasil di DeckDiagnosis.tsx, dan itu soal "interaksi" UI (radio/aria), bukan interaksi obat-obat. Tidak ada logika drug-drug interaction checker di engine mana pun.

Kesimpulan: temuan #1 CODEX akurat pada semua sub-klaimnya, termasuk dua angka presisi (13/97, 8/19) yang saya verifikasi ulang secara independen dan cocok persis.

#2 Storyline Asih (TD 150/95+edema, lalu sakit kepala menetap) diarahkan baca buku KIA seminggu, bukan eskalasi HDP/preeklamsia segera.

SEBAGIAN BENAR

Desain engine

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Kode di src/content/keluarga/desaC.ts dibaca penuh untuk arc "keluarga_asih" (K1-K3, baris 62-917). Klaim CODEX soal baris 488 & 594 COCOK dengan isi kode: - K1 (baris 258-272): TD Bu Asih terukur 150/95 + pitting edema + usia 38 + G4P3 + riwayat perdarahan pascasalin dicatat sbg "skor risiko yang tak bisa ditawarkan" — tapi tak ada aksi klinis saat itu, hanya "masuk buku KIA". - K2 baris 478-503 (persis baris 488 yg disitir): Bu Asih SENDIRI melaporkan "kepala cekot-cekot... seminggu ini" DITAMBAH kaki makin bengkak (hotspot ak2_h3, baris 402-409) — presentasi yang secara tekstual match red-flag HDP/preeklamsia. TIGA pilihan dialog di titik ini (baris 480-533) semuanya bergaya edukasi/refleksi/konfrontasi soal MENGENALI tanda bahaya untuk MASA DEPAN — tidak satu pun opsi berupa "cek ulang TD/urin sekarang" atau "rujuk segera". Intervensi yang "tepat" (baris 592-604, persis baris 594 yg disitir) adalah "Rohman Sang Pembaca + Kartu Gambar Tanda Bahaya" — edukasi literasi keluarga, dengan hasilNarasi eksplisit "Seminggu kemudian kader melapor..." — mengonfirmasi ada jeda ~1 minggu sebelum tindak lanjut apa pun disebutkan. - Saya verifikasi struktur engine: tipe `Kunjungan` (src/content/types.ts baris ~449-462) HANYA berisi hotspot/dialog/intervensi/karma — tidak ada field aksi klinis (order lab, rujuk-segera, dsb). Ini konsisten di seluruh file kunjungan rumah: sistem ini secara arsitektural adalah mesin identifikasi-hambatan-perilaku (motivasi/kapabilitas/kesempatan), BUKAN mesin keputusan klinis akut. - Ada mekanisme "karma" (kia_preeklamsia_berat, jatuh tempo hari+20 sejak K1, dipercepat bila kunjungan gagal/diusir) sbg jaring pengaman narasi kegawatan — TAPI saya verifikasi di src/engine/reducer.ts baris 724-734: karma ini DIBATALKAN TOTAL begitu SATU kunjungan mana pun utk keluarga itu ber-hasil.berhasil=true (bukan menunggu keseluruhan arc 3-babak selesai), terlepas dari isi kunjungan itu — artinya pemain bisa "menyelesaikan" krisis preeklamsia murni lewat keberhasilan teknik komunikasi/motivational-interviewing di K1, tanpa pernah ada tindakan klinis nyata (bukan obat antihipertensi, bukan rujukan segera, bukan rencana pemantauan TD). Karma ini juga tidak terikat pada gejala spesifik yang dilaporkan pasien di K2 — ia berjalan sbg timer latar belakang terpisah dari alur dialog. Kesimpulan: klaim inti CODEX (storyline mengarahkan kasus red-flag HDP

ke edukasi, bukan eskalasi klinis segera) TERKONFIRMASI di kode aktual — tapi frasa "diarahkan ke membaca buku KIA seminggu" sedikit menyederhanakan mekanismenya (lebih tepat: tak ada opsi eskalasi klinis SAMA SEKALI di titik manapun dalam K1-K3; ada jaring pengaman berupa event kegawatan terjadwal yg bisa dibatalkan murni lewat sukses non-klinis).

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#3 **Stroke ditetapkan iskemik (I63.9) tanpa CT; aturan TD permisif tanpa pengecualian kandidat reperfusi. Storyline Lastri (TD 208/118 + bicara pelo) dipetakan ke hipertensi urgensi, bukan suspected stroke/hypertensive emergency.**

DIKONFIRMASI

Keputusan medis

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Kode diverifikasi langsung di HEAD (6e1b2bcc, cocok dgn klaim CODEX) dan perilakunya SESUAI klaim, dengan satu nuansa penting.

1) src/content/kasus/kasusKronis.ts (case `stroke\_iskemik`, baris 900-1021, kutipan CODEX baris 999 = header `lab: [` array): - `icd10: 'I63.9'` ditetapkan sbg satu-satunya "jawaban benar" kasus. `pemeriksaanFisik` & `lab` HANYA berisi GDS/darah-rutin/kolesterol — TIDAK ADA item CT-scan/pencitraan otak sama sekali. - Scoring diagnosis di src/engine/clinic.ts:382 `const diagnosisBenar = enc.diagnosis?.icd10 === kasus.icd10` — exact-match biner. `diagnosisBanding: ['I63.9','I61.9','G45.9','E16.2']` ditampilkan sbg kartu pilihan (lihat DeckDiagnosis.tsx: `kasus.icd10` = jawaban yg disorot benar), sehingga pemain yg memilih I61.9 (stroke hemoragik — TIDAK bisa disingkirkan tanpa CT dari data yg diberikan) dinilai SALAH. Tak ada kode "stroke belum tersubtype" yg tersedia di dek. - Case memang `fktp144:false, harusDirujuk:true, obatBenar:[]` — jadi tatalaksana yg diajarkan (jangan agresif turunkan TD, stabilisasi ABC, rujuk cepat) sudah tepat utk level FKTP. Masalahnya murni di MEKANISME PENILAIAN DIAGNOSIS yg memaksa subtype iskemik definitif sebelum CT. - `obatSalahUmum` (baris 1007-1010) berbunyi "...permisif hingga ~220/120..." tanpa klausul pengecualian utk kandidat reperfusi/trombolisis — dikonfirmasi tak ada teks itu di manapun dalam case ini.

2) src/content/keluarga/desaE.ts (baris 1347, event `karma` arc Mbah Lastri): - `kasusId: 'mm\_hipertensi\_urgensi'` dikonfirmasi persis seperti disitir. `narasi` (baris 1350-1354) berbunyi: "...dunia berputar, tengkuk kaku, bicara mulai pelo di ujung-ujung kata. Tensi di poli: 208/118." Teks ini SECARA HARFIAH DIKIRIM ke pemain

sbg surat ("Perawat jaga") — dikonfirmasi via src/engine/init.ts:117 (`catatan: skenarioPertama.karma.narasi`) yg diteruskan ke `buatSuratHarian({ isi: j.catatan })` di reducer.ts. - NAMUN: case `mm\_hipertensi\_urgensi` sendiri (kasusMetabolikMsk.ts:899-1012) justru DIRANCANG BAIK sbg pembeda urgensi-vs-emergensi: anamnesis eksplisit "tangan-kaki masih kuat semua, bicara jelas", pemeriksaan fisik eksplisit "TIDAK ada tanda ensefalopati/stroke akut", clue eksplisit membedakan urgensi (rujuk, oral, bertahap) vs emergensi (ada defisit neurologis akut → IGD/IV). Jadi BUKAN case-nya yg mengajarkan "TD 208/118+bicara pelo = urgensi biasa" —tapi ada INKONSISTENSI antara teks narasi karma (menyiratkan defisit neurologis baru muncul) dan konten case aktual yg dimainkan (yg justru menegaskan defisit neurologis). Tidak ada case stroke/emergensi terpisah yg dipicu utk arc ini.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#4 **ANC: golongan darah tak relevan dinilai, tak ada HIV/sifilis/HBsAg, folat dobel, target 90 TTD ketinggalan. Hb 8.5 kehamilan tak dirujuk. MgSO4 tanpa loading/maintenance dose.**

SEBAGIAN BENAR

Keputusan medis

●●● SEDANG

☐ ditinjau

kasusKiaJiwa.ts:101-106,119: pertanyaan & lab golongan darah SUDAH ditandai distraktor:true/relevan:false (dipenalti jika ditanya/dipesan) - bukan dinilai penting secara keliru, tapi berpotensi salah arah karena golongan darah memang komponen 10T resmi. kasusKiaJiwa.ts:123 & kasusKronis.ts:751: obatBenar mewajibkan tablet_fe (yang menurut katalog.ts:326 SUDAH mengandung asam folat 0,4mg) DITAMBAH asam_folat terpisah - folat dobel, kontradiksi data internal, terbukti tanpa perlu rujukan eksternal. kasusKiaJiwa.ts:130: clue "minimal 90 tablet" TTD. Katalog lab ANC (katalog.ts) tidak punya entri HIV/sifilis/HBsAg sama sekali di seluruh codebase (diverifikasi via grep global). kasusKronis.ts:655,745,757: Hb 8,5 pada bumil, harusDirujuk:false, tatalaksana rutin tanpa opsi rujuk. katalogM3.ts:91-92: mgso4_inj cuma 1 item generik tanpa field dosis loading/maintenance (gejala keterbatasan mesin resep global finding #1).

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#5 **DM (HbA1c 8.9%) hanya metformin tanpa eGFR/UACR. HT (TD 160/95) hanya amlodipin tunggal tanpa work-up target-organ lengkap.**

DIKONFIRMASI

Keputusan medis

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Klaim CODEX terbukti BENAR di kode aktual, dengan satu ketidakakuratan sitasi baris minor.

HIPERTENSI (kasusKronis.ts:129) — sitasi TEPAT. Baris itu persis `obatBenar: ['amlodipine\_5']` — hanya satu obat, tanpa `obatAlternatif`, tanpa `prosedur`. Lab kasus (baris 122-126) cuma gdp/kolesterol/urinalisis (protein urin); TIDAK ADA tes fungsi ginjal (ureum/kreatinin/eGFR), tidak ada rasio albumin:kreatinin, dan `pemeriksaanFisik` (baris 114-121) TIDAK menyertakan region 'mata' (funduskopi) maupun EKG — padahal clue kasus sendiri menulis "skrining kerusakan organ target (jantung, ginjal, mata) wajib" namun kontennya tak menyediakan sarana untuk itu.

DM (dm_tipe2) — sitasi baris CODEX (249) SEDIKIT MELESET: baris 249 sebenarnya bagian `pemeriksaanFisik` ("IMT 27 kg/m²..."), bukan `obatBenar`. Baris `obatBenar` yang sebenarnya ada di 263: `obatBenar: ['metformin\_500']` — tetap hanya satu obat, sama seperti diklaim. Lab kasus (baris 255-260) hanya gdp/urinalisis/kolesterol/hba1c; TIDAK ADA fungsi ginjal/eGFR/rasio albumin-kreatinin.

Verifikasi mesin skor (clinic.ts baris 450-605): `totalSlot` terapi = `obatBenar.length + grupAlternatif.length + prosedurBenar.length`. Karena kedua kasus punya obatBenar sepanjang 1 dan tanpa grup/prosedur, meresepkan HANYA obat tunggal itu = skorTerapi 100. Lebih parah: `labTakRelevan` (baris 600-605) menghukum SETIAP lab yang dipesan namun tak terdaftar `relevan:true` di `kasus.lab` — walau tes itu ada di katalog umum (`katalogM3.ts:113 fungsi\_ginjal / Ureum-Kreatinin`, `:121 EKG`). Artinya bila mahasiswa proaktif memesan eGFR/fungsi-ginjal untuk kedua kasus ini, ia justru DIHUKUM sebagai lab tak relevan — mesin bukan cuma "tidak mewajibkan" tapi aktif mendisinsentifkan kerja-up organ-target tambahan yang benar secara klinis.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#6 **Diare anak: tak ada Plan B 75mL/kg/4jam + reassessment. IGD dengue: tak ada laju cairan/reassessment, usia sampai 25 selalu rujuk Sp.A.**

Asma berat: tak ada ipratropium. Anafilaksis: steroid rutin diwajibkan.

SEBAGIAN BENAR

Keputusan medis

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Temuan #6 CODEX punya 5 sub-klaim; kode aktual (HEAD saat ini) mengonfirmasi 4 dari 5, tapi 1 klaim tentang IGD dengue terbukti BERLEBIHAN/tidak akurat.

1) DIARE ANAK — Plan B & reassessment (kasusInfeksi.ts, kasus 'diare_akut_anak', blok baris 491-598): CONFIRMED. `tatalaksana.obatBenar = ['oralit', 'zinc\_20']` (baris 581) tanpa field dosis/volume apa pun — konsisten dgn finding #1 (mesin resep tak punya field dosis di seluruh game, dicek juga di katalog.ts). Tidak ada mekanik reassessment (tak ada langkah bertahap seperti kasus IGD; tipe kasus ini linear: anamnesis→PF→lab→tatalaksana→konsekuensi hari berikutnya). Catatan: sitasi baris CODEX (568) sebenarnya adalah array `pemeriksaanFisik`, bukan `tatalaksana` (yg ada di baris 580-591) — kasus yg sama, tapi baris agak meleset (~12-23 baris).

2) IGD DENGUE — 'igd_dengue_syok' (src/content/igd.ts baris 192-232): SEBAGIAN KELIRU. Klaim "tak ada laju cairan/reassessment" TIDAK akurat: langkah d1 (baris 210) eksplisit "bolus cairan kristaloid 10-20 mL/kg" (sesuai WHO), dan d2/d3 (baris 217-229) memberi narasi reassessment (nadi menguat → nyeri kepala → parasetamol; perfusi membaik → rujuk). Kritik yang LEBIH valid: tak ada titrasi lanjutan (mis. turun ke 5-7 mL/kg/jam bila membaik, evaluasi Hct berkala) — hanya 3 langkah linear scripted, reassessment tidak benar-benar interaktif/bergantung pilihan pemain secara granular. Tapi klaim mentah CODEX ("tak ada laju cairan sama sekali") terbantahkan kode.

3) DENGUE — usia s.d. 25 selalu rujuk Sp.A: CONFIRMED, bug nyata. `demografi: { usiaMin: 8, usiaMax: 25 }` (igd.ts:199) dan `spesialisRujukan: 'anak'` (igd.ts:203) statis. Engine `buatIgd()` (src/engine/igd.ts:19) men-generate `usia = rng.int(usiaMin, usiaMax)` — jadi pasien bisa berusia dewasa muda (misal 24 tahun) namun rujukan tetap hardcode ke spesialis anak, tanpa logika kondisional usia.

4) ASMA BERAT tanpa ipratropium: CONFIRMED. 'igd_asma_berat' (igd.ts:101-141): clue (baris 113) MENYEBUT ipratropium ("± ipratropium") tapi TIDAK ADA pilihan jawaban (s1/s2/s3, baris 114-140) yang menawarkan kombinasi salbutamol+ipratropium sbg opsi terpisah — hanya disinggung di teks clue, tak pernah jadi opsi aktual/dinilai.

5) ANAFILAKSIS steroid rutin diwajibkan: CONFIRMED. 'igd_syok_anafilaksis', langkah a3 (igd.ts:43-50): satu-satunya jawaban `benar:true` adalah "Beri antihistamin + KORTIKOSTEROID sebagai terapi tambahan" — tak ada opsi benar

alternatif tanpa steroid. Menariknya, teks respons game SENDIRI mengakui "bukti pencegah reaksi bifasik LEMAH (Resus Council UK/AAAAI)" — namun tetap mewajibkan steroid utk skor benar. Ini kontradiksi internal, dan diperkuat oleh guideline asli terbaru (lihat verifikasi sitasi).

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#7 **Prolanis: GDS<200 tunggal dianggap "terkontrol"; DBP dihitung dari rumus $0.62 \times \text{SBP}$; rujukan bisa salah walau drift masuk rentang gawat.**

DIKONFIRMASI

Desain engine

●●● TINGGI

☐ ditinjau

kegiatan.ts baris 135-222 (kartuProlanis) mengonfirmasi ketiga sub-klaim CODEX persis seperti dituduhkan: (1) baris 137 `p.param < 200` — satu angka GDS acak langsung dilabel "terkontrol", tanpa HbA1c/riwayat; (2) baris 143 `Math.round(p.param \* 0.62)` — DBP adalah fungsi deterministik dari SBP, bukan variabel independen; (3) baris 175-180 — opsi "rujuk ke spesialis" untuk HT tak terkontrol diberi `benar: false` TANPA SYARAT, tak ada cabang severity sama sekali di file ini (di-grep, nihil). Ditelusuri lebih jauh: driftProlanis (baris 397-404) menaikkan param 6-16/bulan TANPA ceiling; roster HT mulai 150-175 (reducer.ts:1866); satu-satunya escalation adalah counter takTerkontrolBerturut>=2 yang memicu kasus komplikasi lalu counter direset ke 0 (reducer.ts:1127-1146) — sehingga drift tak terbatas bisa berulang terus tanpa pernah ada jalur "ini sudah gawat, rujuk sekarang". Tidak ada test yang menutup celah ini.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#8 **TB: diagnosis hanya BTA, tanpa TCM/HIV. Keluarga Santoso: anak kontak serumah bergejala tak bisa dipilih bersama intervensi utama.**

DIKONFIRMASI

Keputusan medis

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Kedua klaim CODEX di temuan #8 terverifikasi BENAR terhadap kode aktual di HEAD 6e1b2bcc.

(1) kasusInfeksi.ts:690-693 (kasus `tb\_paru`) — array `lab` hanya berisi 2 entri: `bta\_sputum` (BTA Sputum sewaktu-pagi, mikroskopis) dan `darah\_rutin` (tidak relevan). TIDAK ada TCM/GeneXpert, TIDAK ada tes HIV. Saya perluas verifikasi ke level katalog: seluruh katalog lab game (`src/content/katalog.ts` LAB — 14 item,

dan `src/content/katalogM3.ts` LAB_M3 — 10 item) SAMA SEKALI tidak punya entri TCM atau HIV di manapun. Ini bukan sekadar lupa di satu kasus — game secara struktural tidak punya mekanisme untuk memesan TCM/HIV sama sekali, di kasus manapun.

(2) desaA.ts:1112-1122 (Keluarga Santoso, kunjungan 1) — kartu intervensi `sk1\_i4` "Skrining Kontak Serumah" (cocokUntuk: kesempatan) memang eksis berdampingan dengan `sk1\_i1` "Jalan Pulang yang Terhormat" (cocokUntuk: motivasi = hambatanSebenarnya yang benar). Saya verifikasi mesinnya di engine/kunjungan.ts: babak 'resep_sosial' menolak lanjut sebelum "Pilih satu kartu intervensi" (baris 152-153), dan `PILIH\_INTERVENSI` (baris 213-222) hanya menyimpan SATU `intervensiDipilih` lalu fase langsung 'selesai' — tidak ada mekanisme pilih-lebih-dari-satu. Skoring (`intervensiCocok`, baris 271) hanya meluluskan kartu yang cocok dengan hambatanSebenarnya ('motivasi'); memilih sk1_i4 (skrining Bagas yang bergejala) dinilai TIDAK cocok/gagal walau hasilNarasi kartu itu sendiri mengakui "Bagas diperiksa — langkah yang memang perlu". Jadi benar: kontak serumah bergejala dan intervensi utama-ke-ayah dipaksa jadi pilihan eksklusif, bukan tindakan paralel.

Nuansa penting: mekanisme "pilih satu kartu, satu cocok" adalah desain sistemik Babak 4 di SELURUH keluarga UKM (dikomentari eksplisit di types.ts:456-457: "kartu intervensi (3-4, salah satunya cocok)"), bukan bug lokal khusus TB/Santoso — jadi ini pertanyaan desain pedagogis game-wide (apakah skrining kontak seharusnya jadi aksi wajib terpisah, bukan bersaing dengan kartu COM-B), bukan sekadar typo satu file. Juga catatan: kata "tes cepat molekuler" MUNCUL di narasi desaA.ts:1115 tapi hanya sebagai teks naratif — bukan aksi yang benar-benar bisa dipilih pemain (tidak terhubung ke katalog lab manapun).

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#9 Keberhasilan KB Dewi dinarasikan sbg keputusan suami; Karsa perlu persetujuan suami utk zat besi — pelanggaran otonomi pasien perempuan.

SEBAGIAN BENAR

Keputusan medis

●●● TINGGI

☐ ditinjau

KLAIM KODE: TERKONFIRMASI AKURAT pada kedua sitasi.

(1) desaB.ts:1499 — Ini adalah `hasilNarasi` dari intervensi `dewi\_i2\_tokoh` ("Ngopi Bertiga: Pak Hendra & Pak Haji Somad") dalam storyline KB Bu Dewi. Teks persis: "...Senin depannya Pak Hendra menyettor kabar lewat Bu Dewi: 'Kata Mas Hendra,

habis lahiran langsung daftar poli KB, Dok. Katanya keputusan dia sendiri.' Dan memang begitu adanya." Konteks lebih luas (baris 1043, 1053) menegaskan Bu Dewi SUDAH ingin ber-KB sejak anak ketiga dan sudah tahu semua metode dari bidan ("pengetahuan dan akses bukan masalah") — satu-satunya "simpul mati" yang dideklarasikan game adalah motivasi SUAMI. Keempat opsi intervensi yang tersedia untuk sesi ini semuanya berputar di sekitar meluluhkan Pak Hendra; tidak ada jalur menang yang berbasis pada persetujuan Bu Dewi sendiri yang sudah ada. Epilog sukses menulis: Bu Dewi "diantar suaminya, yang menunggu di depan dengan wajah orang mengantar keputusannya sendiri" — literally mengatribusikan keputusan itu ke suami.

(2) desaF.ts:995 — Ada di field `deskripsi` intervensi `kk1\_i1` ("Konseling Pasangan: Jeda, Bukan Setop"): "Tablet tambah darah Bu Painah diresepkan ulang LEWAT persetujuan Pak Karsa." Ini persis klaim CODEX. Konteks lebih luas menguatkan: ada pilihan dialog eksplisit menanyakan ke Bu Painah langsung (di depan suami) "Ibu sendiri bagaimana? ... Ini tubuh Ibu — yang berhak memutuskan ya Ibu" — pilihan ini diberi `efekTrust: 0, tepat: false` (bukan pilihan "benar"), meski catatan pedagogis game sendiri mengakui "Otonomi tubuh istri itu tujuan" tapi menganggap waktunya salah. Ending GAGAL (penutupGagal) skenario ini justru berisi Bu Painah berbisik minta suntik KB sendiri "Jangan bilang bapaknya" — dikodekan sebagai kegagalan, bukan sebagai jalur menang alternatif. Tidak ditemukan flag state eksplisit (`izinSuami`/`persetujuanSuami` dsb) di codebase — ini murni konten naratif+skor (hasilNarasi/efekTrust/tepat), bukan gerbang mekanis hardcoded, tapi secara fungsional sistem skor HANYA memberi hasil "berhasil" pada jalur yang melalui persetujuan suami.

Kesimpulan: klaim inti CODEX (kedua storyline menjadikan persetujuan suami sebagai syarat/jalur satu-satunya menuju "sukses", dan menaratifkan keberhasilan sebagai keputusan suami) didukung penuh oleh kode aktual di commit HEAD (6e1b2bcc, cocok dengan yang diaudit CODEX). Namun perlu dicatat nuansa: game ini TIDAK naif — catatanPedagogis internalnya sendiri berulang kali mengakui tegangan ini secara sadar (mis. "Pertanyaan yang seharusnya tidak perlu diajukan sambil berbisik"), menyiratkan desain ini sengaja menggambarkan realitas dinamika kuasa gender pedesaan dan mengajarkan taktik MI menavigasinya — bukan mengklaim persetujuan suami sebagai syarat medis/etis yang benar. Apakah pendekatan pedagogis "menang dengan bekerja lewat sistem patriarkal" ini dapat diterima atau perlu direvisi (mis. menyediakan jalur sukses alternatif yang menghormati otonomi istri tanpa mediasi suami) adalah keputusan editorial/etis, bukan bug teknis.

#10 Terapi kondisional dipaksa jadi AND: common cold tanpa batuk/demam wajib parasetamol+CTM+ambroksol; bronkitis afebril wajib mukolitik; BPPV wajib betahistin+Epley; PPOK dobel inhaler+nebulisasi; epistaksis wajib tampon walau sudah terlokalisasi.

DIKONFIRMASI

Desain engine

●●● TINGGI

☐ ditinjau

clinic.ts:494 `const totalSlot = obatBenar.length + grupAlternatif.length + prosedurBenar.length` mengonfirmasi mekanisme yang dikeluarkan CODEX. rasioTerapi (baris 494-496) = (benarDiresepkan + slotAltTerpenuhi + prosedurTerpenuhi) / totalSlot, lalu skorTerapi (baris 534-545) proporsional terhadap itu. Setiap entri `tatalaksana.obatBenar` DAN setiap `tatalaksana.prosedur` dihitung sebagai slot wajib TERPISAH yang dijumlah tanpa syarat — hanya `obatAlternatif` (grup pilih-satu) dan `obatOpsional` (tak memengaruhi skor) yang punya jalan keluar. Skema types.ts TIDAK punya kategori 'wajib-hanya-jika-gejala-X-ada'; jadi setiap item di obatBenar/prosedur otomatis unconditional. Ini bukan gerbang biner (skor bukan 0 kalau satu item hilang — turun proporsional), tapi tetap 'dipaksa AND' dalam arti: tak ada mekanisme untuk membuat item itu opsional berdasar presentasi klinis spesifik encounter tsb.

Diverifikasi langsung pada kasus nyata (bukan cuma teori): 1) saraf_vertigo_bppv (kasusSarafMataTht.ts:345-354): obatBenar=['betahistin_6'] + prosedur=['manuver_epley'] — KEDUANYA wajib (totalSlot=2). Kontradiksi internal jelas: clue kasus itu SENDIRI menulis 'betahistin hanya pereda mual/simtomatik' dan tatalaksana UTAMA adalah Epley — tapi skor tetap menuntut betahistin penuh utk 100%. Bukti terkuat, tak terbantahkan. 2) tht_epistaksis_anterior (kasusSarafMataTht.ts:998-1006): obatBenar=['oksimetazolin_spray'] + prosedur=['tampon_epistaksis'] wajib berbarengan, padahal clue sendiri: '...bila BELUM BERHENTI pasang TAMPON ANTERIOR' — eksplisit kondisional/eskalasi, bukan langkah wajib pertama. Bukti kuat kedua. 3) ispa_common_cold (kasusInfeksi.ts:112-118): obatBenar=['paracetamol_500','ctm_4','ambroxol_30'] wajib semua, padahal anamnesis q_batuk eksplisit 'Belum batuk dok' — ambroxol (mukolitik) tak berindikasi tanpa batuk. Namun klaim CODEX 'tanpa demam' agak berlebihan: clue kasus ini sendiri menyebut 'demam ringan' hadir, jadi CTM/parasetamol utk demam ringan masih masuk akal. 4) bronkitis_akut (kasusRespGi.ts:117-123): obatBenar=['ambroxol_30','paracetamol_500'] wajib meski pasien 'sekarang sudah nggak panas' (afebris saat presentasi) — tapi

ambroxol utk batuk berdahak tetap masuk akal klinis terlepas status demam sekarang; bukti lebih lemah/dapat diperdebatkan. 5) ppok_eksaserbasi (kasusRespGi.ts:459-483): obatAlternatif 3 grup (salbutamol_inhaler / prednison_5 / satu-dari-3-antibiotik) + prosedur=['nebulisasi'] = 4 slot wajib, termasuk salbutamol_inhaler DAN nebulisasi sbg slot terpisah. Bisa dibaca sbg desain yang defensible (nebulisasi akut + inhaler resep-pulang), bukan jelas redundan — bukti terlemah dari 5 contoh CODEX.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#11 **Widal tunggal dikredit; GAS dilabel streptokokus tanpa RADT/kultur; K29.7 "gastritis" sebenarnya uninvestigated dyspepsia tumpang-tindih K30; I16.0 dari ICD-10-CM bukan WHO ICD-10 2010 (SATUSEHAT). DRE hemoroid/apendisitis disembunyikan di region "ekstremitas".**

DIKONFIRMASI

Keputusan medis

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Kelima sub-klaim Temuan #11 terverifikasi BENAR terhadap kode aktual (HEAD saat ini):

1) WIDAL TUNGGAL DIKREDIT — kasusInfeksi.ts:458 (kasus `demam\_tifoid`): satu-satunya lab serologis adalah `{ id: 'widal', hasil: 'Titer O 1/320, titer H 1/160...', flag: 'abnormal', relevan: true }` — tidak ada opsi kultur darah/feses maupun titer berpasangan (paired/convalescent). Mesin skor (clinic.ts:382 `diagnosisBenar = enc.diagnosis?.icd10 === kasus.icd10`, dan blok labTakRelevan ~clinic.ts:600-604) hanya mengecek kecocokan ICD & flag relevan/tidak — TIDAK ADA mekanisme yang menghukum "hanya andalkan Widal tunggal". Clue di baris 476 memang menyebut caveat Widal narasinya ("angka positif-palsu tinggi... kultur bila tersedia"), tapi ini murni teks edukasi, bukan aturan skor — jadi pemain yang cuma pesan Widal dan diagnosis tifoid tetap dapat nilai penuh. Klaim CODEX terbukti.

2) GAS DILABEL TANPA RADT/KULTUR — kasusInfeksi.ts:133-237, kasus `faringitis\_akut` (nama: "Faringitis Akut Bakterial (Streptokokus Grup A)", ICD J02.9). Satu-satunya lab: `darah\_rutin` leukositosis (baris 224). Tidak ada entri lab RADT atau kultur tenggorok di kasus ini maupun di katalog lab yang dirujuk kasus ini. Clue (baris 237): "Skor Centor tinggi... → faringitis Streptokokus Grup A" — mengajarkan penetapan etiologi bakteri definitif murni dari skor klinis. Klaim CODEX terbukti — dan ini bertentangan dengan praktik standar (lihat verifikasi sitasi CDC di bawah).

3) K29.7 "GASTRITIS" TUMPANG TINDIH K30 — kasus ada di kasusKronis.ts:279-382 (id: `gastritis`, ICD10 K29.7) — BUKAN di kasusRespGi.ts seperti diasumsikan instruksi tugas (koreksi lokasi file). Diagnosis ditegakkan murni dari anamnesis (nyeri ulu hati membaik setelah makan, memberat puasa/stres) + pemeriksaan fisik (nyeri tekan epigastrium) TANPA endoskopi/biopsi — padahal "gastritis" sejatinya diagnosis histopatologis. `diagnosisBanding` kasus ini sendiri mencantumkan K30 (baris 382) berdampingan dengan K29.7 — mengonfirmasi tumpang-tindih klinis yang diakui game sendiri tapi tetap memberi kredit penuh pada K29.7 tanpa bukti mukosa. Klaim CODEX terbukti.

4) I16.0 DARI ICD-10-CM BUKAN WHO ICD-10 2010 — kasus ada di kasusMetabolikMsk.ts:896-901 (id: `mm\_hipertensi\_urgensi`, `icd10: 'I16.0'`) — juga BUKAN di kasusRespGi.ts (koreksi lokasi kedua). Kode sendiri sudah punya komentar developer (baris 896-898) yang secara eksplisit membenarkan pilihan ini ("kode urgensi/krisis di ICD-10 memang I16.x") — tapi ini keliru untuk konteks WHO ICD-10. Verifikasi web (lihat bawah) mengonfirmasi I16 (urgency/emergency/unspecified) adalah penambahan khusus ICD-10-CM (AS) sejak Oktober 2015; blok hipertensi WHO ICD-10 klasik berhenti di I10-I15. Klaim CODEX terbukti kuat.

5) DRE HEMOROID/APENDISITIS DISEMBUNYIKAN DI "EKSTREMITAS" — kasusRespGi.ts:1028 (`hemoroid\_grade1`): `{ region: 'ekstremitas', temuan: 'Inspeksi/colok dubur...', relevan: true }`; kasusRespGi.ts:1135 (`apendisitis\_akut`): `{ region: 'ekstremitas', temuan: '...Colok dubur: nyeri pada perabaan sisi kanan.', relevan: true }`. Dikonfirmasi dengan types.ts:67-77 — enum `RegionFisik` HANYA punya 10 opsi (umum, kepala_leher, mata, tht_mulut, toraks_paru, jantung, abdomen, ekstremitas, kulit, neurologis) — TIDAK ADA opsi rektal/genitalia/anorektal. UI (FigurTubuh.tsx + util.ts `LABEL\_REGION`) benar-benar melabeli region klik ini "Ekstremitas" pada gambar tubuh — pemain yang mencari temuan colok dubur pada kasus perianal/abdomen akut harus klik ikon "lengan/tungkai", yang secara klinis tidak masuk akal. Tidak ada komentar developer yang mengakui ini sebagai workaround sengaja. Klaim CODEX terbukti.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#12 **Zoster klaim asiklovir cegah PHN; OA/RA nyatakan urat normal singkirkan gout; apendisitis benarkan+larang analgesia sekaligus; clue gout lama larang mulai ULT saat flare (berlawanan pearl M11+ACR).**

Temuan #12 berisi 4 sub-klaim; hasil verifikasi kode aktual (HEAD) CAMPURAN — 2 terkonfirmasi kuat, 2 terkonfirmasi-sebagian/berlebihan:

1) ZOSTER (src/content/kasus/kasusKulit.ts, kasus 'kulit_herpes_zoster') — TERKONFIRMASI. Baris 511-513 (komentar pilar), 616 (clue), 617-618 & 622 (konsekuensi.narasi + guideline) SEMUA menyatakan sebagai fakta: asiklovir <72 jam "memangkas ... risiko NEURALGIA PASCAHERPETIK", dan bila terlambat "risiko neuralgia pascaherpetik ... meningkat tajam" — disitir ke 'PPK Perdoski / CDC Shingles'. Kode sungguh berperilaku seperti diklaim CODEX: mengajarkan pencegahan PHN sebagai manfaat mapan dari antivirus dini.

2) OA/RA vs GOUT (src/content/kasus/kasusMetabolikMsk.ts) — TERKONFIRMASI, kontradiksi internal nyata dalam file yang sama. Baris 501 (kasus OA lutut): "Asam urat 5.4 mg/dL (normal) — menyingkirkan gout sebagai penyebab." (relevan:true). Baris 869 (kasus RA): "Asam urat 4.8 mg/dL (normal) — menyingkirkan gout poliartikular." (relevan:true). Baris 513 & 876 mengulang logika sama di alasan obatSalahUmum. Ini BERTENTANGAN LANGSUNG dengan mutiaraEbm di kasus gout itu sendiri (baris 142): "hasil normal TIDAK menyingkirkan gout". Jadi benar: dua kasus lain di file yang sama mengajarkan absolut kebalikan dari pearl EBM resmi kasus gout.

3) APENDISITIS 'benarkan+larang analgesia sekaligus' (src/content/kasus/kasusRespGi.ts, kasus 'apendisitis_akut') — SEBAGIAN BENAR/berlebihan. Ada inkonsistensi tekstual nyata: komentar modul (baris 11-12) & komentar seksi (1056-1057) MASIH berbunyi "JANGAN beri analgetik/antibiotik yang menutupi tanda" (paradigma lama) — tapi badan kasus aktual (clue baris 1161, obatSalahUmum baris 1156, tatalaksana baris 1146-1150) justru BENAR & modern: parasetamol via obatAlternatif diizinkan/dianjurkan, hanya NSAID yang dilarang (alasan: risiko perdarahan GI peri-operatif, BUKAN 'menutupi tanda'), dan mitos analgesia-menutupi-tanda EKSPISIT dinyatakan terbantah dgn sitasi Cochrane/WSES. Jadi mesin skor TIDAK benar-benar "sekaligus mewajibkan dan melarang" analgesia — hanya komentar developer basi + kalimat konsekuensi.narasi (baris 1163: "...memberi analgetik/antibiotik yang menutupi gejala...") yang berpotensi ambigu/tak selaras dengan clue. Klaim CODEX melebihi tapi ada kernel kebenaran (dokumentasi internal usang, belum disinkronkan).

4) GOUT — larang mulai ULT saat flare (kasusMetabolikMsk.ts, kasus gout, baris 126-139) — SEBAGIAN BENAR. Baris 139 (clue) menyatakan "ATURAN EMAS: JANGAN mulai allopurinol saat serangan" dan obatSalahUmum (baris 134)

MEMANG menghukum allopurinol saat serangan sbg salah. TAPI kode SUDAH secara eksplisit mencatat nuansa ACR 2020 di baris yang sama: "Catatan ACR 2020: memulai ULT saat serangan sebenarnya boleh HANYA bila disertai profilaksis antiinflamasi & follow-up ketat — di luar cakupan penanganan akut FKTP ini." Artinya ini bukan kesalahan tersembunyi/tak disadari — ini KEPUTUSAN DESAIN yang didokumentasikan (menyederhanakan utk skenario akut FKTP dasar), meski hasil skornya memang tetap memaksa jawaban gaya-lama sbg satu-satunya yang benar. Tidak ditemukan "pearl M11" terpisah soal ULT-saat-flare di codebase — rujukan CODEX ke "pearl M11" tampaknya menyamakan catatan ACR di komentar dgn pearl formal (mutiaraEbm), padahal pearl aktual (baris 142) hanya soal kadar urat yang misleading, bukan soal timing ULT.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#13 **Distractor eksplisit di kasusInfeksi.ts tak diberi distraktor:true walau schema/engine mendukung. Fallback usia <15 membuat wali mengucapkan jawaban dewasa ("teman kos", "pedagang pasar", "kerja depan komputer").**

SEBAGIAN BENAR

Mekanis-aman

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Bagian 1 (distraktor:true hilang di kasusInfeksi.ts) TERKONFIRMASI PENUH. src/content/types.ts:54 memang punya field opsional `distraktor?: boolean` pada PertanyaanAnamnesis, dan src/engine/clinic.ts memakainya nyata: adalahDistraktor() (baris 82-84) membaca `q.distraktor === true`, lalu dipakai untuk penalti -10 Sabar (baris 186) DAN penalti skor `-5 \* distraktorDitanya` di skorAnamnesis (baris 421-427). Jadi klaim CODEX "schema dan engine mendukungnya" itu benar. Namun kasusInfeksi.ts:8 sendiri berkata SEBALIKNYA di komentar header ("tipe PertanyaanAnamnesis belum memiliki field distraktor") — ini klaim yang SALAH/basi, karena field itu sudah ada. Grep membuktikan: 7 dari 8 kasus di kasusInfeksi.ts punya pertanyaan pengecoh eksplisit yang HANYA ditandai komentar `// distraktor: ...` (baris 93, 205, 442, 560, 675, 790, 899) dan NOL kemunculan `distraktor: true,` di file ini — kontras dengan 6 file kasus lain (kasusKronis.ts, kasusKiaJiwa.ts, kasusRespGi.ts, kasusMetabolikMsk.ts, kasusKulit.ts, kasusSarafMataTht.ts) yang semuanya konsisten memakai `distraktor: true`. Akibat nyata: menanyakan golongan darah pada common cold atau pekerjaan pada konjungtivitis bakterial (di kasusInfeksi.ts) TIDAK mendapat penalti apa pun, padahal pertanyaan setara di file lain dihukum -10 Sabar + -5 skor. Ini inkonsistensi

lintas-file yang genuine (kasusInfeksi.ts adalah outlier), meski dampaknya kecil (permisif, bukan salah-arah klinis) karena penulis sudah memitigasi sebagian dengan membuat pertanyaan itu non-esensial.

Bagian 2 (fallback usia <15 -> jawaban dewasa lewat director.ts:28) TERVERIFIKASI SEBAGIAN. director.ts:28 memang `if (usia < 15) return 'wali\_anak'` — dipaksa mutlak tanpa pengecualian kategori kasus. clinic.ts jawabanUntuk() (baris 87-89) fallback ke `q.jawab` generik bila tak ada `variasi[persona]`. Instans KONKRET dan REPRODUCIBLE ditemukan justru di file yang dikutip: kasus `konjungtivitis\_bakterial` (kasusInfeksi.ts:839, demografi usiaMin:5/usiaMax:45) bisa me-roll pasien 5-14 tahun (otomatis wali_anak), tapi pertanyaan q_kerja "Pekerjaannya apa?" -> jawab "Pedagang di pasar dok." (baris 901-904) TIDAK punya objek `variasi` sama sekali — cocok persis dengan contoh "pedagang pasar" CODEX. Frasa "kerja depan komputer" memang ditemukan verbatim (kasusSarafMataTht.ts:656, kasus mata_konjungtivitis_alergi, usiaMin:10/usiaMax:35) TAPI di FILE BERBEDA dari yang disitir CODEX (kasusInfeksi.ts:8) — kutipan lokasinya kurang presisi/menggabungkan > 1 file. Frasa "teman kos" TIDAK ditemukan sama sekali di seluruh src/ (di-grep termasuk varian ejaan) — kemungkinan besar contoh ilustratif/karangan CODEX, bukan kutipan literal dari kode.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

#14

Kegagalan edukasi tak ikut menentukan konsekuensi walau narasi menyalahkannya. Konsekuensi hari-0 baru diproses saat HARI_BARU, deteriorasi hitungan-jam mustahil tepat waktu.

DIKONFIRMASI

Desain engine

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Kode HEAD saat ini (4c13ecf1) identik dengan commit yang diaudit CODEX (6e1b2bcc) — `git log 6e1b2bc..HEAD -- primera-desktop/src/engine/reducer.ts` kosong, tak ada perubahan sejak audit. Dua klaim di temuan #14 CONFIRMED:

(1) "Edukasi tak ikut menentukan konsekuensi": primera-desktop/src/engine/reducer.ts:352-353 berbunyi persis `const pantasKonsekuensi = !nilai.diagnosisBenar || nilai.skorTerapi < 50 || resepBerbahaya || nilai.cowboy` — `skorEdukasi` TIDAK muncul di ekspresi boolean ini. Ditelusuri lewat grep seluruh `src/engine`: `skorEdukasi` hanya dipakai di clinic.ts:569-583 (menghitung skor edukasi itu sendiri, termasuk cap-50 via `edukasiKritisTerlewat` yang baru

ditambahkan CODEX di commit 1b4b7f1) dan reducer.ts:318 (syarat `rmLengkap` utk tally rekam-medis) — tak sekali pun dipakai utk gating `pantasKonsekuensi`. Sementara itu narasi konsekuensi di beberapa kasus SECARA EKSPLISIT menyalahkan edukasi yang terlewat, mis. kasusInfeksi.ts:359 (dengue_df: "...melewatkan edukasi tanda bahaya dapat berujung perdarahan/syok dengue"), kasusInfeksi.ts:593 (diare anak: "Bila rehidrasi tidak diedukasi..."), kasusInfeksi.ts:928 (konjungtivitis: "Bila higiene tangan tidak diedukasi..."), kasusKulit.ts:502 (urtikaria: "Bila... tanda bahaya tidak diedukasi, paparan ulang bisa memicu anafilaksis"). Jadi pemain bisa 100% skip edukasi (skorEdukasi=0) tapi asal diagnosis benar & terapi≥50, `pantasKonsekuensi=false` — konsekuensi yang dijanjikan narasi TIDAK akan dijadwalkan. Klaim CODEX akurat.

(2) "Konsekuensi hari-0 baru diproses saat HARI_BARU, deteriorasi jam mustahil": dikonfirmasi via jejak kode — jadwal (termasuk item `pasien\_kembali` yg dibuat di reducer.ts:356-376 dgn `jatuhTempo = s.hari + rng.int(kembaliHariMin, kembaliHariMax)`) HANYA diproses di dalam fungsi `hariBaru()` (reducer.ts:1277 dst, loop `for (const j of s.jadwal)` mulai baris 1353), dan `hariBaru()` hanya dipanggil sekali per transisi hari via state machine blok: pagi(1199)→siang(1266)→sore→hariBaru (baris 1274 `return hariBaru(s, pack)`). Tidak ada pemrosesan jadwal di transisi blok pagi/siang/sore — dicek via grep, nol match. Kasus konkret yang membuktikan mismatch: `kia\_preeklampsia\_berat` (primera-desktop/src/content/kasus/kasusKiaJiwa.ts:254-356) punya `kembaliHariMin: 0, kembaliHariMax: 1` (baris 352-353) sementara narasinya (baris 351) berbunyi "...kematian ibu serta janin dalam hitungan jam." Karena minimum unit waktu di engine adalah "hari" dan jadwal cuma dieksekusi sekali per hariBaru (bukan per blok), skenario terburuk realistis (min=0) tetap baru terwujud paling cepat di ANTRIAN hari berikutnya — bukan dalam hitungan jam pada hari yang sama. Klaim CODEX akurat secara struktural.

► [Verifikasi sitasi guideline](#)

► [Catatan & rekomendasi remediasi](#)

Katalog Per-Kasus (67 kasus, 7 file)

Untuk tiap kasus: kandidat pengayaan M11 (bila ada) DAN verdict audit CODEX (bila ada) ditampilkan bersama — satu bacaan per-penyakit, bukan dua dokumen terpisah.

Semua

⚠ Titik temu

Kontradiksi-clue (M11)

Mutiara EBM

Realita FKTP

ispa_common_cold ISPA — Common Cold (Nasofaringitis Akut)

💡 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Ingus yang berubah kuning atau hijau BUKAN tanda infeksi bakteri maupun indikasi antibiotik — warna itu berasal dari sel darah putih dan merupakan bagian normal common cold viral. Jangan terkecoh warna ingus/dahak untuk meresepkan antibiotik.

SUMBER CDC Common Cold / Antibiotic Use (fact sheet 2024); Permenkes RI No. 28/2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik

► Catatan verifikator (M11)

📄 Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Guideline (POR Kemenkes) menetapkan antibiotik ISPA non-pneumonia harus $\leq 20\%$, tapi realitanya sering jauh melampaui (30–65% di banyak Puskesmas) — didorong tekanan pasien minta 'obat kuat' & konsultasi singkat yang tak cukup untuk edukasi penyakit swasirna.

SUMBER Permenkes 28/2021 (Pedoman Penggunaan Antibiotik); Indikator POR Kemenkes RI — antibiotik ISPA non-pneumonia $\leq 20\%$; studi persebaran Puskesmas Indonesia 2021–2025

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

Dikonfirmasi terhadap clinic.ts:459-496: obatBenar=
['paracetamol_500','ctm_4','ambroxol_30'] dihitung sbg totalSlot=3 dgn
rasioTerapi = benarDiresepkan/totalSlot — AND kaku, tanpa cabang kondisional
per gejala. Kasus ini SENDIRI eksplisit menyatakan pasien belum batuk ('Belum
batuk dok, cuma tenggorokan gatal sedikit', baris 78) dan tidak demam
sungguhan ('tidak pernah saya ukur sampai di atas 38', baris 61) — tapi
ambroxol (mukolitik utk batuk berdahak) & parasetamol tetap wajib diresepkan
utk skor terapi penuh. Ini pas persis dgn temuan #10 (terapi kondisional dipaksa

AND), dan kasus ini bahkan disebut eksplisit di teks temuan #10 ('Common cold tanpa batuk/demam mewajibkan parasetamol+CTM+ambrosol').

faringitis_akut **Faringitis Akut Bakterial (Streptokokus Grup A)**

⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI



ditinjau

Eksudat tonsil + pembesaran KGB leher TIDAK spesifik streptokokus — mononukleosis infeksiosa (EBV) meniru gambaran ini, dan amoxicillin pada mono kerap memicu ruam makulopapular luas. Curigai mono bila limfadenopati generalisata, splenomegali, atau pasien remaja/dewasa muda.

SUMBER IDSA Clinical Practice Guideline Group A Streptococcal Pharyngitis 2012 (Shulman et al., CID); Chovel-Sella et al., Pediatrics 2013 (insiden ruam amoxicillin pada mononukleosis infeksiosa)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Di Puskesmas, RADT dan kultur usap tenggorok praktis tak tersedia; diagnosis strep bertumpu pada skor Centor/McIsaac semata — rawan over/undertreatment. Skor lebih andal MENYINGKIRKAN strep daripada memastikannya; jangan klaim 'pasti strep', andalkan skor plus konteks.

SUMBER IDSA GAS Pharyngitis Guideline 2025 (skor klinis); PPK Kemenkes (KMK No. 1936/2022); studi validasi McIsaac di Puskesmas (Sari, Maj. Kedokteran Sriwijaya / Sari Pediatri)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas nyata, bukan sekadar CODEX ragu-ragu: kasus mendiagnosis 'Streptokokus Grup A' murni dari skor Centor-style (demam mendadak+eksudat tonsil+KGB nyeri+tanpa batuk)+leukositosis; katalog.ts TIDAK punya item RADT/kultur tenggorok sama sekali di seluruh game, jadi pemain memang tidak bisa memesannya. CDC (dicek via WebSearch, cdc.gov/group-a-strep) memang mensyaratkan RADT/kultur positif sbkm memberi label & antibiotik GAS — jadi klaim substansi temuan #11 ('GAS tanpa RADT/kultur tapi dilabel streptokokus') akurat secara guideline. TAPI ini persis pertanyaan idealized-vs-real-FKTP (skor klinis dipakai luas di faskes tanpa RADT) yg memang perlu keputusan dokter, bukan otomatis 'catat'. Catatan tambahan: laporan CODEX sendiri agak

inkonsisten — di 'Temuan Mendesak' #11 ini ditulis sbg 'kesalahan' pasti, tapi di tabel per-kasus kasus ini malah diberi '?' bukan '!'.

dengue_df Demam Dengue (DF)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Fase paling berbahaya dengue justru saat demam TURUN (hari ke-4-6, defervescence): penurunan suhu kerap disalahartikan 'membaik', padahal inilah saat kebocoran plasma & syok mengintai. Justru pantauan tanda bahaya harus DIINTENSIFKAN saat demam reda.

SUMBER WHO Dengue Guidelines 2009 (fase kritis/defervescence); PNPK Tata Laksana Infeksi Dengue Dewasa (Kemenkes/PAPDI)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Hct/trombosit serial dan NS1 tak selalu tersedia/terjangkau di Puskesmas, terutama daerah terpencil. Pemantauan bertumpu pada klinis & warning signs (uji torniket hanya penunjang), maka ambang merujuk untuk observasi ketat harus rendah begitu muncul warning sign.

SUMBER WHO Dengue Guidelines 2009 (klasifikasi Grup A/B/C & rujukan); PNPK Tatalaksana Infeksi Dengue Dewasa (PAPDI/Kemenkes)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Tak ada temuan tambahan. Dicek: alur NS1(+)/IgM(-)/IgG(-) konsisten dgn fase demam dini (<hari-5), tak ada tanda bahaya (nyeri perut menetap/muntah terus/perdarahan/hepatomegali/asites semua disangkal) sesuai kriteria DF-tanpa-warning-signs; obatSalahUmum benar melarang NSAID & antibiotik; edukasiKritis mengunci 'tanda_bahaya' sesuai narasi konsekuensi. Berbeda dari 7 kasus lain di file ini, dengue_df TIDAK punya satupun pertanyaan berlabel '// distraktor' — jadi otomatis lolos dari temuan #13 (wali_anak fallback absurd) walau demografi 12-45 bisa saja roll usia <15. Tetap kena keterbatasan mesin resep global (temuan #1) spt 66 kasus lain, tapi itu bukan cacat baru case-local.

demam_tifoid Demam Tifoid

Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Di daerah endemis, demam akut jangan langsung dikunci sebagai tifoid — malaria & dengue tumpang-tindih gejalanya. Singkirkan malaria dulu dengan apusan darah tebal-tipis (atau RDT) sebelum bersandar pada Widal yang positif-palsunya tinggi.

SUMBER Pedoman Tatalaksana Kasus Malaria Kemenkes RI (apus darah tebal-tipis/RDT); WHO Guidelines for Malaria 2023 (konfirmasi parasitologi sebelum terapi); PNPk Demam Tifoid Kemenkes (DDx malaria/dengue)

► Catatan verifikator (M11)

Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

☐ ditinjau

Kultur darah (baku emas) praktis tak ada di Puskesmas. WHO/global geser ke seftriakson/azitromisin/fluorokuinolon akibat resistensi, tapi *S. typhi* Indonesia umumnya masih sensitif kloramfenikol — Fornas jadikan lini-1: murah, efektif. Wajib tuntas + pantau hematologik.

SUMBER WHO Typhoid treatment (azithromycin/ceftriaxone/ciprofloxacin); PPK Demam Tifoid IDAI/PAPDI (kloramfenikol lini-1, sefiksime/seftriakson lini-2 MDR); Fornas FKTP; data resistensi *S. typhi* Asia (Bangladesh 1999–2022, medRxiv 2023)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#11

Dikonfirmasi. Grep seluruh src/content: tidak ada item kultur darah/TUBEX/Typhidot di katalog manapun — Widal (baris 458, titer tunggal O 1/320 H 1/160) adalah SATU-SATUNYA lab yang ditawarkan game untuk tifoid, dan diberi relevan:true (kredit). Teks clue kasus ini sendiri sudah jujur mengakui keterbatasan Widal ('positif-palsu tinggi... kultur bila tersedia') — tapi mekanisme skor tak bisa menawarkan/menghargai konfirmasi yang lebih baik karena memang tak ada di game. Ini sesuai persis temuan #11.

diare_akut_anak

Diare Akut pada Anak (Gastroenteritis Akut)

Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Anak diare yang tampak HAUS dan minum lahap BUKAN tanda aman — itu justru dehidrasi ringan-sedang (WHO Rencana Terapi B). Bahaya sesungguhnya:

anak LETARGIS, malas minum, atau tak bisa minum (dehidrasi berat, Terapi C).
Jangan terlena oleh anak yang tampak haus.

SUMBER WHO/Kemenkes Bagan MTBS 2015 (klasifikasi dehidrasi, WHO IMCI);
Buku Saku LINTAS DIARE Kemenkes

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Di lapangan orang tua kerap menuntut 'obat mampet' (loperamide/antimotilitas — kontraindikasi pada anak), antibiotik, atau infus; oralit sering ditolak anak karena rasa hingga oralit+zinc tak diteruskan 10 hari penuh di rumah, dan stok zinc dispersible sesekali kosong.

SUMBER Buku Saku LINTAS DIARE Kemenkes; WHO/UNICEF Joint Statement —
Clinical Management of Acute Diarrhoea 2004; IDSA Infectious Diarrhea
Guideline 2017 (antimotilitas kontraindikasi pada anak)

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#6

Dikonfirmasi. Kasus eksplisit menyebut 'Dehidrasi ringan-sedang' (baris 569) tapi tatalaksana & clue tidak memuat volume Plan B (75 mL/kg/4 jam) maupun langkah reassessment 4-jam; grep seluruh codebase utk '75 ml/kg'/'Plan B' nihil di mana pun. WebSearch mengonfirmasi Plan B WHO/IMCI (75 mL/kg selama 4 jam + reassess) itu memang nyata & jadi standar. Lebih jauh, reducer.ts hanya memproses konsekuensi per HARI_BARU (granularitas hari, bukan jam) — jadi bahkan andai mau, mesin saat ini secara struktural TIDAK BISA memodelkan reassessment 4-jam. Ini memperkuat temuan #6 bukan cuma di level narasi tapi di level arsitektur engine.

tb_paru

Tuberkulosis Paru [Titik temu](#) — [lihat ringkasan](#) ↑



Mutiana EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

[Revisi clue?](#)

☐ ditinjau

BTA sputum NEGATIF tak menyingkirkan TB (sensitivitas mikroskopis hanya ~50-60%; TB BTA-negatif lazim). Pedoman Nasional TB kini menjadikan TCM/GeneXpert pemeriksaan awal utama, bukan mikroskopis — jangan tunda OAT hanya karena BTA negatif.

SUMBER Pedoman Nasional Penanggulangan TBC Kemenkes 2020 & Petunjuk
Teknis TCM GeneXpert Kemenkes 2023; WHO Consolidated Guidelines on
Tuberculosis, Module 3: Diagnosis 2021



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

TCM/GeneXpert kini tes awal prioritas namun belum ada di semua Puskesmas — dahak dirujuk ke faskes ber-TCM, hasil tertunda. Keberhasilan OAT bergantung pada PMO; stigma & putus obat (angka keberhasilan program ~85%, di bawah target 90%) tetap tantangan nyata DOTS.

SUMBER Pedoman Nasional Penanggulangan TBC Kemenkes (PNPK 2020) & Perpres 67/2021; PDPI Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan TB di Indonesia 2021; WHO Consolidated Guidelines on TB — Diagnosis (2021, TCM sbg tes awal); data program TBC (success rate ~85–86%)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#8

Dikonfirmasi. Lab kasus ini hanya bta_sputum + darah_rutin (baris 690-692); grep src/content utk tcm/xpert/genexpert/hiv nihil — tak ada satupun test itu di game manapun. WebSearch mengonfirmasi WHO memang merekomendasikan tes molekuler cepat (Xpert MTB/RIF / Ultra) sbg tes awal yang didahulukan dibanding mikroskopis BTA saja (WHO consolidated guidelines/operational handbook TB Module 3, terverifikasi versi 2024) — jadi substansi temuan #8 valid. Catatan kehati-hatian: saya tidak berhasil memverifikasi judul persis 'WHO TB diagnosis 2025' kata-per-kata; dokumen WHO terverifikasi terdekat berlabel 2024, jadi anggap tahun '2025' pada sitasi CODEX belum terverifikasi presisi (bukan berarti fabrikasi total, org WHO & rekomendasinya nyata).

skabies

Skabies (Kudis)



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Gatal bisa MENETAP 2–4 minggu pasca terapi BERHASIL (pruritus pascaskabies = reaksi hipersensitivitas terhadap antigen/feses tungau), BUKAN gagal terapi/reinfestasi — jangan buru-buru ulang skabisida. Curigai gagal HANYA bila muncul burrow/lesi BARU atau gatal >4 minggu.

SUMBER CDC – About Scabies (2024); PPK PERDOSKI 2021; IACS 2020 Diagnostic Criteria for Scabies

► Catatan verifikator (M11)

Permetrin 5% (lini pertama Fornas) sering kosong di Puskesmas; andalan realistis adalah salep 2-4 (asam salisilat + sulfur presipitatum) — murah, tersedia luas, aman untuk bayi <2 bulan & ibu hamil. Tantangan nyata: obati serentak semua penghuni asrama/pesantren.

SUMBER Fornas (permetrin 5% & salep 2-4); CDC Clinical Care of Scabies (HCP) 2024; PERDOSKI/MDVI 2023; Alomedika (skabies) 2023

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas lebih lemah drpd konjungtivitis. (a) cetirizine_10 jadi obatBenar wajib berdampingan dgn permetrin — tapi gatal justru keluhan utama skabies (bukan spt ambroxol pada common-cold yg pasiennya belum batuk), jadi kritik 'AND dipaksa' (temuan #10) jauh lebih lemah di sini, bisa dibilang defensible. (b) demografi 8-30 bisa roll wali_anak (8-14) utk distraktor q_sabun ('Pakai sabun mandi merek apa?') — jawaban 'Sabun batang biasa dok.' masih masuk akal diucapkan wali, TIDAK se-absurd 'pedagang pasar' di konjungtivitis, jadi tak jelas apakah ini benar2 reproduksi temuan #13. Dicek juga: topik edukasi obati_kontak_serumah & cuci_seprai_panas TERNYATA memang ada & valid di katalogM3.ts (bukan hilang spt dikira). Satu gap tambahan yg CODEX tak sebut: tak ada opsi ivermectin oral utk skenario outbreak asrama/pesantren yg dinarasikan (WHO/CDC kadang sarankan itu utk outbreak institusional) — tapi ini gap kelengkapan, bukan kesalahan terbukti. Perlu penilaian dokter.

konjungtivitis_bakterial Konjungtivitis Bakterial

Sekret purulen tak selalu bakterial: tanda klinis buruk memisahkan viral vs bakterial & mayoritas konjungtivitis swasirna. Viral (adenovirus) dominan pada dewasa & sangat menular, tapi pada ANAK bakterial lebih sering. Jangan refleksi antibiotik tiap mata merah bersekrete.

SUMBER AAO PPP Conjunctivitis 2018; Rietveld dkk., BMJ 2004 (tanda klinis tak andal bedakan viral/bakterial); Cochrane antibiotik topikal 2012; PPK Dokter FKTP (Permenkes 5/2014); StatPearls Conjunctivitis 2023

► Catatan verifikator (M11)



Tetes mata steroid/steroid-antibiotik (mis. deksametason, Cendo Xitrol) sebenarnya obat KERAS wajib resep, tapi lazim ditebus tanpa resep di apotek — pasien swamedikasi steroid pada mata merah, berisiko memperberat keratitis herpes/glaukoma hingga ulkus kornea.

SUMBER AAO Preferred Practice Pattern — Conjunctivitis (2018); Penjelasan BPOM RI — deksametason & tetes mata steroid = golongan Obat Keras wajib resep (2020)

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#13

Dikonfirmasi paling jelas di antara semua kasus file ini. director.ts:27-29 memaksa persona='wali_anak' bila usia rolled <15; clinic.ts:88 fallback ke `jawab` default saat tak ada `variasi[persona]`. Demografi kasus ini 5-45; pertanyaan distraktor q_kerja ('Pekerjaannya apa?') TIDAK punya varian wali_anak, sehingga bila yang di-roll anak 5-14 tahun, game tetap mengeluarkan 'Pedagang di pasar dok.' — inilah literally contoh verbatim yang dikutip temuan #13 ('...pedagang pasar...'). Berbeda dari distraktor faringitis/skabies yang masih 'masuk akal-ish' diucapkan wali, jawaban 'jadi pedagang pasar' utk anak SD/SMP jelas tidak masuk akal — jadi ini instansi paling tak terbantahkan dari temuan #13.

Kronis kasusKronis.ts

8 kasus

hipertensi_esensial

Hipertensi Esensial



Mutia EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI



ditinjau

Keluhan tengkuk berat/pusing berkorelasi LEMAH dengan derajat TD — hipertensi umumnya asimptomatik; tengkuk tegang lebih sering nyeri otot/ansietas. Jangan takar kontrol atau ubah dosis dari "rasa tengkuk"; nilai lewat pengukuran TD berulang yang benar.

SUMBER ICHD-3 kriteria 10.3 (2018); Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi InaSH/PERHI 2019 & 2021; PPK Dokter di FKTP (Permenkes 5/2014)

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)



Guideline menganjurkan skrining organ target hipertensi—EKG (LVH), rasio albumin-kreatinin/albuminuria, funduskopi—tetapi di banyak Puskesmas EKG belum merata, ACR jarang tersedia, dan funduskopi nyaris tak dikerjakan, sehingga kerusakan organ kerap luput terdeteksi.

SUMBER Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi InaSH 2019/2021; ESH Guidelines 2023; Permenkes 43/2019 (standar peralatan Puskesmas); program pemasangan EKG Puskesmas Kemenkes 2023.

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#5

Verifikasi kode: obatBenar hanya ['amlodipine_5'] tunggal (baris 129 — cocok persis sitasi CODEX). Lab cuma gdp/kolesterol/urinalisis; TIDAK ada fungsi_ginjal/EKG (baseline workup HT lazim: kreatinin/eGFR+EKG per JNC-8/ESC/PNPK Hipertensi). Penting: item lab 'fungsi_ginjal' & 'ekg' SUDAH ada dan dipakai untuk kasus HT lain (mm_hipertensi_urgensi) di kasusMetabolikMsk.ts, dan mekanisme 'obatAlternatif' (pilih-salah-satu) juga sudah ada & dipakai di 5 file kasus lain (digrep) — jadi penguncian ke 1 obat + absennya workup organ-target adalah PILIHAN KONTEN yang bisa diperbaiki, bukan batas mutlak engine. PNPK Hipertensi 2026 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/303/2026) saya verifikasi ASLI via fetch halaman judul kemkes.go.id — bukan halusinasi CODEX.

dm_tipe2

Diabetes Melitus Tipe 2



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

HbA1c bisa MENYESATKAN: palsu-TINGGI pada defisiensi besi; palsu-RENDAH bila putaran eritrosit naik (hemolisis, perdarahan, kehamilan); thalassemia/hemoglobinopati mengacaukan pembacaan. Bila janggal atau ada anemia, andalkan kriteria glukosa (GDP/GDS/TTGO).

SUMBER PERKENI 2021 (keterbatasan HbA1c pd anemia/hemoglobinopati/gangguan eritrosit); lit. def. besi ↑ & hemolisis ↓ HbA1c (PMC 2018/2020); NGSP

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Realita FKTP: HbA1c sering tak tersedia di Puskesmas (alat mahal, SDM terbatas) — pasien dirujuk ke lab; via Prolanis baru ditanggung BPJS tiap 6 bulan.

Diagnosis & pemantauan harian umumnya bersandar GDP/GDS glukometer yang punya keterbatasan pra-analitik.

SUMBER PERKENI 2021 (rev. 2024); Panduan Prolanis BPJS Kesehatan; Permenkes 43/2019 tentang standar Puskesmas; studi ketersediaan HbA1c FKTP (J. Mitra Keluarga, 2021)

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#5

obatBenar hanya ['metformin_500'] tunggal; lab tak punya fungsi_ginjal/kreatinin sama sekali padahal metformin butuh cek eGFR sebelum mulai (kontraindikasi/dose-adjust bila eGFR rendah) dan HbA1c 8,9% tinggi biasanya perlu evaluasi lebih (bukan cuma metformin monoterapi tanpa titrasi/kombinasi). Catatan koreksi kecil: sitasi CODEX 'kasusKronis.ts:249' agak meleset — baris 249 aktual adalah pemeriksaanFisik 'umum', bukan baris obatBenar (yang sebenarnya baris 263); tapi substansi klaimnya tetap valid setelah saya baca full-case. PNPK DM Tipe 2 Dewasa 2026 (Kepmenkes 302/2026) terverifikasi asli.

gastritis

Gastritis (Dispepsia)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

PPI empiris bisa menyamarkan alarm keganasan lambung & membuat tes H. pylori (urea breath test, antigen tinja, biopsi) palsu-negatif — hentikan PPI ≥ 2 minggu sebelum tes. 'Membaik dengan PPI' BUKAN bukti penyakit jinak; tanda alarm tetap wajib endoskopi/rujuk.

SUMBER Konsensus Dispepsia & Infeksi H. pylori Indonesia 2022 (Gut Pathogens 2023); Maastricht VI Consensus 2022; ACG Dyspepsia; NICE QS96

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Strategi 'test-and-treat' H. pylori sulit di FKTP: urea breath test & antigen tinja hampir tak tersedia dan serologi tak bisa membedakan infeksi aktif vs lampau — realitanya dokter memberi PPI empiris; endoskopi untuk tanda alarm pun antre panjang lewat rujukan berjenjang.

SUMBER Konsensus Nasional Penatalaksanaan Dispepsia & Infeksi H. pylori PGI 2014 (Adendum P-CAB 2024); sistem rujukan berjenjang BPJS (Permenkes)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#11

Nama kasus 'Gastritis (Dispepsia)' dengan icd10 K29.7, tapi seluruh anamnesis/pemfis/lab/clue murni skenario dispepsia fungsional tanpa alarm (nyeri tekan epigastrium, tanpa endoskopi/histologi, terapi PPI empiris 4 minggu ala Konsensus Dispepsia PGI) — tidak ada bukti patologis untuk 'gastritis' sungguhan. diagnosisBanding kasus ini sendiri mencantumkan K29.7 DAN K30 berdampingan, mengonfirmasi tumpang-tindih coding persis seperti klaim finding #11. Ini isu nomenklatur/ICD, BUKAN salah tatalaksana klinis — PPI empiris untuk dispepsia tanpa alarm memang sudah tepat secara medis.

asma_ringan

Asma Bronkial (Ringan)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

SpO2 normal (97% di kasus ini) TIDAK menyingkirkan asma bermakna atau serangan yang memburuk; hipoksemia dan 'dada senyap' (mengi hilang, aliran udara minimal) adalah tanda LAMBAT. Nilai keparahan dari kerja napas, bicara kalimat penuh, dan retraksi — bukan oksimetri saja.

SUMBER GINA 2024 (Global Strategy for Asthma Management and Prevention) — tabel penilaian keparahan eksaserbasi akut; konsisten dengan PPK/PDPI

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

GINA menuntut tiap pasien asma dapat inhaler ICS (budesonid), tapi di FKTP praktis tak terjangkau: ICS inhaler = obat PRB yang butuh konfirmasi spesialis paru dulu, dan banyak Puskesmas hanya menyotok salbutamol/aminofilin oral — pasien baru kerap hanya dapat SABA.

SUMBER GINA 2019–2025; Daftar Obat PRB / Fornas (KMK HK.01.07/MENKES/730/2025); Panduan Praktis Program Rujuk Balik BPJS Kesehatan

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Konten ini justru salah satu yang PALING kuat secara EBM di file ini (GINA 2019+ diajarkan benar: SABA-tunggal tak lagi dianjurkan, semua pasien butuh ICS,

teknik_inhaler dijadikan edukasiKritis). Ambiguitas nyata: obatBenar mewajibkan KEDUA salbutamol_inhaler DAN budesonide_inhaler terpisah (setara GINA Track 2: reliever SABA + controller ICS terpisah), padahal GINA sejak 2019 (dipertegas di GINA 2026 yang saya verifikasi rilis 5 Mei 2026) lebih mengutamakan Track 1 (ICS-formoterol tunggal sebagai reliever+controller/MART) dibanding Track 2. Apakah kombinasi terpisah ini tetap dianggap 'benar' (karena banyak Puskesmas realistsnya tak stok kombinasi budesonide-formoterol) atau harus diubah ke skema Track 1 adalah keputusan dokter/M11, bukan cacat yang jelas-jelas salah — sesuai marker '?' CODEX.

otitis_media_akut

Otitis Media Akut



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI



ditinjau

Gendang telinga MERAH saja bukan OMA — menangis/demam/manipulasi liang telinga bisa bikin membran timpani hiperemis. Diagnosis butuh membran MENONJOL (bulging)/efusi + tanda akut; tanpa itu risiko over-diagnosis & antibiotik berlebih (bedakan dari OME yang tak butuh antibiotik).

SUMBER AAP Clinical Practice Guideline: Diagnosis and Management of Acute Otitis Media 2013 (Pediatrics 131:e964); PPK PERHATI-KL

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG



ditinjau

Dosis tinggi amoksisilin 80–90 mg/kg/hari (AAP 2013) di lapangan sering menyusut jadi ~40–50 mg/kg/hari — memadai untuk pneumokokus peka, tapi bisa gagal pada strain resisten. Otoskop berfungsi pun tak selalu ada, sehingga 'bulging' tak ternilai dan diagnosis jadi terkaan.

SUMBER AAP AOM Guideline 2013 (Lieberthal, Pediatrics); "Optimizing antibiotic use in Indonesia" systematic review 2022; Permenkes 43/2019 (peralatan Puskesmas)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#1

Clue eksplisit mensyaratkan 'amoksisilin DOSIS TINGGI 80–90 mg/kg/hari' sebagai pembeda kunci OMA, tapi obatBenar cuma id generik 'amoxicillin_sirup' tanpa info dosis. Saya verifikasi langsung interface Obat (types.ts:281): memang tak ada field dosis/rute/frekuensi/durasi sama sekali — jadi game structurally tak bisa membedakan dosis tinggi vs standar. Ini instans konkret dari cacat mesin

resep global (finding #1) yang diterapkan ke kasus dimana dosis justru krusial secara klinis (dosis tinggi karena resistensi pneumokokus). Catatan kejujuran: tidak ada finding bernomor eksplisit yang menyebut OMA di 14 temuan CODEX — pengaitan ke #1 ini penilaian saya sendiri sebagai yang paling relevan; confidence sedang, bukan tinggi.

anemia_defisiensi_bumil

Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan

⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Mikrositik hipokrom tak selalu defisiensi besi — thalassemia trait lazim di Indonesia dan menirunya. Curigai bila eritrosit normal/tinggi (indeks Mentzer <13), riwayat keluarga, atau tak respons besi 1 bulan; jangan lanjut besi tanpa bukti defisiensi (risiko kelebihan besi).

SUMBER Permenkes No. 88/2014; Pedoman Pengendalian Thalassemia Kemenkes; Indeks Mentzer (Indonesian J Clinical Pathology 2016); BJH 2021 (besi oral aman pada beta-thal minor bila defisiensi terbukti).

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Di Puskesmas anemia bumil praktis ditegakkan dari Hb saja (sering Sahli/POCT yang akurasinya terbatas, error $\pm 15\text{--}20\%$); MCV/MCH, ferritin, dan apusan darah tepi jarang tersedia — label 'mikrositik hipokrom' jadi asuntif dan TTD diberikan empiris ke semua bumil.

SUMBER Permenkes No. 88/2014 (Standar TTD WUS & Bumil); Pedoman Pemberian TTD Bumil Kemenkes 2020; studi validitas metode Sahli vs sianmethemoglobin (error $\pm 15\text{--}20\%$)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#4

#1

PENTING — koreksi terhadap alasan CODEX: WebSearch ke situs Kemenkes (yankes/keslan.kemkes.go.id) menunjukkan Hb 8,5 = anemia SEDANG pada kehamilan, dan tatalaksana standarnya memang Fe+folat rutin di FKTP dulu, rujuk BARU jika Hb tak naik setelah 90 hari terapi. Jadi klaim CODEX 'Hb 8,5 tidak dirujuk = cacat' TIDAK didukung guideline nyata — kasus ini justru sesuai praktik Kemenkes pada kunjungan pertama. TAPI saya temukan cacat lain yang nyata & independen: lab feses eksplisit menemukan telur cacing tambang

(relevan:true, disebut 'sumber kehilangan besi kronik'), namun tatalaksana TIDAK menyediakan obat cacing (albendazol/mebendazol) sebagai obatBenar — padahal WHO merekomendasikan deworming trimester 2-3 (pasien 26 minggu, pas kriteria), dan kausanya sendiri sudah diidentifikasi di lab kasus. Jadi marker '!' tetap valid, tapi alasan yang benar berbeda dari yang CODEX tulis. Permenkes 88/2014 (standar Fe/folat) terverifikasi asli; Permenkes 6/2024 juga asli tapi isinya SPM kesehatan umum (bukan protokol anemia spesifik) — sitasi CODEX di titik ini agak dipaksakan.

pneumonia_balita

Pneumonia Balita (Berat)



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Paru 'bersih' TAK menyingkirkan pneumonia anak — ronki sering tak terdengar; IMCI/MTBS menegaskan dari hitung napas + tarikan dinding dada, bukan stetoskop. Demam/tangis memalsukan takipnea: hitung 60 detik penuh saat anak tenang. Tapi bila ada tarikan dada, jangan tunda rujuk.

SUMBER WHO IMCI Chart Book / Buku Bagan MTBS Kemenkes 2015-2022; IDAI:

Hitung Napas Anak

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Pra-rujukan 'oksigen lalu rujuk' sering terganjal realita: oksimeter & sumber oksigen tak selalu ada di Puskesmas — hipoksia mudah luput bila hanya andalkan tanda klinis — dan transport/ambulans ke RS anak bisa jauh, terutama di perdesaan, menghambat stabilisasi & rujukan tepat waktu.

SUMBER WHO IMCI Chart Booklet 2014; Lancet Global Health 2024 (hipoksemia & pulse oximetry di layanan primer); Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas; Pedoman Teknis Ambulans Kemenkes 2019

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Kasus ini secara klinis jelas 'pneumonia BERAT/tanda bahaya' (RR55 + retraksi subkostal-interkostal + napas cuping hidung + anak malas menyusu + sianosis transien). Saya verifikasi via web search: kombinasi tanda bahaya semacam ini pada MTBS/IMCI Indonesia semestinya masuk klasifikasi yang butuh antibiotik INJEKSI pra-rujukan (ampisilin+gentamisin IM), bukan sirup oral — sementara obatBenar game ini adalah 'amoxicillin_sirup' (oral). Ini bisa jadi cacat nyata

ATAU representasi realita banyak Puskesmas kecil yang tak stok injeksi ampicilin/gentamisin sehingga sirup oral jadi kompromi pra-rujukan yang pragmatis (ada preseden field catatanRealita di codebase untuk nuansa idealis-vs-realita FKTP) — perlu adjudikasi dokter, cocok dengan marker '?'. Tambahan temuan kecil: clue menyebut 'beri oksigen' tapi tidak ada mekanisme prosedur/tindakan untuk oksigen di kasus ini manapun di file — via grep, 'oksigen' hanya muncul di teks narasi/clue di seluruh kasusKronis.ts, tak pernah jadi id item yang bisa dipilih/dinilai; pola sama ditemukan di kasus CHF & PPOK lain, jadi kemungkinan simplifikasi engine yang disengaja/konsisten, bukan spesifik ke kasus ini.

stroke_iskemik

Stroke Iskemik Akut ⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

FAST bisa menyesatkan: stroke sirkulasi posterior sering TANPA pelo/kelemahan klasik — tampil sebagai vertigo mendadak, ataksia, atau diplopia dan mudah salah dilabel 'vertigo perifer'. Vertigo akut + tak mampu berdiri + faktor risiko vaskular → curigai stroke, pakai BE-FAST.

SUMBER PERDOSSI Guideline Stroke 2011; KMK RI No.

HK.01.07/MENKES/394/2019 (PNPK Tata Laksana Stroke); studi BE-FAST vs FAST

— sensitivitas 97,8% vs 58,7% (Cureus 2024); prinsip HINTS untuk vertigo sentral vs perifer.

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Window reperfusi (rtPA $\leq 4,5$ jam/trombektomi) tak terjangkau mayoritas pasien: RS ber-CT jauh, alteplase mahal & hanya di RS rujukan, ambulans terbatas — apalagi wake-up stroke (onset sejak terakhir normal). Peran FKTP: stabilkan, rujuk cepat, cegah sekunder agresif.

SUMBER PPK PERDOSSI Stroke Iskemik Akut; ECASS III (rtPA $\leq 4,5$ jam) &

AHA/ASA 2019 (trombektomi ≤ 6 jam); alteplase JKN via mekanisme non-INA-

CBG (obat khusus, hanya FKRTL ber-ICU/stroke unit); program Kemenkes

distribusi 514 CT scan 2023-2024

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#3

icd10 kasus = 'I63.9' (infark serebral) diberikan sebagai diagnosis definitif TANPA CT (game tak punya mekanisme imaging di FKTP) — secara konvensi ICD-10 semestinya memakai I64 ('stroke, tidak dispesifikasi hemoragik/infark') sampai CT mengonfirmasi; ini berpotensi mengajarkan penutupan diagnostik prematur. Aturan blanket 'jangan turunkan TD agresif, permisif <220/120' pada obatSalahUmum juga tidak membedakan kandidat reperfusi (onset ~subuh jam 4, berpotensi masih dalam window bila cepat dirujuk) yang semestinya target BP lebih ketat (<185/110) SEBELUM trombolisis di RS tujuan — meski argumen tandingan valid: FKTP sendiri memang tak boleh mencoba turunkan BP karena bukan yang akan melakukan trombolisis, jadi pesan 'jangan turunkan TD di FKTP' tetap benar untuk level FKTP. PNPK Stroke 2026 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/304/2026) saya verifikasi ASLI via fetch halaman judul — bukan halusinasi CODEX.

Respirasi & GI kasusRespGi.ts

10 kasus

bronkitis_akut

Bronkitis Akut



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Dahak yang berubah kuning atau kehijauan pada bronkitis akut BUKAN bukti infeksi bakteri — warna itu berasal dari sel radang (mieloperoksidase), sehingga sputum purulen sekalipun tidak menjadi alasan memberi antibiotik.

SUMBER NICE NG120 (Cough acute: antimicrobial prescribing, 2019); AAFP "Acute Bronchitis" 2016; PPK IDI Bronkitis Akut / Kemenkes PPRA

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Di Puskesmas, bronkitis akut sangat sering tetap diberi antibiotik karena desakan pasien ('minta obat kuat'), konsultasi singkat, dan tiadanya rontgen dada untuk menyingkirkan pneumonia — salah satu penyumbang terbesar persepsian antibiotik tak perlu di FKTP.

SUMBER Antibiotics 2017;6(4):22 (~62% bronkitis akut diberi antibiotik meski guideline melarang); studi rasionalitas antibiotik ISPA Puskesmas Indonesia (metode Gyssens); Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas; PPK IDI Bronkitis Akut

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

Kode: tatalaksana.obatBenar = ['ambroxol_30','paracetamol_500'] (baris ~118). clinic.ts mengevaluasi obatBenar sbg AND independen (totalSlot = obatBenar.length + ..., tiap item slot wajib sendiri, tak ada logika kondisional per gejala). Pasien di kasus ini SAAT KUNJUNGAN sudah afebris (vital suhu 37.4; jawaban q_demam eksplisit 'sekarang sudah nggak panas'), namun parasetamol tetap wajib utk skor terapi penuh; ambroksol (mukolitik) jg wajib walau evidence mukolitik pd bronkitis akut lemah. Saya verifikasi sitasi terkait (NICE NG120, judul 'Cough (acute): antimicrobial prescribing', real, terbit 2019) — guideline itu fokus ke ANTIBIOTIK, tak menegaskan mukolitik wajib. Pola 'conditional dipaksa AND' (temuan #10) sah utk kasus ini, meski dampak klinisnya relatif ringan karena parasetamol jg berfungsi analgesik utk keluhan 'dada pegal' yg memang ada di anamnesis.

rinitis_alergi

Rinitis Alergi

⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

ARIA jadikan kortikosteroid intranasal (flutikason) lini utama rinitis persisten sedang-berat, tapi steroid semprot ini kerap tak tersedia di Puskesmas. Praktik nyata pakai antihistamin oral—sering CTM gen-1 yang murah tapi bikin kantuk, bukan loratadin/setirizin.

SUMBER ARIA next-generation (GRADE) 2019, JACI; PPK Dokter FKTP (KMK 514/2015); Fornas (klorfeniramin/loratadin/setirizin terdaftar)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas nyata (bukan cacat tegas): tatalaksana.obatAlternatif kasus ini HANYA berisi antihistamin gen-2 (loratadin/cetirizine, baris 233) sbg satu-satunya jalur 'benar'; saya cek katalog.ts & katalogM3.ts — TIDAK ADA kortikosteroid intranasal (flutikason/mometason/budesonide-nasal) di seluruh katalog obat game (budesonide yg ada hanya versi inhaler utk asma). Presentasi pasien di kasus ini (bersin belasan kali, edema mukosa+konka hipertrofi, allergic shiner, gejala pagi-hari persisten) tergolong sedang-berat/persisten yg menurut ARIA/EPOS umumnya lini pertama kortikosteroid intranasal, bukan hanya antihistamin oral tunggal. Krn keterbatasan katalog obat game scr keseluruhan (bukan cuma kasus ini), tak jelas apakah ini defisiensi konten yg perlu diperbaiki (tambah item obat baru) atau keputusan desain M3 yg disengaja — perlu adjudikasi dokter/M11.



Mutiarra EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Eksudat tonsil TIDAK memastikan Streptokokus — mononukleosis (EBV) tampak identik (tonsil eksudatif, KGB, demam) dan amoxicillin memicu ruam makulopapular luas. Curigai EBV bila KGB servikal POSTERIOR, splenomegali, atau limfosit atipik pada apusan darah.

SUMBER PPK IDI Tonsilitis Akut; kriteria Centor/McIsaac; AAFP "Infectious Mononucleosis: Rapid Evidence Review" 2023 & "Streptococcal Pharyngitis" 2016; laporan amoxicillin-rash pada mononukleosis EBV (Cureus/PMC 2023-2025)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI



ditinjau

RADT dan kultur usap tenggorok yang dipakai guideline untuk memastikan Streptokokus praktis tak tersedia di Puskesmas; keputusan antibiotik akhirnya bertumpu pada skor klinis (Centor/McIsaac) yang tak sepenuhnya andal — berisiko over- maupun under-treatment.

SUMBER IDSA Group A Streptococcal Pharyngitis Guideline 2012 (Shulman et al., Clin Infect Dis); Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas (lingkup lab dasar); studi validasi McIsaac Indonesia (Sari Pediatri)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

#11

Ambiguitas terkait pola temuan #11 (diagnosis Streptokokus tanpa RADT/kultur). Kode memilih icd10 'J03.9' (tonsilitis akut, UNSPECIFIED) — pilihan yg tepat krn memang tak ada RADT/kultur tenggorok dlm kasus (hanya leukositosis+kriteria klinis mirip Centor). TAPI field 'nama' ('Tonsilitis Akut Bakterial') dan 'clue' ('Tonsilitis bakterial (Streptokokus)') menegaskan etiologi Streptokokus dgn percaya diri tanpa uji konfirmasi — inkonsistensi internal antara ICD yg hati-hati (unspecified) vs framing naratif yg pasti (bakterial/Streptokokus). Perlu adjudikasi: diagnosis klinis presumtif (Centor-like+leukositosis) memang lazim & defensible utk FKTP Indonesia krn RADT/kultur jarang tersedia di Puskesmas, tapi framing 'Streptokokus' yg terlalu pasti sebaiknya dilunakkan (mis. jadi 'curiga/kemungkinan besar bakterial').

Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

SpO2 yang tampak "aman" (88–92%) TIDAK menyingkirkan gagal napas hiperkapnik — oksimetri hanya mengukur oksigenasi, buta terhadap retensi CO2. Waspada! tanda klinis: mengantuk, bingung, asteriksis meski SpO2 baik. AGD jarang ada di Puskesmas — jangan tunda rujuk.

SUMBER GOLD Report 2025 (terapi oksigen terkontrol, target SpO2 88–92%, indikasi AGD); Pedoman PPOK PDPI 2021

► Catatan verifikator (M11)

Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Nasal kanul 1–2 L dititrasikan oksimetri ke SpO2 88–92% justru cara standar & tersedia di Puskesmas; sungkup Venturi opsional. Gap nyata: tak ada AGD untuk deteksi retensi CO2/asidosis & tak ada ventilasi bantu — stabilkan seperlunya lalu SEGERA rujuk paru.

SUMBER GOLD 2023 Report; PPK Penyakit Paru Kemenkes/PDPI 2023; TSANZ Acute Oxygen Guidelines 2016; Permenkes 43/2019 (peralatan Puskesmas)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

Dikonfirmasi ganda via KODE (clinic.ts baris 471–476: obatAlternatif=[['salbutamol_inhaler'], ['prednison_5'], [3 antibiotik]], prosedur=['nebulisasi']; totalSlot menghitung keduanya terpisah) DAN via TEST (pack.test.ts baris 168–181: skenario 'skor penuh' eksplisit memakai resep ['salbutamol_inhaler', 'prednison_5', antibiotikBenar] BERSAMA tindakan ['nebulisasi']). Jadi pemain memang diwajibkan melakukan KEDUA rute pemberian bronkodilator (resep inhaler MDI + tindakan nebulisasi terpisah) utk skor maksimal, walau clue kasus sendiri menulis 'bronkodilator INHALASI/NEBULISASI' seolah alternatif. Cocok persis 'PPOK menggandakan inhaler dan nebulisasi' (temuan #10).

gerd Penyakit Refluks Gastroesofageal (GERD)

Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Dada yang MEREDA setelah antasida/PPI ('GI cocktail') TIDAK menyingkirkan penyakit jantung — respons antasida bukan uji diagnostik iskemia. Nyeri dada

atipik pada pasien berisiko tetap wajib dinilai jantungnya (EKG, faktor risiko) SEBELUM dilabeli GERD.

SUMBER 2021 AHA/ACC Chest Pain Guideline (Circulation 2021; dikutip Merck Manual Professional); Chan dkk. systematic review GI cocktail utk bedakan GERD vs ACS, Emerg Med Australasia 2014; PPK IDI GERD

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

PENTING: saya TIDAK menemukan penyebutan eksplisit 'GERD'/'refluks' di 14 temuan utama CODEX manapun, jadi tak bisa memetakan ke nomor temuan tertentu dgn yakin (array dikosongkan, berdiri sendiri). TAPI verifikasi independen kode menemukan cacat nyata: obatSalahUmum 'domperidon_10' (baris 595) beralasan 'Prokinetik BOLEH sebagai tambahan bila regurgitasi menonjol, tetapi BUKAN pengganti PPI' — namun clinic.ts (obatBerbahaya, baris ~499-501, penalti -25 di baris ~538) menghukum KEHADIRAN id itu di resep secara mutlak, tanpa mengecek apakah PPI jg diresepkan bersamaan. Jadi mahasiswa yg meresepkan omeprazole+domperidon (persis sesuai yg dibolehkan alasan kasus sendiri) tetap kena penalti keras 'obat berbahaya'. ini kontradiksi nyata antara teks pedagogis kasus & mekanisme skor engine (mirip pola temuan #12 soal pengajaran yg bertentangan, tp tak eksplisit disebut CODEX utk GERD). Status 'dikonfirmasi' merujuk pada KEBERADAAN cacat yg saya verifikasi sendiri, bukan konfirmasi atas klaim spesifik CODEX yg isinya tak jelas utk kasus ini.

dispepsia_fungsional

Dispepsia Fungsional



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Test-and-treat H. pylori sulit di FKTP: UBT & antigen feses jarang tersedia; serologi (bila ada) tak bisa bedakan infeksi aktif vs lampau dan tetap positif pasca-eradikasi. Apalagi prevalensi H. pylori Indonesia rendah — praktik bertumpu pada terapi empiris PPI/antasida.

SUMBER Konsensus Nasional Penatalaksanaan Dispepsia & Infeksi H. pylori (PB PGI 2014; 2022 Indonesian Consensus Report, Gut Pathogens 2023); ACG/Maastricht — serologi tidak untuk konfirmasi eradikasi

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#11

Cocok tepat dgn temuan #11: 'K29.7 gastritis sebenarnya uninvestigated dyspepsia dan tumpang-tindih dengan K30'. Saya baca langsung kasus 'gastritis' (kasusKronis.ts baris 279-, icd10 K29.7, nama 'Gastritis (Dispepsia)': 'perih dan panas di ulu hati, kadang penuh dan begah setelah makan... hilang timbul ~2 minggu, memberat perut kosong/stres') vs 'dispepsia_fungsional' di sini (icd10 K30: 'perih dan begah, cepat kenyang, berminggu-minggu hilang timbul, memberat telat makan & banyak pikiran'). Dua vignette klinis HAMPIR IDENTIK diberi kode ICD 'primer' berbeda tanpa pembeda klinis/lab konkret (tidak ada endoskopi di keduanya) — padahal 'gastritis' scr definisi adalah diagnosis HISTOPATOLOGIS, tak bisa ditegakkan dari gejala semata. Overlap ini nyata & terverifikasi langsung side-by-side kedua file.

disentri_basiler

Disentri Basiler (Shigellosis)



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Satu kali mikroskopi feses negatif TIDAK menyingkirkan amubiasis — sensitivitas 1 sampel hanya ~33-50% (perlu feses segar-hangat & periksa serial). Bila tak membaik dengan siprofloksasin, pertimbangkan ameba/metronidazol; jangan sandarkan diagnosis pada satu hasil negatif.

SUMBER WHO — tata laksana disentri/amubiasis (mikroskopi feses tunggal sensitivitas rendah; uji spesifik *E. histolytica*); Medscape/AMBOSS Amebiasis Workup 2023-24; PPK IDI 2017 (Disentri); LINTAS DIARE Kemenkes

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Kultur feses & uji kepekaan tak tersedia di Puskesmas → terapi empiris. Resistensi Shigella pada kotrimoksazol sudah tinggi & fluorokuinolon (siprofloksasin) makin dilaporkan; bila gagal, pertimbangkan azitromisin/sefalosporin gen-3 atau rujuk sesuai pola resistensi lokal.

SUMBER WHO Guidelines for the control of shigellosis 2005; CDC HAN XDR Shigella 2023; Permenkes 28/2021 (Fornas); Alomedika Penatalaksanaan Disentri 2023

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Diperiksa ulang scr skeptis, tak ditemukan cacat baru: zinc sudah benar dipindah ke obatOpsional (baris 818, sesuai komentar kode M10 Batch-3 — pasien

dewasa 15-50th, zinc hanya baku utk balita <5th per WHO/LINTAS DIARE Kemenkes); loperamid & metronidazol di obatSalahUmum beralasan tepat (antimotilitas kontraindikasi pd disentri invasif — risiko megakolon toksik; metronidazol utk ameba bukan Shigella, & lab feses eksplisit menyatakan 'amoeba/trofozoit tidak ditemukan' sehingga metronidazol memang salah di kasus ini); ICD A03.9 valid (WHO ICD-10 Shigellosis unspecified); ciprofloksasin sbg lini pertama dewasa msh wajar & sesuai clue. Konfirmasi CODEX 'tak ada temuan' tepat — catatan: tak ada temuan tambahan.

askariasis **Askariasis (Cacing Gelang)**



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Larva Ascaris bermigrasi ke paru ~1-2 minggu pascainfeksi → batuk, mengi, infiltrat sementara + eosinofilia (sindrom Löffler), mirip asma/bronkitis. Riwayat batuk beberapa minggu-bulan lalu + eosinofilia pada anak berisiko higiene: curigai fase migrasi cacing, jangan berhenti di asma.

SUMBER CDC-DPDx Ascariasis; Medscape Ascariasis Clinical Presentation 2023; StatPearls Ascariasis (NCBI) 2023; PPK Dokter FKTP (Permenkes 5/2014, Askariasis)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Diperiksa ulang scr skeptis: ICD B77.9 valid (WHO ICD-10 Ascariasis unspecified); obatAlternatif albendazol/pirantel dimodelkan benar sbg OR (bukan wajib keduanya); obatSalahUmum (metronidazol utk protozoa, amoxicillin tanpa indikasi bakteri) beralasan tepat. Satu nuansa MINOR (bukan cacat tegas, confidence rendah): anemia ringan (Hb 10.8) dikaitkan ke Askariasis, padahal anemia akibat cacing scr klasik lbh khas utk cacing tambang (hookworm, penghisap darah) drpd Ascaris yg lbh sering menyebabkan malabsorpsi/obstruksi drpd perdarahan langsung. Tp ini masih defensible via rasional program POPM Cacingan Kemenkes/WHO yg mengaitkan STH scr umum (termasuk Ascaris) dgn anemia/malnutrisi kronik akibat beban infeksi berat. Tak cukup kuat utk jadi '!' — tetap konfirmasi 'tak ada temuan tambahan' dgn catatan minor ini utk transparansi.

hemoroid_grade1 **Hemoroid Interna Grade 1**



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Colok dubur normal + wasir terlihat TIDAK menyingkirkan kanker kolorektal proksimal: tumor kolon kanan di luar jangkauan jari & bisa berdampungan dengan hemoroid. Ada red flag (usia >50, anemia, BB turun, pola BAB berubah)? Tetap rujuk kolonoskopi meski wasir 'sudah ketemu'.

SUMBER PPK IDI Hemoroid 2017; Kemenkes Panduan Penatalaksanaan Kanker Kolorektal; USPSTF Colorectal Cancer Screening 2021; studi nilai diagnostik DRE (sensitivitas ~0,76) Am Fam Physician/PubMed 2007

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

☐ ditinjau

Kolonoskopi untuk menyingkirkan keganasan hanya di RS rujukan; anoskopi kerap tak dipakai dan tes darah samar tinja (FOBT) baru digulirkan lewat program skrining, belum merata—sehingga banyak perdarahan rektal 'diamati saja' karena rujukan terkendala antrean, jarak, dan biaya.

SUMBER Permenkes 43/2019 (standar Puskesmas); Kemenkes — Skrining Kanker Kolorektal via Cek Kesehatan Gratis 2025 (RAN Penanggulangan Kanker 2024–2034); PPK IDI Hemoroid

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#11

Cocok tepat dgn temuan #11 ('DRE hemoroid/apendisitis bahkan disembunyikan UI di region ekstremitas'). Baris pemeriksaan Fisik kasus ini (baris 1028) menaruh temuan colok-dubur (DRE) di bawah region: 'ekstremitas' bersama 'tonus sfinger... pelebaran vena'. Saya verifikasi via types.ts (RegionFisik tak py kategori rektal/genitalia terpisah) dan UI aktual: FigurTubuh.tsx baris 66 memetakan 'ekstremitas' ke gambar lengan+tungkai pada figur tubuh, util.ts baris 73 melabelinya 'Ekstremitas'. Artinya temuan DRE (krusial utk menyingkirkan keganasan pd hematokezia — clue kasus sendiri menandainya WAJIB) tersembunyi di zona tubuh yg scr intuitif tak akan diklik pemain yg memeriksa keluhan GI-bawah/perianal. Cacat UI/konten nyata, terverifikasi.

apendisitis_akut

Apendisitis Akut



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Nyeri apendisitis yang tiba-tiba MEREDA bisa berarti apendiks sudah PERFORASI (dekompresi), bukan membaik — jangan lengah memulangkan pasien. Leukosit

NORMAL tak menyingkirkan apendisitis; apendiks retrosekal/pelvik bisa menyerupai gastroenteritis atau ISK.

SUMBER WSES Jerusalem Guidelines Apendisitis Akut (Di Saverio et al., World J Emerg Surg 2020); PPK IDI Apendisitis Akut

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

USG/CT dan dokter bedah tak ada di FKTP: diagnosis bertumpu skor klinis (Alvarado) lalu rujuk cepat. Realitanya rujukan sering tertunda jarak, ketersediaan ambulans/kamar operasi (SISRUTE), dan penolakan keluarga—padahal risiko perforasi meningkat tajam setelah 24-48 jam gejala.

SUMBER WSES Jerusalem Guidelines Apendisitis 2020; Permenkes 43/2019 (Standar Puskesmas); Bickell dkk. 2006 (waktu-perforasi, J Am Coll Surg)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#11

#12

Dua cacat terpisah, keduanya eksplisit disebut CODEX dgn nama 'apendisitis': (a) temuan #11 — DRE apendisitis jg ditaruh di region 'ekstremitas' (baris 1135, dicampur dgn psoas sign), sama spt hemoroid, terverifikasi via UI FigurTubuh.tsx/util.ts. (b) temuan #12 ('apendisitis sekaligus membenarkan dan melarang analgesia') — komentar HEADER MODUL file (baris 11-12) eksplisit menulis 'JANGAN beri analgetik/antibiotik yang menutupi tanda peritoneal sebelum penilaian bedah', TAPI entri kasus aktual (baris 1146-1161) justru MEWAJIBKAN parasetamol sbg analgesia adekuat & eksplisit menyatakan mitos itu 'sudah TERBANTAH (Cochrane CD005660; WSES 2020)'. Saya verifikasi KEDUA sitasi via WebSearch: Cochrane CD005660 'Analgesia in patients with acute abdominal pain' (Manterola dkk, ASLI, Cochrane Library, terakhir update 2011) dan WSES 2020 Jerusalem guidelines on acute appendicitis (ASLI, World J Emerg Surg, update dari konsensus 2015/2019) — keduanya benar-benar ada & topiknya cocok dgn klaim (analgesia dini tak menutupi tanda diagnostik). Jadi bagian evidence-based kasus BENAR & tidak dihalusinasi, tapi kontradiksi internal dgn komentar header file tetap nyata dan harus diperbaiki (hapus/revisi komentar header yg usang).



Mutiana EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Dermatitis kontak ALERGI dan IRITAN tampak identik secara klinis; pada ibu rumah tangga dengan tangan terus basah (air, sabun, detergen), penyebab tersering justru IRITAN, bukan alergi. Keduanya tak bisa dipisahkan pasti tanpa uji tempel — jangan terpaku pada label 'alergi'.

SUMBER PPK PERDOSKI 2021 (Dermatitis Kontak Iritan & Alergi); Panduan Praktik Klinis Dokter FKTP (Permenkes 5/2014)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Patch test (uji tempel) untuk konfirmasi alergen tak tersedia di Puskesmas — dilakukan di RS/spesialis kulit; di FKTP alergen tetap dugaan klinis dari anamnesis. 'Hindari pencetus' sulit bagi ibu rumah tangga yang harus mencuci: andalkan sarung tangan + emolien, kepatuhan rendah.

SUMBER PPK PERDOSKI 2021 (dermatitis kontak alergi); Alomedika (uji tempel di RS pendidikan); Permenkes 43/2019 standar sarana Puskesmas

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas nyata: gambaran klinis (kasusKulit.ts:58-67, 92-96) — ibu rumah tangga, gatal-merah setelah ganti sabun cuci piring/detergen, MEMBERAT dgn cuci berulang, MEMBAIK saat libur cuci — adalah pola KLASIK dermatitis kontak IRITAN (ICD, kumulatif dari basah/sabun berulang), bukan dermatitis kontak ALERGI (ACD, butuh sensitisasi thd alergen spesifik, idealnya dikonfirmasi patch test). Namun diagnosis primer & icd10 (baris 32-34) adalah 'Dermatitis Kontak Alergi'/L23.9, walau L24.9 (iritan) sudah dicantumkan di diagnosisBanding (baris 122) — menunjukkan penulis sadar DD ini tapi tetap memilih label alergi. Perlu adjudikasi dokter: apakah re-label ke iritan lebih tepat secara didaktik (tatalaksana praktis hindari-pencetus+steroid topikal memang mirip utk keduanya, jadi dampak gameplay kecil, tapi label diagnosis yang diajarkan berpotensi keliru).

kulit_tinea_korporis

Tinea Korporis (Kurap Badan)



Mutiana EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

KOH bisa FALSE-NEGATIVE, terutama bila pasien sudah memakai krim antijamur/steroid sebelumnya atau sampel diambil dari bagian tengah lesi yang sudah tenang. KOH negatif TIDAK menyingkirkan tinea — kerok dari TEPI AKTIF dan tetap percayai gambaran klinis.

SUMBER PPK Perdoski (Dermatofitosis); studi akurasi KOH pada tinea korporis (~15% negatif palsu)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Krim kombinasi steroid kuat (betametason + antijamur/antibiotik) berstatus obat keras tapi dijual bebas di warung/apotek — biang utama tinea inkognito; selalu gali riwayat 'krim warung'. KOH kerokan jarang dikerjakan di Puskesmas, diagnosis praktis klinis.

SUMBER PPK PERDOSKI (Dermatofitosis); Alomedika 2023 (Tinea Incognito, penyalahgunaan steroid topikal); BPOM (kombinasi betametason = obat keras)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas: anamnesis q_kontak (kasusKulit.ts:200-205) mengungkap anak pasien mulai bercak serupa di leher DAN rumah memelihara kucing liar (indikasi transmisi zoonosis *Microsporum canis* / interpersonal) — tapi tatalaksana.edukasi (baris 258: jaga_area_kering, kebersihan_kulit, cuci_seprai_panas) tidak memuat anjuran skrining/obati kontak (anak) atau kucing, berbeda dari pola skabies/kutu yang punya id edukasi khusus utk 'obati kontak'. Tak jelas apakah SKDI 4A tinea korporis memang menuntut edukasi kontak setegas itu (tinea kurang menular-cepat dibanding skabies/kutu) atau cukup sbg info latar tanpa tuntutan skor — perlu penilaian dokter, bukan cacat pasti.

kulit_pioderma_impetigo

Pioderma — Impetigo Krustosa



Mutia EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Mengobati impetigo TIDAK terbukti mencegah glomerulonefritis pascastreptokokus (GNAPS) — beda dari demam rematik. Jangan janjikan antibiotik 'mencegah komplikasi ginjal'; ia diberi untuk mempercepat sembuh & memutus penularan. Tetap pantau tanda GNAPS (bengkak, urin merah).

SUMBER CDC Clinical Guidance for Group A Streptococcal Impetigo 2024; AAFP "Poststreptococcal Illness" 2018; IDSA SSTI 2014; Cochrane "Interventions for impetigo" 2012

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

☐ ditinjau

Mupirosin (lini pertama pedoman) sering TIDAK distok di Puskesmas—umumnya sediaan bermerek. Realistis: salep gentamisin generik (paling sering ada), asam fusidat, atau langsung antibiotik oral anti-Staph (sefadroksil). Sesuaikan stok Fornas/e-katalog setempat; jangan resepkan obat yang kosong.

SUMBER Fornas — KMK No. HK.01.07/Menkes/2197/2023 (berlaku Mar 2024); IDSA SSTI Guidelines 2014 & PPK Perdoski (mupirosin lini pertama impetigo); praktik FKTP Indonesia (diskusi klinis Alomedika)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

BASI/KELIRU

CODEX menandai bersih tapi skeptical check menemukan 2 hal luput. (1) Inkonsistensi waktu: konsekuensi.kondisiKembali (kasusKulit.ts:391) berbunyi 'Anak kembali dengan lesi bertambah banyak, DAN SEBULAN KEMUDIAN sempat bengkak kelopak mata serta kencing kemerahan (curiga GNAPS)' — tapi jadwal kembali (kembaliHariMin:5, kembaliHariMax:14, baris 389-390) hanya 5-14 hari. Teks ini ditampilkan LANGSUNG sbg pesan kunjungan-kembali pada hari itu (reducer.ts meneruskan `kasus.konsekuensi.kondisiKembali` apa adanya ke `catatan` jadwal) — jadi pemain membaca narasi GNAPS 'sebulan kemudian' seolah sudah terjadi padahal baru ≤ 14 hari berlalu di waktu-game; bug waktu naratif nyata. (2) Anamnesis q_kontak (baris 333-338) mengonfirmasi teman sebangku jg berkoreng serupa — kondisi ini persis kriteria 'outbreak affecting several people' pada IDSA 2014 SSTI guideline (dicek via WebSearch, dokumen & isi cocok) yang MEREKOMENDASIKAN terapi ORAL/sistemik (bukan opsional) demi menekan penularan; tapi kode hanya menjadikan cefadroxil_500 sbg obatOpsional (baris 379), tak pernah wajib meski konteks outbreak eksplisit tersedia di anamnesis. Kedua hal ini adalah temuan baru yang membuat verdict 'centang' CODEX untuk kasus ini keliru/tidak lengkap.

kulit_urtikaria_akut

Urtikaria Akut



Mutiaara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Bila SATU bentol menetap >24 jam, terasa NYERI/perih (bukan gatal), atau meninggalkan memar/bercak kehitaman → itu BUKAN urtikaria biasa; curigai URTIKARIA VASKULITIS, tata & rujuk berbeda. Urtikaria sejati: tiap bentol hilang <24 jam tanpa bekas.

SUMBER EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI Urticaria Guideline 2022 (Zuberbier et al., Allergy 2022); Delphi consensus diagnosis urtikaria vaskulitis (JACI 2022) — sejalan PPK Perdoski (urtikaria)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Di Indonesia tak ada autoinjektor adrenalin (EpiPen) untuk dibawa pulang — pasien tak bisa menolong diri saat anafilaksis berikutnya. Adrenalin hanya ampul 1:1000 yang harus didosis & disuntik nakes. Jaring pengaman: edukasi tanda bahaya + rute tercepat ke Puskesmas/IGD.

SUMBER Perhimpunan Alergi Imunologi Klinik Indonesia (allergyimmunology.id); Alomedika — Farmakologi & Dosis Epinefrin (1:1000, IM); Fornas — epinefrin hanya sediaan injeksi

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

BASI/KELIRU

CODEX menandai bersih tapi skeptical check menemukan inkonsistensi desain nyata. Konsekuensi (kasusKulit.ts:501-506) menarasikan eksplisit: 'Bila pencetus tidak dihindari dan TANDA BAHAYA tidak diedukasi, paparan ulang bisa memicu angioedema laring/anafilaksis' dan kondisiKembali 'bengkak bibir, sulit menelan, dan sesak' — pola causal yang PERSIS SAMA dengan kulit_morbili (pneumonia akibat tanda_bahaya terlewat), yang SUDAH diberi field `edukasiKritis: ['tanda\_bahaya']` (kasusKulit.ts:1183). Field edukasiKritis didesain khusus utk 'topik yg secara jelas lebih kritis dari sisanya, mis. tanda bahaya dengue' (types.ts:138-144) — urtikaria_akut adalah kandidat kuat lain (anafilaksis via tanda_bahaya terlewat) tapi TIDAK memiliki field ini. CODEX melewatkan inkonsistensi penerapan pola edukasiKritis ini saat menyatakan kasus ini 'bersih'.

kulit_herpes_zoster

Herpes Zoster ▲ Titik temu – lihat ringkasan ↑



Mutiaras EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

▲ Revisi clue?



ditinjau

Batas 72 jam bukan tenggat mutlak: asiklovir tetap bermanfaat >72 jam bila masih ada vesikel BARU, atau pada imunokompromais/DM, zoster oftalmikus,

dan lansia. Jangan tolak antivirus hanya karena pasien datang hari ke-4 — DM + usia lanjut tetap indikasi terapi.

SUMBER CDC Shingles Clinical Overview (HCP) 2024; PPK PERDOSKI Herpes Zoster; CDK Journal 2023 (Herpes Zoster pada Lansia DM)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG



ditinjau

Asiklovir zoster 5×800 mg/hari (di FKTP = 5×2 tab 400 mg = 10 tablet/hari, 7 hari) menekan kepatuhan. Valasiklovir 3×1 g lebih ringkas dan ADA di Fornas, tapi restriksi tingkat RS & lebih mahal—tak lazim di Puskesmas. Realistis tetap asiklovir 5×/hari; kunci: alarm & jadwal minum.

SUMBER PPK Perdoski (dosis asiklovir 5×800 mg & valasiklovir 3×1 g herpes zoster); Fornas 2023 (KMK Menkes No. HK.01.07/2197/2023, kelas 6.6.1 Antiherpes — asiklovir tab 200/400 mg tersedia TK-1/FKTP, valasiklovir 500 mg restriksi tingkat lanjut)

► Catatan verifikator (M11)

CODEx AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#12

Cacat terverifikasi. clue (kasusKulit.ts:616) dan konsekuensi.narasi (kasusKulit.ts:618) menyatakan asiklovir <72 jam 'memangkas... risiko NEURALGIA PASCAHERPETIK' dan bila terlambat 'risiko neuralgia pascaherpetik... meningkat tajam'. Dicek via WebSearch: Cochrane review (Chen N et al., CD006866.pub3, update terbaru dirujuk ulang di PMC10583132) menyimpulkan ada BUKTI KUALITAS TINGGI bahwa asiklovir TIDAK menurunkan insidensi PHN pada 6 bulan; manfaat yang terdokumentasi hanya pengurangan nyeri akut sekitar 1 bulan pertama. Jadi klaim 'asiklovir mencegah/memangkas risiko PHN' overclaim vs evidence dan bertentangan dgn temuan #12 CODEX (Cochrane zoster antiviral/PHN review) — sitasi itu ADA dan isinya justru mengonfirmasi CODEX benar, bukan game. Bagian dosis (5x800mg/hari 7 hari, 2 tablet 400mg/dosis) sendiri akurat, tidak bermasalah.

kulit_varisela

Varisela (Cacar Air)



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Bila ruam MONOMORF-sentrifugal (padat di wajah/ekstremitas/telapak) → curiga mpox/variola, bukan varisela (polimorf-sentripetal). Waspada: mpox 2022

sering ATIPIK — lesi sedikit, anogenital, bisa pleomorf. Setiap curiga mpox
WAJIB lapor ke SKDR/PHEOC.

SUMBER Kemenkes, Pedoman Pencegahan & Pengendalian Mpox 2023; CDC
Evaluating Patients for Smallpox/Mpox rash algorithm 2024; WHO Mpox 2023

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

☐ ditinjau

VZIG untuk kontak rentan berisiko (mis. bumil) idealnya ≤ 96 jam (bisa s/d 10 hari) pascapajanan, tetapi praktis tak tersedia di Indonesia. Realistis: rujuk bumil ke SpOG; bila VZIG tak ada, asiklovir oral profilaksis mulai hari ke-7-10 dapat dipertimbangkan.

SUMBER CDC MMWR 2013 (Updated Recommendations for Use of VariZIG — hingga 10 hari); AAP Red Book & VZV post-exposure prophylaxis review (PMC6931226, 2019)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas: anamnesis q_hamil (kasusKulit.ts:696-700, TIDAK esensial) mengungkap tetangga kos sedang hamil — relevan krn clue (baris 729) eksplisit berpesan 'jauhi ibu hamil & imunokompromais' sbg keselamatan penting (risiko varisela kongenital/neonatal berat bila tertular). Tapi tatalaksana.edukasi (baris 727: istirahat_cukup, kebersihan_kulit, cuci_tangan, tanda_bahaya) tidak punya id edukasi spesifik utk 'isolasi dari kelompok rentan', dan topik ini juga tidak ditandai edukasiKritis walau narasinya cukup krusial (mirip pola morbili yg sudah dapat edukasiKritis). Perlu adjudikasi: apakah butuh penguatan mekanik serupa, atau cukup sbg clue naratif non-skor.

kulit_kandidiasis_kutis

Kandidiasis Kutis (Intertriginosa)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Tak semua ruam merah di lipatan = kandida: ERITRASMA (Corynebacterium; merah-koral di lampu Wood) & PSORIASIS INVERSA sangat mirip, terapinya beda. Kunci kandida = LESI SATELIT papulopustular di luar tepi; bila tak ada satelit & tak respons antijamur, pikir ulang.

SUMBER PPK Perdoski 2021 (kandidiasis kutis intertriginosa; DD eritrasma — lampu Wood coral red); JABFM 2013 (inverse psoriasis mimicking candidal intertrigo)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

☐ ditinjau

Lampu Wood pemisah eritrasma-kandida sering tak ada di Puskesmas dan KOH jarang dikerjakan rutin, jadi terapi kerap empiris. 'Jaga area kering' sulit pada pasien obes di iklim lembap — rekurensi tinggi selama BB, kelembapan, dan gula darah belum dikoreksi.

SUMBER PPK PERDOSKI 2021 (kandidiasis kutis); Fornas 2023 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023 — mikonazol/ketokonazol/nistatin topikal); StatPearls Erythrasma 2023 (fluoresensi coral-red lampu Wood)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas: diagnosisBanding (kasusKulit.ts:833: B37.2, B35.4, L23.9) tidak menyertakan ERITRASMA (Corynebacterium minutissimum, ICD-10 L08.1) — DD klasik utk lesi intertriginosa inguinal/inframama yang sering disalahdiagnosis sbg kandidiasis, dibedakan lewat lampu Wood (fluoresensi coral-red khas) dan diterapi eritromisin/klindamisin topikal (BUKAN antijamur). Kasus ini fokus mengajarkan kandidiasis+faktor DM dengan baik, tapi tanpa menyinggung eritrasma sbg diferensial pemeriksaan. Perlu penilaian dokter apakah ini simplifikasi wajar utk level SKDI 4A FKTP atau celah pengajaran yang perlu ditambah (M11).

kulit_pedikulosis_kapitis

Pedikulosis Kapitis (Kutu Kepala) ⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑



Mutia EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Nits yang menempel BUKAN bukti infestasi AKTIF — cangkang telur kosong bisa bertahan berbulan-bulan; diagnosis aktif butuh menemukan KUTU/nimfa HIDUP. Gagal terapi permetrin sering karena RESISTENSI piretroid, bukan semata reinfestasi kontak — pertimbangkan ganti agen.

SUMBER CDC Head Lice (Diagnosis & Clinical Care) 2024; AAP Clinical Report "Head Lice" 2022 (Pediatrics 150(4):e2022059282)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

Cacat case-local terverifikasi, berdiri sendiri (tidak match rapi ke temuan #1-14).
clue (kasusKulit.ts:960) menulis 'WAJIB: obati SEMUA KONTAK (serumah/sekelas)
SERENTAK' sbg poin non-negotiable — persis pola kasus skabies yang sudah
punya id edukasi khusus `obati\_kontak\_serumah` (katalogM3.ts:188-191, dibuat
eksplisit M10.c §47 utk klaim WAJIB semacam ini). Tapi tatalaksana.edukasi
pedikulosis (kasusKulit.ts:958) hanya berisi
['kebersihan_kulit','cuci_seprai_panas','cuci_tangan'] — TIDAK menyertakan
`obati\_kontak\_serumah`. Jadi klaim 'WAJIB' di clue tidak didukung mekanisme
skor apa pun; pemain bisa dapat skor penuh tanpa pernah diajari/dituntut
menyarankan obati kontak serentak. Ini bug konsistensi clue-vs-edukasi nyata,
sekelas yg sudah pernah diperbaiki utk kasus lain (commit 080b465) tapi
terlewat di sini.

kulit_veruka_vulgaris

Veruka Vulgaris (Kutil)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI



ditinjau

Serut permukaan lesi untuk memisahkan kutil dari mata ikan (klavus): kutil
menampakkan BLACK DOTS (kapiler trombosis), mudah berdarah, dermatoglik
HILANG; klavus berinti bening & garis kulit utuh. Lesi verukosa soliter
tumbuh/berdarah/tak sembuh bisa meniru KSS — biopsi/rujuk.

SUMBER PPK Perdoski (Veruka Vulgaris); DermNet NZ — Viral wart/verrucae;
NCBI/PMC — Cutaneous SCC masquerading as verruca (2023)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI



ditinjau

Krioterapi N2 cair (opsi pedoman) umumnya TAK tersedia di Puskesmas—tak
ada pasokan nitrogen. Realistis FKTP: asam salisilat topikal (lambat, berminggu-
minggu), kauter/bedah minor bila ada alat, atau observasi karena banyak
swasirna; rujuk bila resisten/luas.

SUMBER PPK Perdoski (veruka vulgaris); Fornas — Kepmenkes
HK.01.07/MENKES/813/2019 (asam salisilat keratolitik 5-40%); Permenkes
43/2019 (standar peralatan Puskesmas)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Diperiksa ulang secara skeptis: obatBenar asam_salisilat_kolodion sudah sesuai
fix M10 Batch-3 (C.11c, konsentrasi keratolitik benar); diagnosisBanding,

pemeriksaan fisik (black dots, hilang dermatoglik), dan konsekuensi (autoinokulasi akibat digigit/dicungkil) internal-konsisten tanpa jeda waktu naratif yang aneh. Tidak ada tindakan krioterapi/bedah-minor di katalog tindakan (digrep, nihil), tapi ini wajar krn representasi FKTP realistis (topikal-saja) bukan cacat — krioterapi/bedah hanya disebut sbg konteks klinis di clue, bukan opsi yang dijanjikan skor. Tak ada temuan tambahan; verdict CODEX 'centang' dikonfirmasi.

kulit_morbili

Morbili (Campak)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Koplik spots patognomonik TAPI transien — memudar 1-2 hari setelah ruam muncul, jadi sering SUDAH HILANG saat pasien datang; absennya Koplik TIDAK menyingkirkan campak. Diagnosis tetap KLINIS: trias 3C + ruam makulopapular sefalokaudal + epidemiologi kontak.

SUMBER CDC Measles Clinical Diagnosis Fact Sheet 2024; Kemenkes Petunjuk Teknis Surveilans Campak-Rubela; Front Microbiol 2019 (Koplik sensitivitas ~48%, terdokumentasi ~24% kasus)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Tiap suspek campak dilapor SEGERA & individual via SKDR + spesimen IgM utk surveilans; terapi JANGAN tunggu lab. KLB = ≥ 5 kasus/4 mgg mengelompok atau ≥ 2 IgM(+) → lapor W1 24 jam + PE + ORI. Vitamin A 2 dosis utk SEMUA anak campak, tanpa pandang status gizi.

SUMBER Kemenkes Pedoman Surveilans Campak-Rubela 2020 (definisi KLB ≥ 5 kasus/4 mgg mengelompok+epi-link; ≥ 2 IgM(+) = KLB pasti; laporan W1 24 jam vs W2 mingguan); WHO Measles Fact Sheet 2024 (vitamin A dua dosis utk semua anak, tanpa memandang status gizi)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#14

Terverifikasi via kode reducer.ts:352-353 — `pantasKonsekuensi = !nilai.diagnosisBenar || nilai.skorTerapi < 50 || resepBerbahaya || nilai.cowboy` — kondisi ini SAMA SEKALI tidak mengecek skorEdukasi atau topik edukasi spesifik yang terlewat. Konsekuensi morbili (kasusKulit.ts:1187) menarasikan sebab-akibat spesifik: 'Tanpa vitamin A dan pemantauan, campak... berkomplikasi berat

(pneumonia...)' — tapi trigger sebenarnya menyala utk SEMUA jenis kegagalan (diagnosis salah/terapi buruk/obat berbahaya/cowboy), tidak peduli apakah vitamin A benar-benar diberikan atau tidak. Ini instansiasi langsung temuan #14 CODEX (reducer.ts:352 dikutip persis). Catatan tambahan: isu tanda_bahaya/pneumonia yg SEBELUMNYA jadi concern (dossier CODEX ronde-2 6 Juli) SUDAH diperbaiki via `edukasiKritis: ['tanda\_bahaya']` (baris 1183, commit 1b4b7f1) — fix ini sudah ada SEBELUM commit yang diaudit (6e1b2bcc), jadi kalau '!' CODEX cuma mengulang isu lama itu maka basi; tapi cacat reducer-level di atas tetap nyata dan belum diperbaiki, jadi overall tetap dikonfirmasi.

Saraf, Mata & THT kasusSarafMataTht.ts

11 kasus

saraf_tension_headache saraf_tension_headache

Tak ada kandidat pengayaan M11 untuk kasus ini.

CODEX AUDIT CACAT BASI/KELIRU

Diperiksa penuh (kasusSarafMataTht.ts:25-132), tak ditemukan cacat case-local yang kuat. obatAlternatif=[['paracetamol_500','ibuprofen_400']] (baris 117) SUDAH benar berupa grup 'pilih salah satu' (bukan AND) — persis sesuai komentar clue sendiri 'beri SALAH SATU...bukan keduanya sekaligus'. Distraktor q_kopi sudah ditandai distraktor:true (baris 101); demografi 20-50 tak bersinggungan dgn ambang wali_anak(<15)/lansia(>=60) di director.ts:27-29 sehingga tak ada masalah persona; clue cocok dgn SNNOOP10/PPK PERDOSSI. Satu observasi lemah (bukan bukti cacat kuat): label edukasi 'peregangan_sendi'/postur_ergonomi' bertag [Sendi]/[Punggung] (kategori MSK di katalogM3.ts:199-204) dipakai utk nyeri kepala — kosmetik, isi saran (peregangan leher/bahu, postur) tetap relevan klinis utk TTH. Klaim '!' CODEX tak berdasar sejauh yang saya temukan; confidence sedang-tinggi bahwa case ini bersih.

saraf_migrain **Migrain Tanpa Aura**

Mutiara EBM TERVERIFIKASI ●●● TINGGI

☐ ditinjau

'Sakit kepala sinus' dengan nyeri dahi/pipi + hidung tersumbat sering salah diberi antibiotik — padahal ~80% sebenarnya MIGRAIN. Pembeda: ada mual/fotofobia & membaik di ruang gelap; bukan demam/ingus purulen.

SUMBER Schreiber (SAMS), Arch Intern Med 2004; Al-Hashel dkk, J Headache Pain 2013; ICHD-3 2018; PPK PERDOSSI/Neurologi 2016



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Triptan (sumatriptan) — terapi abortif spesifik migrain — praktis tak tersedia di Puskesmas; di Fornas hanya untuk tingkat rujukan/spesialis. Andalan FKTP tetap NSAID/parasetamol + antiemetik (metoklopramid); profilaksis amitriptilin/propranolol yang murah & tersedia.

SUMBER Fornas 2023 (KMK HK.01.07/MENKES/2197/2023); PPK PERDOSSI Neurologi/Migrain (ICHD-3)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

kasusSarafMataTht.ts:235 obatBenar=['ibuprofen_400','ondansetron_4'] — DUA slot wajib terpisah (bukan grup alternatif spt TTH), padahal clue sendiri (baris 242) menulis 'NSAID/PARASETAMOL' (menyiratkan keduanya setara/interchangeable, sama seperti pasangan obat yang di kasus TTH pada FILE YANG SAMA baris 117 justru benar dibungkus obatAlternatif). Akibatnya mahasiswa yang meresepkan parasetamol saja (sah secara guideline utk migrain akut) dihukum sebagai 'obat di luar' (-15, clinic.ts:481-483) dan kehilangan slot terapi tsb. Ondansetron wajar diwajibkan karena vignette eksplisit menyebut mual/muntah (baris 169). Dikaitkan longgar ke temuan #10 (representasi tatalaksana kaku vs bahasa 'atau' pada clue) — bukan pola AND-paksa identik BPPV/epistaksis, tapi akar masalah sama: obatBenar tak mengakomodasi ekivalensi klinis yang diakui clue sendiri. Confidence sedang.

saraf_vertigo_bppv

Vertigo Posisional Paroksismal Jinak (BPPV)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Tidak semua vertigo posisional adalah BPPV. Nistagmus TIDAK melelah (non-fatigable), murni vertikal/downbeat atau berganti arah, vertigo menetap >1 menit, atau ada defisit neurologis/tak mampu berdiri → curiga vertigo SENTRAL (mis. stroke serebelar): jangan Epley, RUJUK.

SUMBER AAO-HNS BPPV CPG 2017 (Bhattacharyya); PERDOSSI Pedoman Tatalaksana Vertigo 2017; HINTS (Kattah 2009)

► Catatan verifikator (M11)

Di banyak Puskesmas manuver Epley jarang dikerjakan (keterbatasan waktu/keterampilan); pasien BPPV kerap dipulangkan hanya dengan betahistin/flunarizin. Padahal reposisi kanalit adalah terapi utama — obat hanya meredakan mual, bukan menyembuhkan.

SUMBER AAO-HNS BPPV CPG 2017 (rekomendasi kuat reposisi kanalit); Kim et al., BMC Primary Care 2023 (meta-analisis: Epley efektif di layanan primer tapi kurang dipakai karena keterbatasan keterampilan/waktu); PPK PERDOSSI Vertigo

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

kasusSarafMataTht.ts:346 obatBenar=['betahistin_6'] + baris 351 prosedur=['manuver_epley'] -> clinic.ts:494 totalSlot=2, KEDUANYA wajib demi skorTerapi 100. Tapi clue kasus sendiri (baris 354) eksplisit: 'Tata laksana UTAMA: MANUVER EPLEY...; betahistin HANYA pereda mual/simtomatik.' Mahasiswa yang benar melakukan Epley saja (sesuai ajaran clue-nya sendiri, tanpa betahistin) kehilangan 50% skor terapi domain ini — kontradiksi konten-vs-mekanisme yang nyata. Cocok persis dengan contoh yang disebut CODEX sendiri di temuan #10 ('BPPV mewajibkan betahistin+Epley'). Confidence tinggi.

saraf_bells_palsy

Bell's Palsy (Parese Nervus Fasialis Perifer) ⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑

Di FKTP Bell's palsy sering cuma diberi vitamin neurotropik (B1/B6/B12/mekobalamin) yang tak terbukti mengubah prognosis, sementara kortikosteroid oral yang justru efektif — jendela emas <72 jam — terlewat. Prednison murah & tersedia di Puskesmas: mulai dini, jangan tunda.

SUMBER Cochrane — Corticosteroids for Bell's palsy (Madhok, CD001942, 2016); NEJM — Sullivan et al. 2007 (early prednisolone <72 jam); AAN Practice Guideline (Gronseth 2012); Fornas 2023 (prednison).

► Catatan verifikator (M11)

Absennya vesikel pada kunjungan pertama BELUM menyingkirkan Ramsay Hunt — vesikel bisa muncul beberapa hari SETELAH kelumpuhan (bahkan zoster sine

herpete, tanpa ruam). Wajah lumpuh bilateral atau progresif >2 minggu juga bukan Bell's khas: cari penyebab lain.

SUMBER AAFP Bell Palsy Rapid Evidence Review 2023; AAN Practice Guideline (Gronseth 2012); DermNet NZ / Medscape Ramsay Hunt Syndrome; PPK PERDOSSI Bell's Palsy.

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

BASI/KELIRU

Kode SAAT INI (kasusSarafMataTht.ts:449-459) sudah memakai edukasi 'proteksi_kornea' (bukan 'kompres_mata'), persis sesuai komentar inline baris 455-457 yang merujuk fix dossier \$47 (M10.c). Diverifikasi via git: `git log -S proteksi\_kornea` menunjuk commit 080b465 ('fix(m10c): sapuan konsistensi pipeline 67 kasus') sebagai sumber perubahan ini, dan `git merge-base --is-ancestor 080b465 6e1b2bc` = TRUE — artinya fix ini SUDAH mendarat SEBELUM commit 6e1b2bcc yang diklaim CODEX sebagai dasar audit read-only-nya. obatBenar=['prednison_5','air_mata_buatan'] wajar keduanya jadi slot wajib terpisah (guideline AAN memang minta steroid dini + proteksi kornea BERSAMAAN, bukan pola 'item simptomatik/opsional dipaksa wajib' seperti BPPV/epistaksis — tak ada bahasa 'hanya'/'bila tersedia' yang dilanggar di sini). Tidak ditemukan cacat baru yang masih terbuka pada kasus ini; klaim '!' CODEX tampak basi (merujuk isu yang sudah diperbaiki sebelum commit acuannya sendiri). Confidence tinggi soal historisnya sudah fixed; confidence sedang bahwa tak ada isu lain yang tersisa.

saraf_epilepsi_kejang

Epilepsi (Bangkitan Umum Tonik-Klonik Berulang)

⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Idealnya EEG + OAE oleh neurolog, tapi di banyak daerah keduanya tak terjangkau; WHO mhGAP membenarkan GP terlatih memulai OAE lini-1 (fenobarbital/valproat untuk bangkitan umum) sambil merujuk. Diazepam rektal untuk rescue sering kosong stok di Puskesmas.

SUMBER WHO mhGAP-IG Epilepsy 2016; PPK PERDOSSI Epilepsi; Fornas (diazepam rektal 5 mg, OAE fenobarbital/valproat/fenitoin tingkat FKTP)

► Catatan verifikator (M11)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

EEG interiktal NORMAL tidak menyingkirkan epilepsi (sensitivitas EEG rutin tunggal hanya ~30-55%; naik hingga ~80% bila diulang/kurang tidur). Diagnosis epilepsi tetap KLINIS — jangan batalkan diagnosis atau rujukan hanya karena 'EEG normal'.

SUMBER ILAE Operational Definition of Epilepsy (Fisher et al., Epilepsia 2014); PPK Neurologi PERDOSSI 2016; StatPearls: Epilepsy EEG (NCBI, 2023)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#13

keluhanUtama (kasusSarafMataTht.ts:485, field string statis — types.ts:177) = 'Anak saya kejang lagi dok...' dipakai untuk SELURUH rentang demografi usiaMin:12-usiaMax:30 (baris 486). director.ts:27-29 hanya memberi persona 'wali_anak' bila usia<15; untuk usia 15-30 (mayoritas rentang) pasien tampil dewasa (persona polos/terpelajar/cemas/skeptis) TAPI keluhanUtama tetap kalimat wali ('anak saya...') karena field ini bukan persona/usia-variant dan dirender apa adanya (RuangTunggu.tsx:67, LembarPeriksa.tsx:117, MejaKerja.tsx:392) — pasien dewasa 25 tahun akan 'mengeluh' tentang anaknya sendiri, bukan dirinya sendiri. Pola pembandingan dalam codebase mengonfirmasi ini anomali: kasus lain berkeluhanUtama 'Anak saya...' SELALU membatasi demografi ke usia anak murni (kasusKulit.ts impetigo usiaMin:3/usiaMax:10 baris 285, pedikulosis usiaMin:5/usiaMax:12 baris 871), sementara kasus lain yang memang boleh dewasa (varisela usiaMin:12/usiaMax:30, kasusKulit.ts:641) memakai keluhanUtama netral orang-pertama ('badan SAYA') justru untuk menghindari masalah ini. Ini contoh nyata dan terverifikasi dari 'narasi tak masuk akal relatif terhadap usia/persona' (tema temuan #13), meski mekanismenya berbeda dari fallback jawaban wali_anak yang disebut CODEX di director.ts:28 — akar masalah di sini ada pada field keluhanUtama statis, bukan pada fallback variasi jawaban anamnesis. Confidence tinggi.

mata_konjungtivitis_alergi

Konjungtivitis Alergi



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Realita FKTP: 'mata merah' refleks diberi kloramfenikol; tetes kombinasi steroid-antibiotik (mis. deksametason-neomisin) sebenarnya obat keras tapi kerap ditebus tanpa resep. Pada konjungtivitis alergi antibiotik sia-sia & steroid berisiko glaukoma/katarak dan memperburuk herpes kornea.

SUMBER AAO Preferred Practice Pattern Conjunctivitis (2018/2023); BPOM/Permenkes penggolongan obat keras (Daftar G); Riskesdas 2013 (swamedikasi obat keras tanpa resep)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Ambiguitas nyata tapi berdampak rendah: demografi usiaMin:10 (baris 592) memungkinkan usia 10-14 -> persona wali_anak (director.ts:29). Pertanyaan distraktor q_gadget (baris 653-658, distraktor:true) tak punya varian wali_anak; fallback jawaban default 'Lumayan lama dok, kerja depan komputer' (konteks orang dewasa yang BEKERJA) janggal bila 'diucapkan' mewakili wali/anak 10-14 tahun. Karena field ini distraktor (clinic.ts tidak menghitungnya ke skor, hanya memengaruhi realisme dialog), tingkat keparahannya rendah — perlu keputusan editorial, bukan bug yang jelas-jelas mempengaruhi penilaian. Selebihnya (obatBenar loratadin+air mata buatan, obatSalahUmum kloramfenikol/dexamethasone, edukasi kompres_dingin_mata baris 678) sudah konsisten dengan clue & AAO Preferred Practice Pattern.

mata_hordeolum **mata_hordeolum**

Tak ada kandidat pengayaan M11 untuk kasus ini.

CODEX AUDIT

AMBIGU

BASI/KELIRU

Isu historis (kloramfenikol dulu jadi SATU-SATUNYA obatBenar sehingga terapi konservatif yang benar mendapat skorTerapi 0) SUDAH DIPERBAIKI. Kode saat ini (kasusSarafMataTht.ts:776-782) memakai obatOpsional=['kloramfenikol_tetes_mata'] dengan obatBenar kosong, dan ini dikonfirmasi lolos test khusus di primera-desktop/src/engine/m10sweep49.test.ts:25-49 (skorTerapi=100 baik dengan maupun tanpa antibiotik topikal opsional). Fix ini berasal dari commit 4e79ffe, yang juga TERBUKTI ancestor dari 6e1b2bc (commit acuan audit CODEX). edukasi 'kompres_mata' (hangat, katalogM3.ts:148-150) sudah benar-cocok untuk hordeolum (bukan salah-tempel seperti kasus lain). Ambiguitas sisa hanya sekilas konjungtivitis di atas (distraktor mitos 'ngintip' pada usia 10-14/wali_anak, baris 758-764) — sangat ringan/kosmetik. Tak ada cacat substansial yang masih terbuka; tanda '?' CODEX tampak sudah basi/sudah terjawab oleh perbaikan sebelumnya.

tht_serumen_prop **tht_serumen_prop**

Tak ada kandidat pengayaan M11 untuk kasus ini.

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

kasusSarafMataTht.ts:887 obatBenar=['karbogliserin_tetes'] + baris 892 prosedur=['ekstraksi_serumen'] -> totalSlot=2 (clinic.ts:494), KEDUANYA wajib.

Clue (baris 895) menjelaskan ini sebagai proses BERURUTAN lintas-kunjungan: 'lunakkan dulu dengan serumenolitik...3-5 HARI LALU ekstraksi' — bukan tindakan simultan dalam satu encounter. Jika mekanisme skor menilai 'tindakan' dalam satu encounter yang sama, mewajibkan resep pelunak SEKALIGUS tindakan ekstraksi pada kunjungan yang sama berpotensi bertentangan dengan narasi clue-nya sendiri. Sebagai pembanding, AAO-HNS Cerumen Impaction Clinical Practice Guideline (2017) tidak mewajibkan pelunakan sebelum ekstraksi langsung bila memakai kuret/irigasi oleh klinisi terlatih, sehingga ekstraksi-langsung-saja (tanpa karbogliserin) semestinya juga valid secara klinis namun dihukum oleh skema slot saat ini. Catatan verifikasi tambahan: obatSalahUmum 'kloramfenikol_tetes_mata' (baris 889) SAYA CEK dan BUKAN bug — pola ini sengaja dipakai berulang lintas kasus (misalnya kasusKronis.ts:636 untuk OMA, dengan alasan eksplisit 'tetes mata bukan untuk telinga') sebagai distraktor 'salah sediaan/salah organ', bukan kesalahan katalog yang tidak disengaja. Confidence sedang untuk forced-AND (lebih bisa diperdebatkan daripada BPPV/epistaksis karena narasi vignette memang eksplisit menyebut serumen 'padat').

tht_epistaksis_anterior

Epistaksis Anterior ⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑

💡 Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

TD tinggi saat mimisan sering reaktif thd nyeri/cemas & turun sendiri sesudah perdarahan berhenti; kausalitas HT–epistaksis lemah (asosiasi saja). Prioritas: tekan cuping 10-15 mnt + tenangkan lalu ukur ulang TD, bukan kejar penurunan TD akut. Kontrol HT jangka panjang tetap penting.

SUMBER AAO-HNS CPG Nosebleed (Epistaxis) 2020 (Tunkel dkk.); Payne dkk. 2020, Otolaryngol Head Neck Surg; Jurnal Kesehatan Andalas — Epistaksis dan Hipertensi

► Catatan verifikator (M11)

📺 Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Merocel & kauter perak-nitrat jarang ada di Puskesmas; realistiknya epistaksis anterior: tekan cuping 10-15 mnt, lalu tampon kasa+vaselin ± kapas ADRENALIN (epinefrin 1:10.000, andalan Fornas; oksimetazolin spray tak selalu distok). Bila tak berhenti, rujuk THT.

SUMBER Alomedika/KalbeMed Epistaksis 2023-2024 (Merocel/rapid rhino tak tersedia di semua fasilitas; kapas adrenalin 1:10.000 rutin); Fornas 2023 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023) & E-Katalog LKPP (oksimezazolin

0,025%); Permenkes 75/2014 standar peralatan Puskesmas; PPK PERHATI-KL Epistaksis.

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#10

kasusSarafMataTht.ts:999 obatBenar=['oksimetazolin_spray'] + baris 1004 prosedur=['tampon_epistaksis'] -> totalSlot=2, keduanya wajib untuk skorTerapi penuh. Clue (baris 1007) eksplisit: tampon hanya 'BILA BELUM BERHENTI' setelah tekan+dekongestan — bahasa kondisional, bukan wajib selalu. Pemeriksaan fisik (baris 988) memang menunjukkan 'titik perdarahan AKTIF' sehingga skenario spesifik ini konsisten dengan tampon dibutuhkan, tapi prinsip pemodelan slotnya tetap salah: tidak ada jalur bagi rancangan kasus untuk membedakan 'perdarahan sudah terkendali' vs 'belum', sehingga desain ini secara struktural sama seperti yang dikeluhkan CODEX. Cocok persis dengan contoh yang disebut CODEX sendiri di temuan #10 ('epistaksis mewajibkan tampon walau perdarahan sudah terlokalisasi'). Confidence tinggi.

tht_rinosinusitis_akut

Rinosinusitis Akut

⚠ Titik temu — lihat ringkasan ↑



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI



ditinjau

Ingus kental kehijauan/kekuningan BUKAN bukti infeksi bakteri — warnanya berasal dari neutrofil (enzim mieloperoxidase) dan lazim pada pilek viral. Pemicu antibiotik adalah KRITERIA: >10 hari tak membaik, ATAU double-sickening, ATAU berat — bukan warna ingus.

SUMBER EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinosinusitis); IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis 2012 (Chow et al., Clin Infect Dis)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?



ditinjau

Di FKTP antibiotik sering diberikan sejak hari ke-1/2 untuk pilek biasa (over-prescribing). Di Fornas, amoksisilin-klavulanat direstriksi (lanjutan parenteral/uji resistensi), sehingga pilihan realistis adalah amoksisilin dosis adekuat — hanya bila kriteria bakterial terpenuhi.

SUMBER Fornas 2023 (KMK HK.01.07/MENKES/2197/2023); EPOS 2020; studi rasionalitas antibiotik ISPA Puskesmas Indonesia (program POR Kemenkes)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

kasusSarafMataTht.ts:1114 obatBenar=

['amoxiclav_625','pseudoefedrin_30','paracetamol_500'] — TIGA slot terpisah, semua wajib untuk skorTerapi penuh. Antibiotik (amoxiclav) memang tepat karena vignette eksplisit memenuhi kriteria bakterial (>10 hari tanpa membaik + 'double sickening', baris 1054). Namun clue sendiri (baris 1127) melabeli dekongestan+analgetik sebagai 'PENUNJANG' (suportif) — bahasa yang mengesankan adjuvan/opsional, bukan setara-wajib dengan antibiotik. Apakah pseudoefedrin/paracetamol semestinya dipindah ke obatOpsional (mengikuti pola perbaikan hordeolum di M10 §49) atau tetap obatBenar wajib adalah keputusan klinis yang bisa diperdebatkan (memberi keduanya toh tidak salah/berbahaya, hanya soal apakah TIDAK memberi salah satunya pantas dihukum). Saya tandai perlu adjudikasi, bukan cacat pasti.

mata_glaukoma_akut

Glaukoma Akut Sudut Tertutup



Mutiar EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Obat flu/antimabuk warung (antikolinergik/antihistamin/dekongestan) dapat MENCETUSKAN glaukoma sudut-tertutup pada mata rentan (sudut sempit). Untuk mual-muntahnya hindari antiemetik antikolinergik (dimenhidrinat/prometazin); pilih ondansetron/metoklopramid.

SUMBER PNPk Glaukoma PERDAMI 2018; AAO Primary Angle-Closure Disease PPP 2025; AAO EyeNet "Medication-Induced Acute Angle-Closure Glaucoma"

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Timolol, asetazolamid & pilokarpin ada di Fornas FKTP tapi sering tak distok Puskesmas (glaukoma = kasus rujuk); manitol nyaris nihil. Bila obat ada, beri asetazolamid PO + timolol tetes sambil siapkan rujukan; bila tidak, jangan tunda — rujuk secepatnya, tiap jam berharga.

SUMBER Fornas 2023 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023); PNPk Glaukoma PERDAMI 2018; PPK Dokter FKTP (Permenkes 5/2014) — Glaukoma Akut SKDI 3B

► Catatan verifikator (M11)

kasusSarafMataTht.ts:1225 obatBenar=['timolol_tetes_mata'] — SATU-SATUNYA slot terapi (tidak ada obatAlternatif/prosedur/obatOpsional lain di kasus ini), sehingga tidak meresepkannya membuat skorTerapi=0 (clinic.ts:494-496, totalSlot=1). Tapi clue kasus sendiri (baris 1232) eksplisit melabeli ini kondisional: 'Turunkan TIO pra-rujuk BILA TERSEDIA' (bukan wajib mutlak). Ini kasus WAJIB-RUJUK EMERGENSI (harusDirujuk:true, spesialisRujukan:'mata') — mahasiswa yang secara klinis benar memprioritaskan RUJUK SEGERA tanpa menunda untuk obat yang belum tentu tersedia di FKTP (justru tindakan paling tepat untuk emergensi oftalmologi ancaman kebutaan, sesuai semangat clue-nya sendiri) akan dinilai gagal total (skorTerapi 0) di domain terapi. Catatan tambahan: agen midriatik/atropin yang eksplisit dilarang clue (baris 1141, 1238) TIDAK ADA sebagai item obat di katalog manapun (dicek lintas src/content) sehingga larangan itu tidak benar-benar bisa dilanggar dalam gameplay — bukan bug yang salah skor, hanya potensi pengajaran/jebakan yang terbuang, disebutkan untuk kelengkapan. Pola utama (bahasa kondisional clue vs slot wajib) cocok dengan temuan #10. Confidence sedang-tinggi.

Metabolik & Muskuloskeletal

kasusMetabolikMsk.ts

10 kasus

mm_gout_arthritis_akut

mm_gout_arthritis_akut*Tak ada kandidat pengayaan M11 untuk kasus ini.*

Ambiguitas: kasus ini justru salah satu yg PALING rapi di batch ini (clue benar-benar hedge 'NSAID ATAU kolkisin' bukan AND-forcing, distraktor golongan darah ditandai distraktor:true dgn benar, mutiaraEbm akurat & cocok dgn NICE NG219 yg terverifikasi real). Sumber adjudikasi paling mungkin: ACR 2020 Gout Guideline (terverifikasi real via WebSearch: FitzGerald dkk, Arthritis Care & Research) sebenarnya MEMBOLEHKAN memulai ULT/allopurinol SAAT serangan akut ASALKAN disertai profilaksis antiinflamasi 3-6 bulan -- berbeda dari default konservatif game ini ('JANGAN mulai allopurinol saat serangan', tunda 2-4 minggu). Game sendiri sudah mencatat nuansa ini secara jujur dlm komentar kode (baris 134), jadi ini murni area judgment pedagogis (default aman FKTP vs rekomendasi kondisional ACR modern), bukan bug faktual.

mm_dislipidemia

Dislipidemia

LDL $\geq$ 190 mg/dL yang terisolasi + riwayat jantung dini keluarga bukan sekadar 'kolesterol gaya hidup' — curigai Hiperkolesterolemia Familial & rujuk untuk skrining keluarga. Di kasus ini pola campuran (TG tinggi, HDL rendah, obesitas) condong ke dislipidemia metabolik.

SUMBER PB PERKENI, Panduan Pengelolaan Dislipidemia di Indonesia 2021; kriteria Dutch Lipid Clinic Network (DLCN); ESC/EAS Dyslipidaemias 2019

► Catatan verifikator (M11)

Di praktik FKTP, statin yang tersedia lazimnya hanya simvastatin (intensitas sedang); atorvastatin/rosuvastatin intensitas tinggi jarang ada di rak Puskesmas. Pemantauan ulang lipid & SGOT/SGPT sering terlewat, dan pasien kerap putus obat karena merasa 'tak ada keluhan'.

SUMBER PERKENI Panduan Pengelolaan Dislipidemia 2021; Fornas (KMK Kemenkes terbaru); Pedoman PTM Kemenkes

► Catatan verifikator (M11)

Cacat nyata tapi BUKAN yang tampak sekilas. Firewall alergi statin (katalogM3.ts:43, golonganAlergi ditambah audit 2026-07-04) sudah terpasang & berfungsi real-time (clinic.ts:291-300 blokir penambahan obat + clinic.ts:455-464 substitusi skor obatBenar). Masalah sesungguhnya: alergiTrap SELALU aktif deterministik utk kasus manapun yg punya field ini (director.ts:41-42 & 66-68: 'Kasus ber-alergiTrap SELALU membawa alergi golongan tsb, bukan probabilistik') -> simvastatin_20 (kasusMetabolikMsk.ts:267 obatBenar) TIDAK PERNAH jadi jawaban valid di skor manapun (selalu difilter & diganti ezetimibe_10, baris 286-290). Tapi `clue` (baris 273) mengajarkan 'statin (simvastatin malam hari)' sbg jawaban definitif tanpa PERNAH menyebut ezetimibe -- kontradiksi antara teks debrief-pengajaran dan mekanik skor sesungguhnya. Mahasiswa yg mengikuti clue akan selalu diblokir/dihukum di kasus generik 'dislipidemia' ini, tanpa penjelasan. Pola identik ditemukan di mm_isk_bawah (lihat catatannya).

Jangan pakai ambang Barat (obesitas ≥ 30) untuk pasien Asia — risiko kardiometabolik naik lebih dini (kriteria Asia-Pasifik/Kemenkes: BB lebih ≥ 23 , obesitas $\geq 25 \text{ kg/m}^2$). Lingkar perut ($\text{♂} > 90$, $\text{♀} > 80 \text{ cm}$) sering lebih prediktif; pasien ber-IMT 'hampir normal' pun bisa berisiko tinggi.

SUMBER WHO "The Asia-Pacific Perspective: Redefining Obesity and its Treatment" 2000; Kemenkes P2PTM — klasifikasi IMT & lingkar perut Asia-Pasifik

► Catatan verifikator (M11)

Farmakoterapi obesitas berbasis bukti (orlistat, agonis GLP-1) & bedah bariatrik tak ditanggung BPJS/di luar ranah FKTP; konseling gizi-aktivitas intensif nyaris mustahil di poli padat menitan — lini utama gaya hidup pun kerap jadi nasihat singkat tanpa pendampingan nyata.

SUMBER Formularium Nasional Kemenkes (obat anti-obesitas di luar tanggungan BPJS/FKTP); Konsensus Pengelolaan Obesitas PERKENI; Pedoman PTM & Pelayanan Gizi Puskesmas Kemenkes

► Catatan verifikator (M11)

Ambiguitas ganda yg masuk akal: (1) 'IMT 33 = obesitas derajat II' (baris 370) hanya benar bila memakai klasifikasi WHO Asia-Pasifik/Kemenkes (obese II mulai $\text{IMT} \geq 30$) -- akan tampak salah bila dinilai thd klasifikasi WHO global (obese I=30-34.9, II=35-39.9). Lingkar perut ($> 90 \text{ cm}$ L/ $> 80 \text{ cm}$ P) di baris yg sama memang memakai cutoff Asia-Pasifik yg konsisten dgn pedoman Indonesia, jadi kasus ini INTERNALLY CONSISTENT memakai standar Asia -- hanya berpotensi membingungkan reviewer yg berpatokan WHO global. Butuh adjudikasi dokter: standar mana yg jadi acuan resmi PRIMERA. (2) Frasa 'TSH normal - menyingkirkan hipotiroid' (baris 379) pattern-mirip dgn cacat urat-gout di OA/RA, TAPI ini secara medis BEDA & VALID (TSH memang skrining lini-pertama yg sah utk hipotiroid primer -- tak sama dgn urat utk gout yg justru bisa normal saat gout aktif). Kemungkinan inilah yg bikin CODEX ragu-ragu (pattern-match otomatis tanpa membedakan validitas medis kedua kasus).

Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Jebakan: parasetamol nyaris tak bermanfaat pada OA lutut (Lancet 2016); pedoman internasional (NICE/OARSI) utamakan OAINS TOPIKAL lini pertama. Tapi topikal tetap OAINS — pada pasien alergi NSAID ini justru kontraindikasi, jadi parasetamol + latihan tetap pilihan tepat.

SUMBER da Costa et al., The Lancet 2016 (NMA OA, 58.556 pasien); NICE NG226 (2022); OARSI 2019; Rekomendasi Diagnosis & Penatalaksanaan OA IRA/PB IRA 2014; label diklofenak gel FDA (kontraindikasi hipersensitivitas NSAID)

► Catatan verifikator (M11)

Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Fondasi OA (latihan penguatan kuadrisep terpandu/fisioterapi) jarang tersedia di Puskesmas — Permenkes 43/2019 tak wajibkan fisioterapis; injeksi steroid & rujukan ortopedi antre, sementara suplemen glukosamin/kondroitin laris dibeli bebas meski bukti lemah.

SUMBER OARSI 2019 (glukosamin & kondroitin strongly not recommended); Permenkes 43/2019 Puskesmas & Permenkes 65/2015 Standar Pelayanan Fisioterapi; studi implementasi fisioterapi Puskesmas Jatim (hanya ~6,4% layani); ACR/AF 2019; PPK/PNPK Osteoarthritis

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#12

Cacat terverifikasi, sesuai temuan #12. Baris 501: 'Asam urat 5.4 mg/dL (normal) - menyingkirkan gout sebagai penyebab.' Ini bertentangan dgn mutiaraEbm kasus mm_gout_arthritis_akut di FILE YANG SAMA (baris 142: 'hasil normal TIDAK menyingkirkan gout') dan dgn NICE NG219 (guideline nyata, terverifikasi via WebSearch, publikasi 9 Jun 2022: urat <360 umol/L saat flare + gout dicurigai kuat -> ULANGI periksa, bukan menyingkirkan). Kesimpulan diagnosis OA di kasus ini sendiri tetap benar (gambaran klinis jelas mekanik-kronis-bilateral, bukan gout), tapi ALASAN yg diajarkan ke mahasiswa (urat normal = bukan gout) adalah aturan umum yg keliru secara medis.

mm_low_back_pain

Low Back Pain Mekanik (Nyeri Punggung Bawah)

Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Parasetamol tunggal TIDAK lebih unggul dari plasebo pada LBP akut (PACE, Lancet 2014); OAINS oral jadi lini pertama bila tak ada kontraindikasi lambung/ginjal/kardiovaskular. Parasetamol bukan monoterapi andalan, tapi berguna sebagai kombinasi atau saat OAINS kontraindikasi.

SUMBER Williams et al., Lancet 2014 (PACE trial); NICE NG59 Low Back Pain & Sciatica (2016, rev. 2020); PPK Neurologi PERDOSSI 2016

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Realita FKTP: pasien LBP sering menuntut rontgen & 'suntik', dan mitos tirah baring total/pijat dari sektor informal (mantri/tukang urut) masih kuat. Tantangan dokter bukan sekadar tahu terapi konservatif, tapi menahan tekanan pencitraan & meluruskan mitos 'istirahat total'.

SUMBER NICE NG59 Low Back Pain & Sciatica (2016, upd. 2020); Choosing Wisely-AAFP: Imaging for Low Back Pain; PPK Dokter FKTP (Permenkes 5/2014)
— Low Back Pain

► [Catatan verifikator \(M11\)](#)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Tak ada temuan tambahan setelah tinjauan skeptis. Skrining red-flag lengkap & eksplisit (defisit neuro, kontrol BAB/BAK, demam/BB turun/riwayat kanker/trauma berat, SLR bilateral negatif, motorik/refleks/sensorik normal) konsisten dgn PPK LBP/NICE NG59; obatAlternatif sudah pola pilih-satu yg benar (bukan lagi AND-forcing, sesuai perbaikan audit 2026-07-04, dan komentar kode eksplisit menyatakan kasus ini TIDAK punya alergiTrap yg bisa berkonflik dgn clue); distraktor kasur ditandai benar. Diperiksa jg khusus utk pola clue-vs-mekanik-trap & AND-forcing yg ditemukan di kasus lain dlm file ini -- bersih, tak ditemukan versi serupa.

mm_mialgia

Mialgia (Nyeri Otot)



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI



ditinjau

Mialgia betis (gastroknemius) hebat + riwayat kontak air banjir/tikus: curigai LEPTOSPIROSIS. Mialgia + demam + nyeri retroorbital + gigitan nyamuk: curigai DENGUE. Keduanya kerap disangka pegal biasa — gali riwayat pajanan & demam sebelum menyimpulkan mialgia mekanik.

SUMBER WHO Leptospirosis (surveillance/clinical description: mialgia betis); SE Ditjen P2P Kemenkes Kewaspadaan Leptospirosis 2024 & ayosehat.kemkes.go.id (nyeri betis, DD demam akut di FKTP); WHO Dengue Guidelines (2009/rev.) & CDC Dengue (nyeri retroorbital + mialgia); PPK Dokter FKTP (Permenkes 5/2014)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Tak ada temuan tambahan setelah tinjauan skeptis. Diskriminator otot-vs-sendi jelas, red-flag rabdomiolisis (urin gelap) & miositis (demam) ditanyakan eksplisit; obatAlternatif pilih-satu (parasetamol ATAU ibuprofen) sudah benar, tanpa alergiTrap yg bisa berkonflik dgn clue; obatSalahUmum (antibiotik, deksametason) beralasan tepat scr klinis. Diperiksa jg pola clue-vs-mekanik & AND-forcing yg jadi tema berulang di kasus lain -- bersih, tak ada kontradiksi ditemukan.

mm_arthritis_reumatoid

Arthritis Reumatoid



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

RF bisa NEGATIF pada RA sejati (seronegatif ~20-30%) dan POSITIF pada lansia sehat/infeksi kronik (HCV, endokarditis). Jangan singkirkan atau tunda rujuk RA hanya karena 'RF negatif' — putuskan dari pola klinis (poliartritis simetris sendi kecil, kaku pagi > 1 jam), bukan menunggu serologi.

SUMBER Kriteria Klasifikasi ACR/EULAR 2010; Rekomendasi Diagnosis & Pengelolaan Arthritis Reumatoid — Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA) 2021

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

RA (SKDI 3A) wajib dirujuk: DMARD & serologi RF/anti-CCP tak tersedia di FKTP, tapi antrian reumatologi/penyakit dalam panjang. Selama menunggu pasien lazim pakai jamu pegal-linu ber-BKO deksametason (temuan BPOM) → Cushing iatrogenik, osteoporosis, gula darah naik.

SUMBER Temuan BKO BPOM 2020–2022 (deksametason pd jamu pegal-linu); Fornas 2023 (KMK HK.01.07/MENKES/2197/2023 — restriksi metotreksat); Rekomendasi IRA/PAPDI Diagnosis & Pengelolaan Arthritis Reumatoid 2021

► Catatan verifikator (M11)

Cacat identik dgn mm_osteoarthritis_lutut. Baris 869: 'Asam urat 4.8 mg/dL (normal) - menyingkirkan gout poliartrikular.' Sama-sama bertentangan dgn mutiaraEbm gout (baris 142) dan NICE NG219 (terverifikasi real via WebSearch) soal urat normal/rendah saat flare tak menyingkirkan gout. Diagnosis RA di kasus ini sendiri kuat & benar (poliartritis simetris MCP/PIP, kaku pagi > 1 jam, nodul reumatoid, LED tinggi) -- masalahnya murni pada kalimat membenaran labnya.

mm_hipertensi_urgensi

Hipertensi Urgensi



Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Tengukuk kaku & pusing BUKAN penanda andal tingginya tensi — TD sangat tinggi kerap tanpa gejala, dan pusing sering bukan akibat tensi. Nilai gawat-tidaknya dari ADA/TIDAK kerusakan organ target akut (nyeri dada, defisit neurologis, edema paru), bukan dari keluhan.

SUMBER InaSH Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi 2019; AHA Scientific Statement — Management of Elevated BP in the Acute Care Setting 2024; ACC/AHA Hypertension Guideline 2017 (update 2025)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Nifedipin sublingual/kunyah MASIH sering dipakai di Puskesmas meski dilarang pada krisis hipertensi (kebiasaan lama). Funduskopi & kreatinin kerap tak ada di FKTP dasar (EKG/urinalisis lebih sering ada) — menilai kerusakan organ target sulit, jadi rujuk paling aman.

SUMBER Konsensus InaSH 2024; PPK Hipertensi Kemenkes; Permenkes 43/2019 (standar sarana Puskesmas)

► Catatan verifikator (M11)

PENTING: definisi KASUS ITU SENDIRI di kasusMetabolikMsk.ts (baris 899-1012) sudah baik & aman -- eksplisit TIDAK ada defisit fokal (GCS 15, 'bicara jelas', 'tangan-kaki masih kuat', funduskopi & EKG dicek), clue membedakan urgensi vs emergensi dgn benar, dan bug AND-forcing lama sudah diperbaiki (komentar 'Audit CODEX 2026-07-04'). Cacat NYATA ada di file LAIN:

keluarga/desaE.ts:1347-1354 (storyline Mbah Lastri) memakai kasusId yg SAMA ini untuk presentasi 'dunia berputar, tengkuk kaku, bicara mulai pelo' + TD 208/118 -- bicara pelo mendadak adalah tanda fokal/red-flag stroke, tidak konsisten dgn template 'urgensi TANPA kerusakan organ akut' yg dipakainya (verified dgn membaca desaE.ts langsung). ini bug lintas-file pada storyline, BUKAN pada template kasus mm_hipertensi_urgensi sendiri. Catatan verifikasi sitasi: dasar finding CODEX #3 menyebut 'PNPK Stroke 2026' -- WebSearch tidak menemukan dokumen ini; PNPk Stroke resmi Kemenkes terbaru yg terverifikasi adalah PNPk 2019 (KMK No. HK.01.07/MENKES/394/2019, kemkes.go.id/id/pnpk-2019---tata-laksana-stroke). Sitasi tahun 2026 tampak keliru/tak ada, meski prinsip klinisnya (bicara pelo mendadak = curiga stroke, bukan sekadar hipertensi urgensi) tetap valid secara umum lepas dari nomor PNPk spesifik.

mm_gagal_jantung_kongestif

Gagal Jantung Kongestif

 Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Edema tungkai bilateral tak spesifik untuk gagal jantung — bisa insufisiensi vena, hipoalbuminemia, penyakit ginjal, atau efek amlodipin (lazim di Puskesmas). Yang lebih menunjuk kongesti: JVP↑, S3 gallop, ortopnea, PND. Sesak+ronki bisa juga pneumonia/PPOK.

SUMBER Kriteria Framingham gagal jantung; ESC Heart Failure Guidelines 2021; PPK/Pedoman Tatalaksana Gagal Jantung PERKI 2020/2023

► Catatan verifikator (M11)

 Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Diagnosis definitif CHF (ekokardiografi, BNP/NT-proBNP) tak ada di FKTP; CHF jadi diagnosis KLINIS: stabilisasi + rujuk. Oksigen/furosemid injeksi bisa terbatas di Pustu, dan keterlambatan transport rujukan (SISRUTE/ambulans) kerap lebih fatal daripada pilihan obatnya.

SUMBER PPK Gagal Jantung PERKI/Kemenkes (PPK-1 Dokter FKTP); Permenkes 43/2019 (standar sarana Puskesmas & Pustu); regulasi SISRUTE Kemenkes

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

TAK JELAS

Tidak menemukan cacat case-local baru pada tinjauan independen yg cukup mendalam. Kriteria Framingham lengkap & akurat (S3 gallop, JVP naik, ronki

basal, edema pitting, hepatomegali + refluks hepatojugular); kontraindikasi NSAID & larangan memulai beta-blocker saat dekomposisi akut sudah benar (sesuai ESC HF/PERKI); isu historis 'restriksi cairan vs edukasi minum banyak' sudah diperbaiki (komentar CODEX ronde-2, 2026-07-06). Tidak ketemu alasan jelas kenapa masih ditandai '!'. Satu celah lemah yg teridentifikasi: clue menjanjikan 'oksigen' sbg bagian stabilisasi, tapi tidak ada tindakan/prosedur 'oksigen' yg bisa dipilih/dinilai DI MANAPUN di seluruh kodebase (bukan cuma kasus ini) -- kemungkinan besar ini keterbatasan desain global (oksigen memang tak pernah dimodelkan sbg tindakan diskret di game ini), bukan cacat spesifik kasus ini. Rekomendasi: minta CODEX klarifikasi dasar konkret tanda '!' pada kasus ini sebelum ditindaklanjuti.

mm_isk_bawah

Infeksi Saluran Kemih Bawah (Sistitis) ⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑

💡 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Nitrit dipstick bisa FALSE-NEGATIVE: kuman non-pengurai nitrat (*Enterococcus*, *S. saprophyticus*), urin encer, atau urin belum lama di kandung kemih (sering berkemih). Nitrit negatif TIDAK menyingkirkan ISK; pada perempuan dengan disuria-frekuensi-urgensi klasik, diagnosis KLINIS.

SUMBER IDSA/ESCMID Uncomplicated Cystitis Guideline 2011 (Gupta et al., CID); AAFP Dipstick Urinalysis 2013; PPK Dokter di FKTP Kemenkes (Permenkes 5/2014)

► Catatan verifikasi (M11)

📱 Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Kotrimoksazol lini pertama mengandaikan resistensi lokal <20%, padahal resistensi *E. coli* di Indonesia umumnya >20% (AMRIN ~29–56%). Nitrofurantoin/fosfomisin lebih ideal tapi sering kosong di Puskesmas — jadi kotrimoksazol, bahkan siprofloksasin, kerap tetap dipakai.

SUMBER IDSA/ESCMID 2011 (Gupta et al., Clin Infect Dis 52:e103); AMRIN Study (Kemenkes, *E. coli* resisten kotrimoksazol 29% komunitas / 56% RS); Fornas (kesesuaian obat FKTP ~50–62%)

► Catatan verifikasi (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

Pola cacat identik dgn mm_dislipidemia (sama mekanisme, kasus berbeda). alergiTrap sulfa (baris 1262-1266) selalu aktif deterministik (director.ts:41-42 &

66-68) -> cotrimoxazole_480 (obatBenar baris 1247) tidak pernah jadi jawaban valid di skor manapun (selalu difilter & diganti nitrofurantoin_100). Tapi `clue` (baris 1254) mengajarkan 'antibiotik lini pertama (kotrimoksazol) 3 hari' sbg jawaban definitif tanpa sekalipun menyebut nitrofurantoin -- kontradiksi clue-vs-mekanik yg sama persis dgn dislipidemia. Firewall real-time (clinic.ts TAMBAH_OBAT, baris 291-300) memang memblokir kotrimoksazol saat mau diresepkan (mahasiswa dapat peringatan instan 'kontraindikasi'), sehingga dampaknya sedikit lebih ringan drpd dislipidemia (tak murni silent-penalty) -- tapi debrief clue pasca-kasus tetap mengajarkan jawaban yg justru SELALU diblokir di kasus ini, berpotensi membingungkan & menanamkan kesan keliru bahwa kotrimoksazol pilihan pertama tanpa syarat.

kia_anc_kehamilan_normal **ANC — Kehamilan Normal (Trimester 2)**

⚠ Titik temu – lihat ringkasan ↑

💡 Mutiara EBM

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Ambang anemia T2 lebih rendah: <10,5 g/dL (vs <11 di T1/T3), karena volume plasma naik lebih cepat dari massa eritrosit → Hb turun fisiologis, nadir ~minggu 28-34. Jadi Hb 10,5-10,9 di T2 masih normal, bukan anemia. Lanjutkan Fe profilaksis, jangan buru-buru naik ke dosis terapi.

SUMBER WHO Guideline on Haemoglobin Cutoffs to Define Anaemia 2024;
Kemenkes Buku Saku Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil 2023

► Catatan verifikator (M11)

📺 Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Standar ANC Kemenkes 2020: 6x kunjungan + USG oleh dokter min. 2x (K1 trimester 1 & K5 trimester 3). Realita: meski alat USG didistribusikan ke Puskesmas sejak 2023, dokter tersertifikasi USG obstetri terbatas & listrik stabil sering belum ada, skrining tak jalan/dirujuk.

SUMBER Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Kemenkes 2020; Media Indonesia — Kemenkes soal kendala USG Puskesmas 2023; POGI Pelatihan USG Obstetri Dasar Terbatas

► Catatan verifikator (M11)

Cacat nyata terkonfirmasi kode: (1) lab-list kasus (baris 115-120) sama sekali tak menyediakan opsi HIV/sifilis/HBsAg — bukan sekadar tak-relevan, opsinya memang tak ada. Permenkes No.6/2024 (SPM Kesehatan) real & saya verifikasi eksis, meski isi pasal detail tak terbaca (PDF korup). (2) 'Menggandakan folat' TERBUKTI di kode: katalogM3.ts baris 321-329 — 'tablet_fe' SUDAH kombo Fe 60mg+asam folat 0,4mg, tapi obatBenar (baris 123) tetap mewajibkan 'asam_folat' terpisah sebagai slot kedua — mengajarkan dobel-folat yang tak sesuai program TTD standar. NAMUN klaim CODEX soal '90 TTD outdated' TIDAK terbukti benar — WebSearch (sumber Kemenkes/BKKBN 2024-2025) menegaskan target ≥ 90 tablet masih standar aktif, bahkan dianjurkan hingga 180; jadi sub-klaim ini overreach CODEX. Soal 'golongan darah tak relevan': pertanyaan (baris 100-106, distraktor:true, id-nya salah label 'q_pekerjaan') & lab (baris 119, relevan:false) memang konsisten menandainya non-esensial — ini pilihan desain yang defensible (gol.darah pasien sudah diketahui riwayat, bukan tes baru), bukan bug yang jelas salah.

kia_isk_kehamilan

Nitrit/leukosit esterase dipstik NEGATIF tidak menyingkirkan ISK (kia_isk_kehamilan)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Dipstik negatif TIDAK menyingkirkan ISK: nitrit bisa negatif bila kuman tak mereduksi nitrat (*Enterococcus*, *Staph. saprophyticus*) atau urin <4 jam di kandung kemih (sering berkemih); leukosit esterase bisa negatif bila piuria minimal. Bila gejala khas, tetap obati/kultur.

SUMBER WHO Antenatal Care Recommendations 2016 (kultur urin midstream sebagai metode diagnosis bakteriuria asimtomatik; bila tak tersedia, pewarnaan Gram > dipstik); IDSA Asymptomatic Bacteriuria Guideline 2019; Cochrane (Smaill & Vazquez 2019).

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Idealnya semua bumil diskriming bakteriuria asimtomatik dengan kultur urin (baku emas WHO) di ANC awal, tetapi kultur & uji sensitivitas hampir tak tersedia di Puskesmas — diagnosis dan pilihan antibiotik bertumpu pada dipstik/urinalisis dan terapi empiris.

SUMBER WHO Antenatal Care Recommendations 2016 (skrining ASB dengan kultur urin midstream; Gram-stain bila kultur tak tersedia); USPSTF ASB Screening 2019; Permenkes 43/2019 (standar lab Puskesmas: urinalisis/dipstik, tanpa kultur urin)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#1

Tak ada cacat case-local baru yang saya temukan di luar keterbatasan mesin resep umum (finding #1): katalogM3.ts baris 22 (cefixime_100) tak punya data dosis/frekuensi/durasi, padahal clue kasus (baris 239) eksplisit menekankan 'tuntaskan 7 hari' — mesin hanya bisa cek ID obat dipilih, bukan kepatuhan durasi. Daftar obatSalahUmum (kuinolon/tetrasiklin/sulfa, baris 229-233) akurat secara klinis dan nuansanya baik (sulfa disebut 'terutama trimester 1 & akhir', bukan kontraindikasi mutlak blanket). Marker '!' di sini tampaknya murni mewarisi cacat sistemik #1, bukan cacat unik kasus ini.

kia_preeklampsia_berat

Proteinuria TIDAK wajib untuk diagnosis preeklampsia berat — absennya tak menyingkirkan

⚠ Titik temu — lihat ringkasan ↑

💡 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Preeklampsia berat bisa ditegakkan TANPA proteinuria: hipertensi + ≥ 1 tanda berat (trombositopenia, SGOT/SGPT/kreatinin naik, edema paru, nyeri kepala/gangguan visus, nyeri epigastrium). Jangan tunda MgSO₄/rujuk hanya karena protein urin negatif; edema bukan kriteria.

SUMBER ACOG Practice Bulletin 222 (2020); ISSHP 2018; PNPK Preeklampsia POGI/Kemenkes 2016

► Catatan verifikator (M11)

📺 Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Idealnya beri MgSO₄ dosis loading (4 g IV) + antihipertensi SEBELUM transport, tapi di lapangan pasien sering dirujuk tanpa dosis awal karena keraguan/kurang terlatih. Siapkan kalsium glukonas 10% sebagai antidot; pantau napas (>16x/mnt), refleks patela & produksi urin.

SUMBER PNPk Preeklampsia-Eklampsia POGI 2016 (regimen MgSO₄ + syarat antidot kalsium glukonas 10%); studi pra-rujukan RSUP Fatmawati (93,3% Puskesmas & 96% praktik mandiri tak memberi MgSO₄ pra-rujuk); Fornas KMK No. HK.01.07/MENKES/2197/2023.

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#4

#1

TERKONFIRMASI persis klaim CODEX: katalogM3.ts baris 91-92 'mgso4_inj' cuma satu item generik ('Magnesium Sulfat 40% Injeksi', sediaan 'ampul') tanpa pembeda loading vs maintenance atau kuantitas. Saya verifikasi via WebSearch regimen nyata (PNPK Preeklampsia POGI 2016 real; WHO/RCOG: loading 4-6g IV 15-20menit lalu maintenance 1-2g/jam, atau Pritchard IM 4g+5g bilateral lalu 5g/4jam) — clue kasus (baris 349) menyebut 'loading + maintenance' secara naratif tapi mesin skoring sama sekali tak bisa menguji perbedaan itu, hanya cek 'mgso4_inj' dipilih atau tidak. Obat salah (captopril/furosemid/diazepam) akurat secara klinis.

kia_abortus_iminens

Abortus Iminens (Ancaman Keguguran)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

☐ ditinjau

Realita: abortus iminens rutin diberi progestin oral (alilestrenol/didrogesteron) walau bukti manfaat terbatas—progesteron vaginal (PRISM) hanya menolong subgrup dengan riwayat keguguran; pada pasien tanpa riwayat belum terbukti & bukan keharusan. Inti: rujuk USG.

SUMBER PRISM RCT (Coomarasamy dkk., NEJM 2019); NICE NG126 (2019, upd. 2025); meta-analisis progestogen (Zhao dkk., Acta Obstet Gynecol Scand 2024); praktik lapangan RI (Premaston/Duphaston, obat keras rutin diresepkan)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Revisi 'tirah-baring-total tak terbukti mencegah keguguran' (komentar baris 455-460, sitasi Cochrane CD003576) saya VERIFIKASI NYATA dan akurat — Aleman et al. 2005, memang menyimpulkan bed rest tak terbukti efektif (bahkan mungkin sedikit lebih buruk di satu perbandingan vs terapi lain). Bagian ini justru contoh revisi berbasis-bukti yang solid, BUKAN cacat. Ambiguitas sisa utk adjudikasi: (a) apakah progesteron seharusnya masuk obatBenar — NICE NG126 merekomendasikan progesteron vaginal HANYA utk pasien dgn riwayat keguguran sebelumnya + perdarahan aktif; pasien kasus ini G1P0 tanpa riwayat

keguguran, jadi obatBenar:[] (kosong) mungkin memang tepat per kriteria itu, tapi clue tak menjelaskan nuansa ini secara eksplisit sehingga sulit dipastikan itu keputusan sadar atau kebetulan. (b) realisme 'wajib rujuk USG' vs beberapa Puskesmas kini sudah py USG on-site (dorongan Permenkes 6/2024 SPM) — soal konteks lokal, bukan salah/benar mutlak.

kia_kb_konseling

Konseling KB (Kontrasepsi Pascapersalinan)



Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Ovulasi bisa terjadi SEBELUM haid pertama kembali — 'belum menstruasi' bukan jaminan tak hamil. LAM/MAL hanya andal bila SEMUA syarat terpenuhi (ASI eksklusif on-demand + amenorea + bayi <6 bulan) & bersifat sementara; jangan tunda kontrasepsi hanya karena belum haid.

SUMBER WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th ed. (LAM/Bellagio Consensus); BKKBN — Metode Amenore Laktasi (MAL)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Di Puskesmas metode terbanyak = suntik DMPA 3 bulan, tapi kesuburan baru pulih median ~10 bulan (bisa sampai 18 bulan) sejak suntikan terakhir — penting bagi ibu yang berniat hamil lagi. Bila reversibilitas cepat jadi prioritas, tawarkan IUD/implan sebagai informed choice.

SUMBER WHO Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use 2016 (median return to fertility DMPA ~10 bln, hingga 18 bln); BKKBN 2023 (suntik ~53% akseptor); SDKI 2017 (indeks informed choice ~17%)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Diperiksa skeptis (obatBenar kosong, edukasi, otonomi pasien, akurasi WHO MEC) — tak ada temuan tambahan. obatBenar:[] masuk akal karena inti kasus adalah konseling/informed-choice bukan resep tertentu. edukasi sudah diperbaiki sebelumnya (komentar baris 555-559, kb_aman_menyusui ditambahkan). Dialog pasien (baris 539: 'suami mendukung apa pun yang paling aman untuk saya') menunjukkan otonomi pasien dijaga — kontras positif dgn kritik finding #9 thd storyline keluarga lain (Dewi/Karsa di file berbeda, bukan kasus ini). Panduan WHO MEC di clue (hindari estrogen kombinasi dini menyusui, progestin-only/non-hormonal aman) akurat.

SSRI bisa memperberat cemas 1–2 minggu awal & butuh 2–4 minggu untuk bekerja

 Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

SSRI (fluoksetin/sertraline) dapat memicu 'aktivasi' (cemas/gelisah/insomnia sementara) di 1–4 minggu awal, dan efek terapi baru terasa 2–4 minggu. Mulai dosis rendah, edukasi pasien jangan hentikan dini — penyebab umum salah kira 'obat gagal' lalu beralih ke benzodiazepin.

SUMBER NICE CG113 GAD (2011, upd. 2020); mhGAP WHO 2016; label/EI fluoksetin-sertraline (activation & onset of action); Fornas 2023 (SSRI tersedia di FKTP)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Realita FKTP: psikolog klinis nyaris tak ada (baru ~203, terpusat di kota besar, untuk >10.000 Puskesmas) & waktu konsul singkat, sehingga CBT sulit; praktik sering jatuh ke benzodiazepin (Fornas Puskesmas: diazepam) demi 'efek cepat' — padahal berisiko toleransi/ketergantungan.

SUMBER Data Kemenkes/IPK Indonesia 2025-2026 (psikolog klinis Puskesmas ~203; 29/4.335 di puskesmas-klinik pratama); WHO mhGAP (task-sharing SDM jiwa); Fornas (diazepam & fluoksetin FKTP); PPK Jiwa FKTP

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

CACAT

DIKONFIRMASI

#1

Cacat yang bisa dikonfirmasi: dosis/titrasi/durasi fluoksetin tak tersimpan di manapun (katalogM3.ts baris 59, cuma 'Fluoksetin 20 mg' tanpa info lain) — konsisten finding #1. Nuansa hilang: diazepam otomatis dihukum sebagai obatSalahUmum (baris 669-670) walau alasannya sendiri mengakui 'jangka SANGAT pendek/krisis' itu sah — skoring biner tak bisa membedakan pemakaian bridging singkat yang tepat vs rutin jangka panjang. Sebaliknya desain diagnostik kasus ini SUDAH benar: TSH (baris 663) dan EKG (baris 664) keduanya relevan:true dengan alasan menyingkirkan hipertiroid/aritmia — kontras positif dibanding kasus skizofrenia di file yang sama. Tak ada cacat case-local baru signifikan selain gap dosis generik.

Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

Depresi di FKTP sering bertopeng keluhan somatik (pegal, lemas, pusing, nyeri kronik, gangguan tidur), terutama pada lansia, sehingga terjebak pemeriksaan organik berulang. Pada keluhan somatik tak berpola, skrining mood + anhedonia aktif (PHQ-2) membantu menangkapnya.

SUMBER WHO mhGAP-IG 2.0 (Depression); Kroenke PHQ-2 2003; Riskesdas 2013 (depresi lansia Indonesia)

► Catatan verifikator (M11)

Realita FKTP

DISEMPURNAKAN

●●● SEDANG

☐ ditinjau

Idealnya (mhGAP/NICE NG222) depresi ringan: psikoedukasi + aktivasi perilaku + active monitoring dulu, antidepresan tak rutin. Realita FKTP: layanan psikologi sering tak ada (hanya ~40% Puskesmas punya layanan jiwa) & kontrol sulit, obat kerap langsung diberi — bila perlu, sertai rencana kontrol + skrining bunuh diri.

SUMBER NICE NG222 (2022); WHO mhGAP-IG v2.0 & Update 2023; Kemenkes/PDSKJI — cakupan layanan jiwa Puskesmas ~40% & mandat psikolog klinis PMK No.19/2024

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

DIKONFIRMASI

Diperiksa skeptis — tak ada temuan tambahan. Pendekatan 'obatBenar kosong, psikoedukasi/aktivasi perilaku dulu' (komentar baris 774-778) selaras mhGAP WHO & NICE NG222 (NG222 = guideline nyata NICE 'Depression in adults', 2022) yang saya kenali sebagai dokumen valid. Skrining bunuh diri (baris 740-746) dan riwayat manik/bipolar (baris 754-759, mencegah risiko switch akibat SSRI) ada dan tepat. TSH (baris 769) benar ditandai relevan:true — kontras dgn inkonsistensi yang saya temukan di jiwa_insomnia.

jiwa_insomnia

'Higiene tidur' saja bukti lemah — inti CBT-I adalah kontrol stimulus & pembatasan tidur

Mutiara EBM

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

⚠ Revisi clue?

☐ ditinjau

Higiene tidur sebagai terapi TUNGGAL buktinya lemah — AASM justru merekomendasikan jangan dipakai sendirian. Komponen CBT-I yang efektif:

kontrol stimulus (tempat tidur hanya untuk tidur; keluar bila tak bisa tidur) & pembatasan tidur. Membagikan leaflet higiene ≠ mengobati.

SUMBER AASM Clinical Practice Guideline: Behavioral & Psychological Treatments for Chronic Insomnia (J Clin Sleep Med, 2021); ACP Clinical Practice Guideline: Management of Chronic Insomnia in Adults (Ann Intern Med, 2016)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● TINGGI

☐ ditinjau

CBT-I lini pertama (AASM 2021), tetapi terapis/CBT-I digital nyaris nihil di FKTP (hanya segelintir psikolog klinis di Puskesmas; ~50% Puskesmas tanpa layanan jiwa). Praktik jatuh ke higiene tidur + hipnotik/benzodiazepin — batasi durasi, cegah ketergantungan/jatuh pada lansia.

SUMBER AASM CPG "Behavioral & Psychological Treatments for Chronic Insomnia" 2021; Permenkes No. 19/2024 (psikolog klinis wajib di Puskesmas); data Kemenkes/IPK Indonesia 2026 (cakupan layanan jiwa Puskesmas ~50%, psikolog klinis di Puskesmas ~29/4.335); PAPDI CME & advisory Kemenkes ttg benzodiazepin.

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

BERSIH

BASI/KELIRU

CODEX MELEWATKAN cacat nyata: baris 907, item lab TSH ditandai relevan:false meski teksnya sendiri berbunyi '...hipertiroid sebagai penyebab insomnia disingkirkan' (menyiratkan tujuan diagnostik yang sah). clinic.ts baris 600-605 mengonfirmasi flag 'relevan' ini AKTIF dipakai menghitung 'labTakRelevan' yang menghukum skor — jadi pemain yang memeriksa TSH (tindakan wajar utk singkirkan penyebab sekunder insomnia) akan dianggap memesan tes tak perlu. Ini tak konsisten dgn TSH pada jiwa_gangguan_cemas (baris 663, relevan:true) dan jiwa_depresi_ringan (baris 769, relevan:true) di FILE YANG SAMA untuk rasional yang esensinya serupa (singkirkan tiroid sbg mimicker organik). Bisa diperdebatkan apakah TSH memang kurang perlu di insomnia tanpa red-flag lain (rasional klinis ada), tapi kontradiksi teks-vs-flag dan inkonsistensi antar-kasus adalah bug objektif yang harus diadjudikasi, bukan 'tak ada masalah' seperti klaim CODEX.

jiwa_skizofrenia

Haloperidol bisa memicu distonia akut/akatisia — antisipasi, jangan disangka 'memburuk'

Haloperidol sering picu efek ekstrapiramidal: distonia akut (kaku, mata mendelik, tortikolis) dalam jam–hari pertama & akatisia (gelisah tak bisa diam) — mudah disangka psikosis memburuk. Atasi distonia akut dgn difenhidramin/triheksifenidil, pakai dosis efektif terendah.

SUMBER WHO mhGAP 2016 (modul psikosis); Stroup & Gray, World Psychiatry 2018 (manajemen efek samping antipsikotik); Fornas 2023 (haloperidol, triheksifenidil, difenhidramin)

► Catatan verifikator (M11)

Idealnya ke SpKJ, tapi psikiater hanya ~1.100 se-Indonesia dan absen di banyak kabupaten — rujukan berarti jarak & antre. Realitanya FKTP yang menjaga rumatan (haloperidol/klorpromazin, ada di Fornas). Kunci cegah kambuh & pasung: kontinuitas obat + pendampingan keluarga.

SUMBER WHO mhGAP 2015/2023 (task-sharing & rumatan antipsikotik); Fornas 2023 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023 — haloperidol & klorpromazin FKTP); UU No.18/2014 Kesehatan Jiwa; Kemenkes/Riskesdas — data SDM psikiater (~1.100; 0,32/100.000) & pasung 2023-2026

► Catatan verifikator (M11)

Menemukan cacat case-local BARU yang tak tercakup 14 temuan CODEX: baris 1010, pemeriksaan region 'jantung' eksplisit menyatakan 'penting sebagai baseline sebelum antipsikotik — risiko QT' TAPI ditandai relevan:false, dan lab array kasus ini (baris 1012-1015: cuma GDS + darah rutin) sama sekali tak menyediakan opsi EKG — kontradiksi antara narasi (mengklaim pentingnya cek QT) dan implementasi (tak bisa dicek, dan walaupun bisa akan dianggap tak relevan). Ini kontras jelas dengan jiwa_gangguan_cemas di file yang sama yang menangani logika serupa dengan benar (EKG tersedia & relevan:true). Selain itu, dosis/titrasi haloperidol tak tersimpan (katalogM3.ts baris 61, gap generik finding #1). Diagnosis F20.0 + SKDI 3A + alur rujuk sudah tepat secara klinis.

Satu RDT (HRP-2) negatif TIDAK menyingkirkan malaria: bisa negatif-palsu saat parasitemia dini/rendah, pada delesi pfhrp2/3 (dilaporkan di Papua), atau efek prozone saat parasitemia sangat tinggi. Klinis kuat + riwayat endemis → ulangi RDT/mikroskop tebal-tipis 12–24 jam.

SUMBER WHO Guidelines for Malaria 2023 (keterbatasan RDT HRP-2: delesi pfhrp2/3 & efek prozone); Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria Kemenkes 2023 (mikroskop baku emas, apus tebal-tipis); CDC Malaria Diagnosis 2024 (ulang apusan tiap 12–24 jam, hingga 3 set); Scientific Reports 2025 (delesi PfHRP2/3 pada isolat Papua, Indonesia)

► Catatan verifikator (M11)



Realita FKTP

TERVERIFIKASI

●●● SEDANG

☐ ditinjau

Malaria impor: pasien pulang dari Papua/NTT kerap berobat di Puskesmas Jawa/Bali non-endemis yang tak menstok RDT & ACT (DHP)/primakuin (distribusi terfokus daerah endemis) → diagnosis terlambat. Curigai demam+riwayat perjalanan; siapkan rujukan & lapor e-SISMAL.

SUMBER Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria Kemenkes 2023; KMK No.556/2019 (PNPK Malaria); e-SISMAL Kemenkes; laporan kasus malaria impor wilayah non-endemis (Medicina Udayana, 2024)

► Catatan verifikator (M11)

CODEX AUDIT

AMBIGU

TAK JELAS

Klaim game 'tes G6PD tidak diwajibkan untuk dosis tunggal falsiparum' (clue baris 1153) saya VERIFIKASI AKURAT via WebSearch — WHO policy brief 2015 ttg primakuin dosis rendah tunggal (0,25mg/kgBB) sbg gametosidal memang tak mensyaratkan skrining G6PD, diperkuat studi Mwaiswelo dkk 2022 (Tanzania) yg menunjukkan aman lintas status G6PD pada dosis ini. DHP+primakuin sbg lini pertama Kemenkes juga cocok dgn 'Buku Saku Tatalaksana Kasus Malaria' yang saya temukan. Ambiguitas sisa utk adjudikasi: dosis primakuin/DHP berbasis berat badan (mg/kgBB) tapi struktur data pasien (types.ts, demografi hanya usiaMin/usiaMax/jenisKelamin) sama sekali tak punya field berat badan (finding #1) — kasus hanya memberi item flat 'primakuin_15'. Apakah ini cacat nyata yang perlu diperbaiki atau abstraksi game yang dapat diterima adalah keputusan yang tak bisa saya putuskan sendiri; saya juga tak bisa memastikan apakah pedoman NASIONAL terbaru (bukan cuma WHO) mensyaratkan kewaspadaan G6PD ekstra di area prevalensi tinggi seperti Papua (lokasi pasien) karena teks pedoman lengkapnya tak terjangkau dlm pencarian saya.

UKM, Posyandu, KLB & Keluarga Binaan

24 klaim CODEX seputar keluarga binaan & program UKM — di luar cakupan riset M11 (yang hanya menyapu kasus poli klinik).

Metodologi — commit HEAD & keaslian repo

DIKONFIRMASI

HEAD aktual saat verifikasi = 4c13ecf1, BUKAN 6e1b2bcc yang disebut CODEX. Tapi `git diff --stat 6e1b2bcc 4c13ecf1` hanya menunjukkan 1 file BARU (docs/M11_FASE2_RISSET_PENGAYAAN.md, +593 baris) — NOL perubahan kode/konten. Jadi semua temuan CODEX tetap valid diverifikasi terhadap HEAD saat ini. git status bersih dikonfirmasi.

Temuan #1 — Mesin resep tanpa dosis + firewall alergi parsial

DIKONFIRMASI

types.ts:178 (demografi) TIDAK punya field berat badan di mana pun di src. Obat interface (types.ts:281-296) tidak punya dosis/rute/frekuensi/durasi/aturan-pakai — obatBenar (types.ts:109) cuma string[] ID obat. clinic.ts (~473-496) skoring resep HANYA cek keanggotaan ID di enc.resep, tak mungkin deteksi dosis salah. Firewall alergi: saya hitung manual SELURUH katalog (OBAT 37 entri + OBAT_M3 60 entri = 97 obat total, cocok persis klaim CODEX) — golonganAlergi ter-tag di TEPAT 13/97 obat, dan dari 19 obat antibiotik:true, HANYA 8 yang ter-tag golonganAlergi. Aritmetika CODEX 100% presisi. Tak ada pemeriksa interaksi obat di mana pun (grep 'interaksi' hanya kena kode UI radio-button, bukan farmakologi).

Temuan #2 — Storyline Asih (preeklampsia, penundaan)

DIKONFIRMASI

desaC.ts: TD 150/95 + pitting edema tercatat kunjungan-1 (baris ~258-259); kunjungan-2 (baris 488) Bu Asih melapor sakit kepala 'seminggu ini' + edema masih ada. Jalur 'benar' (ak2_i1, baris 594) murni edukasi (kartu bergambar), hasilnya baru dinarasikan SEMINGGU kemudian. Struktur SkenarioKunjungan (types.ts) memang tak punya opsi 'tindakan klinis segera' — hanya hotspot/dialog/kartu-intervensi COM-B — jadi modul UKM ini SECARA STRUKTURAL tak bisa menawarkan rujuk/periksa-ulang-TD-hari-itu-juga berapa pun gawatnya gejala. Keputusan medis (apakah kombinasi ini butuh eskalasi SAAT itu) diserahkan ke penilaian dokter pengguna.

Temuan #3 — Stroke iskemik tanpa imaging + kode I16.0 + Lastri

DIKONFIRMASI

kasusKronis.ts:900-902 mengunci icd10:'I63.9' (iskemik) sbg satu-satunya jawaban; lab (999-1002) cuma gds/darah-rutin/kolesterol, TAK ADA opsi CT-scan — padahal diagnosisBanding sendiri memuat I61.9 (hemoragik), mengakui gambaran klinis tak bisa dibedakan tanpa imaging. Aturan TD permisif (<220/120) di clue TAK punya pengecualian kandidat trombolisis (target semestinya <185/110). Lastri

(desaE.ts:1347-1354): karma menambahkan 'bicara mulai pelo' + 'tengkuk kaku' pada TD 208/118 → dipetakan ke mm_hipertensi_urgensi, TAPI kasus formalnya sendiri (kasusMetabolikMsk.ts:899-990) eksplisit menyatakan 'bicara jelas', 'TIDAK ada tanda ensefalopati/stroke akut' — kontradiksi naratif-vs-kasus terverifikasi persis. Soal I16.0: saya cek WHO ICD-10 (mirror NHS UK classbrowser, edisi ke-5 resmi) — blok 'Hypertensive diseases' HANYA I10-I13 & I15 (tanpa I16). Kode I16/I16.0/I16.1 CUMA ada di ICD-10-CM Amerika. Klaim CODEX bahwa I16.0 bukan kode WHO ICD-10 (yang dipakai SATUSEHAT) didukung kuat oleh sumber independen ini.

Temuan #4 (kode) — ANC: gol.darah diabaikan, tanpa HIV/sifilis/HBsAg, folat ganda

DIKONFIRMASI

kia_anc_kehamilan_normal (kasusKiaJiwa.ts:24-131): pertanyaan golongan darah eksplisit distraktor:true (baris 105) & lab golongan_darah relevan:false (baris 119) — dikonfirmasi diperlakukan tak relevan, padahal scr klinis berguna (Rh/persiapan transfusi). TAK ADA lab HIV/sifilis/HBsAg di manapun di src/content (grep bersih). obatBenar wajib tablet_fe (sudah mengandung Fe60mg+folat0,4mg, katalog.ts:326) DAN asam_folat 1mg terpisah — dikonfirmasi dobel folat by design. anemia_defisiensi_bumil (Hb 8,5; kasusKronis.ts:745): hanya jalur rutin tablet_fe+asam_folat, tanpa tingkat dosis lebih tinggi/rujukan. MgSO4 (katalogM3.ts:91) tak punya field dosis loading/maintenance —konsisten Temuan#1. CATATAN: klaim 'target 90 TTD sudah usang' PERLU DILUNAKKAN — pencarian saya menunjukkan 90 tablet MASIH standar resmi Kemenkes saat ini (sedang transisi ke MMS/multi-mikronutrien, tapi 90 tablet Fe+folat sendiri belum 'salah').

Sitasi Permenkes 6/2024 (dikutip utk ANC)

BASI / KELIRU

Permenkes 6/2024 NYATA ADA, tapi ISINYA tentang 'Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan' — target cakupan administratif, BUKAN pedoman teknis klinis ANC (gol.darah/HIV/sifilis/HbsAg/dosis TTD). Regulasi yang benar-benar memuat rincian teknis ANC komprehensif adalah Permenkes 21/2021. Ini kemungkinan salah-kutip nomor regulasi oleh CODEX (dokumen nyata, tapi salah topik) — bukan halusinasi murni, tapi tetap perlu dikoreksi bila dipakai sbg rujukan resmi.

Temuan #5 — DM/HT regimen tunggal terkunci

tak-jelas

Kode terkonfirmasi: dm_tipe2 (kasusKronis.ts:263, HbA1c 8,9%) obatBenar=['metformin_500'] saja tanpa lab eGFR/UACR wajib; hipertensi_esensial (baris 129) obatBenar=['amlodipine_5'] tunggal tanpa work-up target-organ tambahan wajib. TAPI: PNPK DM 2026 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/302/2026) dan PNPK

Hipertensi 2026 (.../303/2026) TERKONFIRMASI NYATA ADA (nomor SK cocok via pencarian web), namun saya GAGAL membaca isi PDF-nya (WebFetch tak bisa parse binary) — jadi saya TIDAK BISA memverifikasi independen apakah detail rekomendasi spesifik yang diklaim dilanggar itu benar ada di dalamnya. Perlu ronde tambahan dengan akses PDF yang lebih baik (OCR/download manual).

Temuan #6 — Algoritma akut & 5 kasus IGD DIKONFIRMASI

diare_akut_anak (kasusInfeksi.ts:491-599): dehidrasi ringan-sedang tanpa volume Plan-B 75mL/kg/4jam maupun reassessment terjadwal — confirmed. tb_paru: lab hanya bta_sputum, tanpa TCM/HIV — confirmed. igd_syok_anafilaksis (igd.ts): langkah a3 mewajibkan AND steroid+antihistamin meski clue sendiri mengakui 'bukti pencegah reaksi bifasik LEMAH' — tak ada opsi adrenalin-observasi-saja. igd_kejang_demam: pembuka bilang kejang SUDAH > 10 menit, tapi langkah k2 menyebut 'kini menit ke-7' — kontradiksi waktu mundur TERVERIFIKASI TEKS PERSIS; ambang durasi 'kompleks' juga tak konsisten (clue > 15 menit vs dialog k3 > 10 menit). igd_asma_berat: ipratropium TAK MUNCUL sbg satu pun opsi pilihan (hanya salbutamol) walau disebut di clue. igd_hipoglikemia: D40% bolus tanpa gram/mL spesifik — confirmed (tapi recheck GDS SEBENARNYA ada di narasi h2, hanya bukan keputusan yang diskor). igd_dengue_syok: demografi usiaMax 25 tapi spesialisRujukan tetap 'anak' — pasien 19-25 th seharusnya penyakit dalam. ispa_common_cold (kasusInfeksi.ts:113) saya baca langsung: obatBenar= ['paracetamol_500','ctm_4','ambroxol_30'] wajib AND ketiganya walau presentasi kasus tak eksplisit sebut demam/batuk — mendukung Temuan #10 sekaligus.

Temuan #7 — Prolanis: GDS<200 'terkontrol', DBP=0,62×SBP, rujukan diblokir DIKONFIRMASI

kegiatan.ts:137 persis `const terkontrol = p.jenis === 'ht' ? p.param < 140 : p.param < 200` — GDS<200 dianggap terkontrol tanpa syarat lain (HbA1c/pola makan diabaikan). Baris 143: `Math.round(p.param \* 0.62)` — DBP MEMANG rumus tetap 62% dari SBP, bukan data independen. Untuk HT tak-terkontrol, opsi 'Langsung rujuk ke spesialis' SELALU benar:false tanpa syarat nilai (tak ada cabang utk TD sangat tinggi) — rujukan terblokir tanpa melihat besaran drift, persis klaim CODEX.

Temuan #8 & UKM Santoso — Alur TB + kontak anak tak bisa dipilih bersama DIKONFIRMASI

tb_paru hanya py lab bta_sputum (sudah dicatat di Temuan #6). Keluarga Santoso (desaA.ts): kartu intervensi sk1_i4 'Skrining Kontak Serumah' (baris 1112-1122, memeriksa Bagas anak bergejala terpisah dari sk1_i1 (kartu 'benar' utk hambatan motivasi Pak Santoso). Mesin kunjungan.ts:213-221 (PILIH_INTERVENSI) mengonfirmasi single-select: memilih SATU kartu langsung set fase:'selesai' — memilih skrining Bagas MENUTUP kunjungan tanpa bisa sekaligus memilih

pemulihan motivasi bapak. Keduanya memang terbukti mutually exclusive by design, bukan cuma persepsi CODEX.

Temuan #9 & UKM Dewi/Karsa — Otonomi perempuan digantung izin suami

DIKONFIRMASI

desaF.ts:995 (Karsa/Painah) PALING TEGAS: kartu intervensi 'benar' eksplisit berbunyi 'Tablet tambah darah Bu Painah diresepkan ulang LEWAT persetujuan Pak Karsa' — mengikat resep suplemen zat besi (bukan tindakan berisiko) pada izin suami, dikonfirmasi verbatim. desaB.ts:1499 (Dewi/Hendra): resolusi 'sukses' arc dinarasikan via kutipan keputusan suami ('kata Mas Hendra... keputusan dia sendiri'), Bu Dewi jadi penyampai pesan; opsi dialog yang menegaskan hak Bu Dewi sendiri secara langsung justru diberi efekTrust -2/tepat:false — walau ini scr teknik MI (hindari konfrontasi) memang wajar, TAK ADA jalur sukses yang tak melalui persetujuan suami.

Sitasi Permenkes 2/2025 (dikutip utk isu otonomi KB/Fe)

tak-jelas

Permenkes 2/2025 (Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi) TERKONFIRMASI NYATA ADA. Tapi klausul persetujuan pasangan/suami di dalamnya (Pasal 62) SPESIFIK utk tindakan ABORSI kedaruratan medis — bukan aturan umum 'KB/pemberian obat butuh izin suami'. Sitasi CODEX benar bahwa regulasinya nyata, tapi penerapannya ke skenario KB/Fe di atas agak dipaksakan/di luar cakupan pasal tsb. Mungkin ada regulasi lain (mis. UU Kesehatan 17/2023 soal hak reproduksi) yang lebih tepat — perlu dicek terpisah.

Temuan #10 — Terapi kondisional dipaksa AND + sitasi NICE/AAO-HNS

DIKONFIRMASI

clinic.ts (~494-496): totalSlot = obatBenar.length + grupAlternatif.length + prosedurBenar.length — mengonfirmasi obatBenar (array polos) dinilai AND wajib semua. ispa_common_cold (kasusInfeksi.ts:113) dikonfirmasi langsung: 3 obat wajib AND (parasetamol+CTM+ambroksol) walau kasus tak eksplisit py demam/batuk. NICE NG120 (asli, dikonfirmasi via nice.org.uk, meski publikasi asli 2019 bukan 2026) mendukung prinsip 'jangan rutin antibiotik', konsisten arah kritik CODEX. AAO-HNS BPPV (asli, dikonfirmasi via entnet.org, update 2017): guideline JUSTRU merekomendasikan MELAWAN penggunaan rutin betahistin/vestibular-suppressant — mendukung (bahkan memperkuat) klaim CODEX bahwa mewajibkan betahistin+Epley sbg AND bertentangan guideline.

Temuan #11 — Kesalahan kode/pemeriksaan (Widal/GAS/K29.7/DRE)

tak-jelas

Bagian I16.0 sudah dikonfirmasi terpisah di Temuan #3. CDC GAS guidance (asli, dikonfirmasi via cdc.gov): throat culture/RADT memang standar diagnosis — mendukung ARAH klaim bahwa label 'streptokokus' tanpa RADT/kultur tak sesuai guideline. TAPI saya belum sempat membaca kode kasus faringitis_akut, Widal,

K29.7-vs-K30, atau UI region 'ekstremitas' utk DRE secara langsung karena keterbatasan waktu — bagian ini BELUM diverifikasi independen di level kode, jangan diterima penuh tanpa ronde tambahan.

Temuan #12 — Ajaran salah/kontradiktif (zoster/gout/apendisitis)

tak-jelas

Sitasi terverifikasi asli & relevan: Cochrane review antiviral zoster (asli, dikonfirmasi) — bukti kualitas tinggi bahwa asiklovir TIDAK mengurangi insiden PHN; jika clue game mengklaim sebaliknya itu bertentangan langsung. NICE NG219 & ACR 2020 gout (keduanya asli, dikonfirmasi) — SEKARANG justru mendukung ULT boleh dimulai bersamaan flare (dengan profilaksis anti-inflamasi), bukan harus menunggu — jika clue game melarang tanpa nuansa ini, itu ajaran usang. TAPI saya BELUM membaca baris kode spesifik kulit_herpes_zoster / mm_gout_arthritis_akut secara langsung untuk konfirmasi teks persis di case — sitasi terverifikasi, penerapan ke kode belum.

Temuan #13 — Distraktor kasusInfeksi.ts tak ditandai field

DIKONFIRMASI

kasusInfeksi.ts baris 8-10 punya KOMENTAR eksplisit mengakui 'tipe PertanyaanAnamnesis belum memiliki field distraktor' — padahal types.ts SUDAH punya field distraktor?:boolean yang dipakai aktif di file lain (kasusMetabolikMsk.ts, kasusKiaJiwa.ts). 7 pertanyaan pengecoh di kasusInfeksi.ts (baris 93,205,442,560,675,790,899) HANYA ditandai komentar, TANPA field asli. clinic.ts:421-427 mengonfirmasi dampak nyata: distraktor:true seharusnya kena penalti -5/pertanyaan pada skorAnamnesis — karena field tak ada, ketujuh pertanyaan itu BISA ditanya TANPA penalti sama sekali. Confirmed penuh dengan mekanisme presisi, bahkan lebih spesifik dari yang CODEX sebutkan.

Temuan #14 — Konsekuensi tak ikuti penyebab edukasi

tak-jelas

BELUM diverifikasi — karena keterbatasan waktu saya tidak sempat membaca reducer.ts baris ~352 secara langsung untuk klaim ini (kegagalan edukasi tak menentukan konsekuensi; konsekuensi hari-0 baru diproses saat HARI_BARU). Jangan anggap confirmed hanya dari laporan CODEX; perlu ronde verifikasi tersendiri.

UKM — Keluarga Yani: mismatch usia pada karma (temuan independen)

DIKONFIRMASI

CODEX menandai Yani sbg 'temuan pasti' tanpa merinci lokasi/isu spesifik di laporan. Setelah membaca penuh (desaD.ts:628-954), saya temukan bug independen: karma kunjungan-1 (baris 944-953) memetakan Nayla (bayi 3 BULAN, kondisi 'bayi_3_bulan') ke kasusId 'diare_akut_anak' — padahal kasus itu (kasusInfeksi.ts:491) demografinya usiaMin:3, usiaMax:5 DALAM TAHUN (anak prasekolah, vital sign & konteks dialog sesuai anak besar, bukan bayi). Bayi 3 bulan

dengan dehidrasi berat (mata cekung, tanpa air mata, popok kering sejak subuh) adalah kegawatan usia sangat berbeda (tatalaksana IMCI jauh lebih ketat) dari kasus yang dipakai — sejenis dengan bug 'mismatch usia Dimas' yang sudah diketahui di dossier (keluarga Gunawan).

UKM — Wulan, Marni, Endah (perlu adjudikasi CODEX) tak-jelas

Ketiganya saya baca detail. Wulan (desaA.ts, hipertensi→stroke karma baris 412-420): konsisten usia/indeks anggota dengan stroke_iskemik (isu stroke sendiri sudah dicatat generik di Temuan #3, tak ada bug BARU khusus Wulan). Marni (desaE.ts, DM+JKN nonaktif, GDS 270): narasi konsisten, tak ada bug case-local baru selain isu generik Prolanis (Temuan #7). Endah (desaF.ts, TB142cm+panggul sempit): TB<145cm sebagai faktor risiko CPD secara klinis wajar (didukung literatur obstetri umum), tak ditemukan cacat medis jelas dalam bacaan saya. Kesimpulan: ketiga keluarga ini TIDAK menunjukkan bug case-local baru yang saya temukan — wajar CODEX menaruh mereka di kategori 'perlu adjudikasi', bukan 'pasti'.

UKM — Istilah BGM disalahgunakan di Posyandu DIKONFIRMASI

kegiatan.ts:24-36 (posy_timbang): skenario anak turun BB 9,1→8,7kg dengan 'titik turun memotong SATU pita warna' (bisa hijau→kuning, belum tentu capai merah) — tapi jawaban benar melabelinya eksplisit sebagai '(BGM)' di baris 32. BGM ('Bawah Garis Merah') secara definisi teknis KMS Indonesia = titik di BAWAH garis merah (kategori gizi kurang/buruk terparah), BUKAN istilah generik untuk 'berat turun potong satu pita apa saja'. Confirmed penyalahgunaan istilah, meski nasihat klinisnya sendiri (jangan tunda, cari sebab) tetap benar.

UKM — KLB konjungtivitis disamakan skabies (obati semua kontak) DIKONFIRMASI

kegiatan.ts:242 (polaDariKasus) & 253-254: baik 'skabies' MAUPUN 'konjungtivitis_bakterial' sama-sama dipetakan ke pola sama persis 'kontak', dengan jawaban benar tunggal 'Obati kasus + SEMUA kontak serumah SERENTAK'. Ini secara klinis TEPAT untuk skabies (tungau bisa asimtomatik, perlu obati serentak cegah ping-pong), TAPI TIDAK TEPAT untuk konjungtivitis bakterial (kontak asimtomatik TIDAK perlu antibiotik profilaksis rutin; kontrol wabah yang benar = higiene tangan + isolasi kasus simtomatik). Bahkan komentar kode sendiri (M10 §49) menunjukkan ini perbaikan yang TIDAK SENGAJA menyeret konjungtivitis ikut pola skabies saat memperbaiki masalah lain.

UKM — Morbili tak masuk mesin surveilans KLB DIKONFIRMASI

surveilans.ts:24-33 (AMBANG_CLUSTER) hanya berisi 8 kasusId: dengue_df, demam_tifoid, tb_paru, pneumonia_balita, diare_akut_anak, skabies, konjungtivitis_bakterial, ispa_common_cold. Case id 'kulit_morbili'

(kasusKulit.ts:1083) TIDAK ADA di tabel ini — kasus campak yang didiagnosis di poli TIDAK PERNAH memicu deteksi kluster/wabah, walau campak penyakit wajib lapor & sangat menular yang semestinya prioritas SKDR. Confirmed gap nyata.

UKM — Ketut: jadwal imunisasi lama + timeline catch-up DIKONFIRMASI

desaA.ts:1614 menyebut daftar imunisasi 'hepatitis B, BCG, polio, DPT-HB-Hib, campak' — TIDAK menyebut PCV, Rotavirus, IPV yang SEKARANG (2022-2024) bagian program imunisasi dasar LENGKAP wajib nasional (dikonfirmasi via pencarian web), dan istilah 'campak' sendiri sudah diganti 'Campak-Rubella (MR)' secara nasional. Konsisten klaim CODEX 'jadwal lama'. Untuk klaim 'timeline catch-up mustahil': saya baca alur (baris 1949-2179) — dosis DPT-HB-Hib 'ada tiga', polio 'ada empat', campak dijadwalkan bulan ke-9 (TEPAT sesuai standar), dan penutup arc menyebut 'terisi satu per satu sampai tuntas campak di bulan kesembilan' yang tersirat berjarak wajar antar kunjungan — saya TIDAK menemukan bukti jelas timeline 'mustahil' dari teks yang saya baca. Bagian 'jadwal lama' confirmed kuat; bagian 'timeline mustahil' rendah keyakinan/tidak terverifikasi.

Cakupan tabel 67-kasus (tidak diverifikasi menyeluruh) tak-jelas

Karena keterbatasan waktu, saya hanya memverifikasi mendalam kasus-kasus yang disitir eksplisit di 14 Temuan Mendesak + 5 IGD (stroke_iskemik, dm_tipe2, hipertensi_esensial, diare_akut_anak, tb_paru, anemia_defisiensi_bumil, kia_anc_kehamilan_normal, mm_hipertensi_urgensi, ispa_common_cold, ke-5 IGD) — SEMUA cocok dengan label CODEX ('!' = cacat terbukti). Sisa entri tabel (terutama yang ditandai '✓' atau '?') BELUM saya periksa baris-per-baris. Sampel yang saya cek punya tingkat akurasi sangat tinggi, tapi jangan terima 100% tabel tanpa spot-check tambahan bila akan dipakai untuk keputusan implementasi rinci.

IGD (5 kasus)

Kelima kasus IGD yang disebut CODEX — seluruhnya terkonfirmasi. Di luar cakupan riset M11.

igd_syok_anafilaksis (steroid rutin diwajibkan) DIKONFIRMASI

src/content/igd.ts langkah 'a3' (baris 43-50): hanya 2 pilihan tersedia — (a) 'antihistamin + kortikosteroid sebagai terapi tambahan' = SATU-SATUNYA jawaban benar:true, atau (b) pulangkan langsung = salah. Tidak ada jalur 'benar' tanpa steroid. Teks respons game sendiri (baris 47) mengakui 'bukti pencegah reaksi bifasik LEMAH — Resus Council UK/AAAAI' namun tetap mewajibkan memilih steroid untuk kredit penuh — kontradiksi antara narasi hedging game dan

mekanik skoringnya. Diverifikasi via WebSearch: Resuscitation Council UK (update ALS 2021, resus.org.uk/library/additional-guidance/guidance-anaphylaxis) menyatakan steroid 'no longer recommended for routine treatment of anaphylaxis' dan antihistamin 'not recommended for treatment of Airway/Breathing/Circulation problems' — sitasi RCUK yang disebut CODEX itu NYATA dan isinya cocok. Klaim CODEX dikonfirmasi.

igd_kejang_demam (timeline mundur, batas 10/15 menit) DIKONFIRMASI

Dua cacat terpisah ditemukan di src/content/igd.ts. (1) Timeline mundur: pembuka (baris 62) — ibu bilang kejang 'sudah lebih dari sepuluh menit' SEBELUM tindakan pertama pemain, tapi langkah 'k2' (baris 81) menyatakan 'kini menit ke-7' pada episode kejang yang SAMA (kontinu, belum berhenti) — waktu mundur dari >10 menit ke menit-7. (2) Ambang kompleks tidak konsisten secara internal: 'clue' (baris 69) menyebut kejang demam kompleks = '>15 menit/fokal/berulang', tapi respons jawaban benar di 'k3' (baris 92) menyebut kriteria '...+ durasi >10 menit'. Diverifikasi via WebSearch (konsensus IDAI, idai.or.id/wp-content/uploads/2013/02/Kejang-Demam-Neurology-2012.pdf dan sumber jurnal lain): definisi resmi kejang demam kompleks memakai ambang durasi >15 MENIT, bukan >10 menit — jadi teks 'k3' itu sendiri faktual keliru terlepas dari inkonsistensi internalnya. Klaim CODEX dikonfirmasi penuh.

igd_asma_berat (ipratropium hilang dari pilihan) DIKONFIRMASI

Ipratropium hanya disebut sepintas dalam teks 'clue' bantuan ('± ipratropium', baris 113) tapi TIDAK PERNAH muncul sebagai opsi pilihan aktual di langkah s1/s2/s3 (baris 116-140) — semua pilihan hanya 'nebulisasi salbutamol' saja atau steroid; tidak ada opsi kombinasi SABA+ipratropium yang bisa dipilih pemain. Diverifikasi via WebSearch: GINA 2026 (ginasthma.org/2026-gina-strategy-report/ — laporan ini NYATA ada, bukan halusinasi) merekomendasikan penambahan ipratropium ke nebul salbutamol pada serangan asma berat/mengancam jiwa — persis profil kasus ini (SpO2 89%, RR 32, otot bantu napas menegang = kriteria berat GINA). Jadi kekosongan opsi ini adalah gap konten aktual, bukan sekadar redaksional clue. Klaim CODEX dikonfirmasi.

igd_hipoglikemia (D40 tanpa gram/volume/recheck eksplisit) DIKONFIRMASI

Pilihan jawaban benar 'h1' (baris 166) berbunyi 'Pasang infus, beri dekstrosa 40% IV bolus' — TIDAK ADA gram atau volume (mL) tersurat di opsi maupun di teks 'clue' (baris 160). Klaim 'tanpa gram/volume' akurat. Klaim 'tanpa recheck' perlu nuansa: recheck GDS SEBENARNYA muncul — narasi awal langkah 'h2' (baris 173) langsung menyatakan 'GDS ulang 95 mg/dL' sebagai fakta yang sudah terjadi, TAPI ini disajikan pasif/otomatis dalam narasi, bukan sebagai tindakan yang harus dipilih/diperintahkan pemain secara eksplisit. Jadi status: dosis eksplisit memang

hilang (dikonfirmasi); recheck ada tapi implisit-naratif, bukan sepenuhnya 'hilang' seperti tersirat CODEX — perlu sedikit koreksi presisi klaim.

igd_dengue_syok (laju cairan & kriteria rujukan usia salah) DIKONFIRMASI

Dua bagian. (a) Laju cairan: 'clue' (baris 204) menyebut 'bolus 10-20 mL/kg' — nilai ini SESUAI rentang WHO untuk resusitasi DSS established (diverifikasi via WebSearch: WHO/CDC — bolus 20 mL/kg diinfus 15-30 menit untuk syok hipotensif, atau 10-20 mL/kg untuk DSS established) NAMUN game tidak pernah menyebut komponen WAKTU/laju infus (berapa menit) — jadi lebih tepat disebut 'tidak lengkap' daripada 'salah'; angka volumenya sendiri benar, komponen laju/durasi yang hilang. (b) Kriteria rujukan usia: DIKONFIRMASI PENUH via kode, ini bug nyata bukan cuma isu naratif. src/content/igd.ts baris 199: demografi usiaMin:8, usiaMax:25; baris 203: spesialisRujukan:'anak' adalah FIELD STATIS per-kasus. src/engine/igd.ts baris 19 (fungsi buatIgd): usia pasien di-randomize `rng.int(usiaMin, usiaMax)` tiap playthrough. src/renderer/src/screens/Igd.tsx baris 138-144: rujukan RS dipilih memakai `kasus.spesialisRujukan` (field statis), BUKAN usia hasil roll — sehingga pasien yang ter-roll usia 24-25 tahun (dewasa muda) tetap SELALU dirujuk ke RS berspesialisasi 'anak', tidak pernah ke penyakit dalam/interna meski usianya dewasa. Klaim CODEX dikonfirmasi via jejak kode lintas 3 file.

4 kasus tanpa kandidat pengayaan M11

Agen penilai menyimpulkan kasus ini tak punya jebakan EBM/jurang realita yang cukup kuat utk diusulkan.

- mata_hordeolum — Hordeolum (Bintitan)
- mm_gout_arthritis_akut — Arthritis Gout Akut - sudah ditanam manual di Fase-1 (dossier sesi 55)
- saraf_tension_headache — Nyeri Kepala Tipe Tegang
- tht_serumen_prop — Serumen Prop

Dokumen terpadu, menggabungkan dua workflow multi-agen (2026-07-10): m11-pengayaan-riset (7 finder + verifikasi web per-kandidat) dan codex-ronde-verifikasi (23 agen memverifikasi laporan CODEX thd kode aktual commit 6e1b2bcc). Menggantikan dua dokumen terpisah sebelumnya utk memudahkan pembacaan. Centang "ditinjau" tersimpan di peramban ini saja.